

1. 적취

01

명칭과 병인병리

① 적취의 여러 명칭

- 積聚(적취) = 癥瘕^{경하} 痞塊^{비괴} 癥塊^{징괴} 癖塊^{벽괴} 癥瘕^{현벽}
- 腹內積塊 或脹或痛(복내적괴 혹창혹통): 뱃속에 덩어리가 뭉쳐서 혹 붓거나 혹 아픈 병증

💬 **한의학의 병리 용어** - 모두 막혀 기혈의 순환이 잘 되지 않아 생긴 것들

- ① 不通 不利 不營 不順(순조롭지 X), 不暢
- ② 不行 不調 不節 不健 不振 橫逆
- ③ 搏結 相搏 失和 不和 留戀 失常 偏勝
- ④ 不足 不充 虧損 虛衰 衰竭 虛弱 無力 衰微
- ⑤ 積滯 蘊閉 祕窒 ⑥ 瘀淤 鬱結 阻留 ⑦ 壅凝 塞遏 澀 ⑧ 逆痹 痞乘 乖亂

2. 병인병리

- ① 情志所傷(정지소상) ② 飲食所傷(음식소상) ③ 感受寒濕(風寒) ④ 他病轉歸(타병전귀)

↳ 주로 肝脾 兩臟과 관련됨

↳ 📌 주된 병기: 氣滯 血瘀 痰結 毒蘊^{독은}

1) 情志所傷 정지소상

- 積: 氣機阻滯 → 血行不暢 → 脈絡瘀滯
- 聚: 情志所傷 → 肝氣鬱結^{간기억결} → 臟腑失和 → 氣機阻滯 → 氣滯不行

2) 飲食所傷 음식소상

- 음식을 먹는 시간이 일정하지 않으며 골고루 잘 먹지 못하는 것에 감정적인 스트레스적 변화가 서로 엉켜서 기의 순환이 정체되어 담, 혈행장애 등이 생기게 됨

聚	飲食不調, 因食遇氣 → 食氣交阻 → 氣機不暢 → 聚而不行
聚	酒食不節 → 損傷脾胃 → 運化不健, 聚濕生痰 → 痰阻氣滯 → 氣機不暢
積	痰阻氣滯 → 痰濁與氣血相搏結, 瘀阻脈絡

💬 **담 생성과 관련된 장기: 폐, 비, 위, 신**

- ① 담이 생기면 기혈과 관련되어 문제 일으킴
- ② 비: 담을 생성하는 장기
- ③ 위: 담음이 모이는 곳이라고도 함
- ④ 신장: 담을 생성하는 요인이 된다고 보기도 함

3) 感受寒濕(風寒) 감수한습(풍한) - 외적 기후 영향

聚	寒濕侵襲 → 內傷于脾, 脾陽不振 → 濕痰內聚 → 阻滯氣機 → 滯而不暢
	한습이 침입하면 비양이 부진함 → 비주운화이므로 습담이 쌓이고 기기가 막혀 취가 생김
積	阻滯氣機 → 血行瘀滯 기기가 막히면 혈행도 막힘
聚	外感風寒, 內傷飲食 → 脾失健運 → 濕濁不化, 凝聚成痰 → 痰阻氣滯 → 聚而不行
積	痰阻氣滯 → 瘀血留滯, 脈絡壅塞
聚	外感風寒, 內傷七情 → 氣因寒逆 → 壅遏不暢 → 氣滯不行
積	壅遏不暢 → 陰血凝聚, 壅塞脈絡

4) 他病轉歸 타병전귀

積	黃疸病後, 或 黃疸經久不退 → 濕邪留戀 → 阻滯氣機 → 氣滯血瘀
	或 久瘡不愈 → 濕痰凝聚 → 脈絡痺阻 → 血行不暢
	或 感染血吸蟲, 日久不愈 → 肝脾氣血不暢 → 血絡瘀滯

[결론] 기혈 순환을 방해하는 요인들에 의해 “積”이 생성됨!

📌 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은? 99 02

적취의 원인은 주로 情志抑鬱, 走食內傷, 邪毒侵襲과 관련이 있다.

발생은 주로 肝, 脾 兩臟과 관련이 있고, (기체), (혈어), (담결), (독은) 이 적취를 형성하는 주된 병기이다.

💬 각종 병인의 상호작용 🍵 - 한가지에 의해서 생기는 것이 아님

《금궤익》 🍵	積聚之病，非獨痰食氣血，即風寒外感，亦能成之，然痰食氣血非得風寒，未必成積，風寒之邪，不遇痰食氣血，亦未必成積
《서촉》 🍵	積聚癥瘕痞，因寒而痰與血食凝結病也
《금궤익》 🍵	憂怒傷其內，風寒襲于外，氣逆血寒，凝結成積
《금궤익》 🍵	정신, 음식, 외감과 관련된 것들이 상호작용해서 積이 형성된다

💬 적취의 형성과 정기의 강약 🍵

동의보감 🍵	壯人無積，虛人則有之，皆由脾胃怯弱，氣血兩衰，四時有感，皆能成積
의종필독 🍵	積之成也，正氣不足，而後邪氣踞之
내경	積이 성하다는 것은 정기가 부족한 이후 사기가 머무는 것이다.
내경	정기가 체내에 존재하고 있으면 사기가 감히 간섭하지 못한다.

02 감별진단

① 비만(痞滿)	• 內覺痞悶，外無脹急. 氣聚脹急이나 堅積包塊는 없음
② 석가(石瘕)	• 답답하지만 육안상 창대, 팽팽한 것은 안 보임 자각증상
③ 고창(鼓脹)	부인과 질병 (적취는 내과질병)
④ 분돈기(奔豚氣)	按之如鼓，水液停聚: 수액의 유무로 구별 (=복수가 차는 것)

03 적증과 취증의 구별

1. 적증 🍵 - 실제적 덩어리 有

증후 특징	觸之有形，固定不移，痛有定處: 만지면 덩어리 O, 고정되어 안 움직임, 통처 있음
병위	病在血分，多爲臟病: 혈분, 장병
병기	氣滯血瘀，互結成塊，正氣日損: 기체혈어하여 뭉쳐서 괴가 형성, 정기는 날로 손상됨
병정	病程較長，病情較重: 비교적 길고 중함
치법	活血에 중점 (重在活血)
예후	治療得當，積漸可消，失治誤治，終致不愈 : 조기 진단이 중요하며 치료 시기를 못 지키는 것은 나쁨 (제때 치료 안하면 심해짐)

2. 취증 🍵 - 실제적 덩어리 無

증후 특징	觸之無形，聚散無常，痛無定處 : 만지면 형태 없이 모였다가 흩어졌다 함, 통증도 일정한 곳 없이 돌아다님
병위	病在氣分，多爲腑病: 기분, 부병
병기	氣結不行，或兼痰食停滯，正氣未傷 : 기가 뭉쳐서 행하지 않음, 혹은 담이나 식적이 정체됨, 정기는 아직 상하지 않음
병정	病程較短，病情較輕: 비교적 짧고 가벼움
치법	調氣에 중점
예후	治療及時，聚可向愈，失治誤治，病趨于甚

🍵 괄호 안에 들어갈 말은? 17

《잡병원류서촉》積聚癥瘕痞，因()而痰與血食凝結病也
① 풍 ② **한** ③ 서 ④ 습 ⑤ 화

🍵 담, 식, 기, 혈은 ()를 만나지 않으면 결코 적을 형성할 수 없다.

이것은? 18 19
① **풍한** ② 한습 ③ 풍열 ④ 조열
⑤ 조열

🍵 괄호 안에 들어갈 말은? 07 09

《東醫寶鑑》壯人無(積)，虛人則有之，皆由脾胃怯弱，氣血兩衰，四時有感，皆能成(積).

🍵 괄호 안에 들어갈 말은? 05 07 09

《醫宗必讀》積之成也，(正氣)不足，而後(邪氣)踞之.

🍵 積證에 대해 옳은 것은? 11

가. 觸之有形 固定不移
나. 病在血分 多爲臟病
다. 治法 : 重在活血
라. 痛無定處 病程較短

① **가나다** ② 가다 ③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

🍵 積證에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은? 17

① 증후 특징: 觸之無形，聚散無常，痛無定處
② 병위: 病在氣分，多爲腑病
③ 병정: 病程較短，病情較輕
④ **병기: 氣滯血瘀，互結成塊，正氣日損**
⑤ 치법: 調氣에 중점을 둔다.

04

적괴의 부위와 증상

	병변부위	증상
右脇腹	肝	脇肋刺痛, 황달, 納呆, 복창
左脇腹	肝脾	患處脹痛, 疲乏無力, 출혈
脘腹	胃	반위, 구토, 토혈, 변혈
右腹	腸	설사 또는 변비, 消瘦乏力
左腹	腸(상행/하행결장)	대변횡수 증가, 농혈변

急則治其標

- ① 토혈, 변혈: 血熱妄行, 氣不攝血, 瘀血內積 → 열, 허약, 어혈
- 빈도: 열로 인한 출혈(혈열망행) >> 허(비허불통, 비불섭혈)로 인한 출혈
 - 노상: 타박상, 체내 어혈이 생겨 나타나는 출혈
- ② 극렬한 구토: 胃失和降, 胃氣上逆 기를 아래로 내리는 약 사용
- 위기는 아래로 하행해야 위의 기능이 유지 → but 상역하면 트림, 구토, 딸국질 등이 나타남
 - 폐조속강 (폐는 선발, 속강을 모두 함) → 폐기가 상역하면 천식, 기침 발생
 - 모두 위기를 하강시키는 약을 써서 치료
- ③ 황달: 肝膽鬱滯, 膽汁外溢

05

적취의 치료원칙

[치료원칙] 理氣散結, 化瘀軟堅

聚證의 치료원칙은? 99 12 13 15

- ┐ 積證: 病在血分하므로 活血化瘀, 軟堅散結을 기본 법칙으로 하되 活血에 중점
- └ 聚證: 病在氣分하므로 疏肝理氣, 行氣消聚를 기본 법칙으로 하되 調氣에 중점

06

적증의 초중말 3기 분치법

分期	적괴 특징	병세	치법
초기	적괴의 형태가 작고 부드러우며 단단하지 않음	사기: 淺 정기: 强	行氣化瘀 通絡消積
중기	적괴가 더 커지고 누르면 단단함	사기: 較深 정기: 已傷	祛瘀軟堅 補益脾胃
말기	적괴가 뚜렷해지며 누르면 단단함	사기: 已深 정기: 大傷	大補氣血 活血化瘀

07

적취 치료 시 주의사항

- ① 治實當顧其虛: 실증을 치료하더라도 마땅히 허한 것을 보해야 함
- ② 補虛勿忘其實: 보허에 치중해서 실증을 잊어서는 안 됨
- ③ 《소문》大積大聚, 其可犯也, 衰其大半而止.
: 큰 적이나 취를 치려고 할 때에는 대반(7/10)이 쇠해지면 약을 쓰지 않고 그침
- ④ 《증치준승》大毒治病, 十去其五, 小毒治病, 十去其七, 不得過也.
: 대독(독성이 강한 약)으로 병을 치료할 때에는 50% 정도 줄어든 때까지만 쓰고
소독으로 병을 치료할 때에는 70% 정도 줄어든 때까지 쓰고 약을 과용해서는 안 됨
- ⑤ 《보감》治積聚, 有化積消積揆積磨積, 而無下積之說, 蓋不可直便取下, 以傷胃氣也.
: 적취를 치료할 때에는 화적, 소적, 애적, 마적(천천히 없애는 방법들)의 방법을 써야지 한번에 積을 쏟아내어 없애는 방법(하적)은 없다. 위기만 손상시킬 뿐이다.

㉞ 積塊의 부위와 증상을 기한 것이다. 괄호 안을 채우시오. 07

- 1) 右脇腹之積
: 病在(肝), 脇肋刺痛, 황달, 納呆, 복창
- 2) 左脇腹之積
: 病在(肝脾), 患處脹痛, 疲乏無力, 출혈
- 3) 脘腹之積
: 病在(胃), 반위, 구토, 嘔血, 변혈
- 4) 右腹之積
: 病在腸. 설사 또는 변비, 消瘦乏力
- 5) 左腹之積
: 病在(腸), 대변 횡수 증가, 농혈변

㉞ 취의 초중말기에 따른 적괴의 특징과 병세, 치법을 쓰시오. 02 10 13 14

㉞ 적취의 초기, 중기, 말기에 따른 치법 중에 중기에 적합한 치법은? 11 12

- ① 行氣化瘀 通絡消積
② 通絡消積 活血化瘀
③ 祛瘀軟堅 補益脾胃
④ 大補氣血 補益脾胃
⑤ 大補氣血 活血化瘀

㉞ 적증의 중기 치법은? 18

- ① 창통이 있지만 정황상 양호하다.
② 면색이 위황하고 흑색이다.
③ 덩어리 모양이 작고 만지면 부드럽다.
④ 덩어리 모양이 작고 누르면 부드럽다.
⑤ 경기가 손상되어 있고, 사기가 심하다.

㉞ 적증은 초중말 3기로 나뉜다. 중기는? 19

- ① 창통이 있지만 정황상 양호하다.
② 식사량이 크게 감소한다
③ 얼굴색이 위황 또는 黧黑이다.
④ 덩어리 모양이 작고 누르면 부드럽다.
⑤ 경기가 손상되어 있고, 사기가 심하다.

㉞ 적증 말기의 치법은? 18

- ① 소간이기, 행기소결
② 거어연견, 보익비위
③ 행기화어, 통락소적
④ 대보기혈, 활혈화어
⑤ 이기산결, 통보검시

㉞ 적취의 올바른 치법이 아닌 것은? 03 19

- ① 化積 ② 消積 ③ 揆積 ④ 磨積
⑤ 下積

㉞ 積聚의 치법에 있어 無下積의 이유는? 07

- ① 積自消 ② 補脾胃 ③ 扶正祛邪
④ 他病轉歸 ⑤ 傷胃氣

㉞ 적취의 치법으로 옳은 것은? 11

- 가) 화적 나) 소적 다) 애적 라) 마적
① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라 ⑤ 가나다라

㉞ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은? 08 12

治積聚, 有化積消積揆積磨積, 而無(下積)之說.

㉞ 적취를 치료할 때 위기가 상하므로

주의하거나 금해야 하는 치료는? 17

- ① 하적 ② 화적 ③ 소적 ④ 애적 ⑤ 마적

08

변증시치

☞ 적응의 변증시치 4가지를 기하시오 07 09

ㄱ 적응: ① 氣滯血阻 기체혈조 ② 氣結血瘀 기결혈어 ③ 正虛瘀結 정허어결

ㄴ 취증: ① 肝氣鬱滯 간기울결 ② 食滯痰阻 식체담조

1. 적응

1) 氣滯血阻 기체혈조 ☞ 19 탈기

증상	脹痛并見, 固着不移, 積塊軟而不堅, 舌質青, 或瘀斑, 脈弦
치법	行氣化瘀, 通絡消積
처방	금령자산 + 실소산
🔑 금령자산(金鈴子散) = 玄金散 • 구성: 금령자(=川楝子), 현호색 40g • 설명: 舒肝瀉熱, 理氣止痛 - 금령자(疏肝理氣), 현호색(활혈지통) • 적용: 治熱厥心痛, 治肝氣鬱滯化火, 胃脘胸脇疼痛, 疝氣疼痛, 經行腹痛	
🔑 실소산(失笑散) = 斷弓弦散 • 구성: 오령지, 포황 등분 • 설명: 활혈화어, 산결지통 • 적용: 治產後兒枕痛, 臍腹疼痛, 治瘀血內阻, 月經不調, 小腹急痛, 惡露不行 - 흥부의 심통에 쓸 수 있는 대표적 응급약 + 협심증, 심근경색 진통제로 씀	

2) 氣結血瘀 기결혈어 = 積之中期

증상	積塊明顯增大, 硬痛不移, 消瘦乏力, 納差, 時有寒熱, 女子或月事不下, 面暗, 舌邊暗或質紫, 或瘀斑, 脈細澀 : 적괴가 뚜렷하고 단단해짐, 증대, 마르고 힘 없음, 얼굴이 거무칙칙, 어반 → 어혈의 증상 이 더 심해짐
치법	祛瘀軟堅, 補益脾胃
처방	격하죽어탕 또는 별갑전환 + 육군자탕
🔑 별갑전환(鰐甲煎丸) • 구성: 별갑(炙) 4.4g, 사간(炒), 황금, 鼠婦, 계지, 건강, 석위, 후박, 紫葳, 아교 1.2g, 시호, 蜣螂(炒) 2.4g, 작약, 목단피, 蟪蟲(炒) 2g, 정력자(炒), 반하, 인삼 0.4g, 구맥, 도인 0.8g, 赤硝 4.6g, 노봉방(炙) 1.6g • 설명: 行氣, 活血, 祛瘀, 利水, 扶正 • 적용: 治瘰癧, 瘡 疾日久不愈, 脇下痞 硬有塊, 治積塊大而堅硬作痛	

3) 正虛瘀結 정허어결 = 積之末期(말기)

증상	積塊堅硬, 疼痛加劇, 飲食大減, 面色萎黃, 消瘦脫形, 舌質淡紫無苔, 脈細數或弦細 : 적괴가 단단하고 동통이 심해지고 수척해서 뼈만 앙상히 남음, 설태는 없어짐
치법	大補氣血(기혈이 부족하기 때문에), 活血化瘀
처방	팔진탕 + 화적환 (팔진탕: 사군자탕 + 사물탕 → 대보기혈)
🔑 화적환(化積丸) • 구성: 삼릉, 봉출, 아귀, 해부석, 향부자, 옹황, 빈랑, 소목, 와능자, 오령지 • 설명 ① 삼릉, 아출, 아귀, 소목, 오령지: 活血化瘀 ② 향부자, 빈랑: 疏肝理氣 ③ 해부석, 와능자: 軟堅消瘀 ④ 옹황: 解毒殺蟲 • 적용: 通治諸積	
🔑 팔진항암단(八珍抗癌丹) • 구성: 백화사설초 3돈, 인삼, 백복령, 생지황, 별갑, 천산갑 1돈 반, 백출, 당귀, 적작약, 삼릉, 봉출, 향부자, 유향, 천궁, 감초 1돈 • 설명: 扶正祛邪 처방, 健脾益氣, 活血祛瘀, 軟堅消積	

☞ 적응 환자. 복통과 창만이 있으며 적괴가 만져지고 고정되어 움직이지 않는다. 부드럽고 단단하지 않다. 처방은?

19 탈기

- ① 금령자산 + 실소산
- ② 격하죽어탕 + 육군자탕
- ③ 별갑전환 + 육군자탕
- ④ 팔진탕
- ⑤ 보중익기탕

☞ 적응에 적괴가 더 커지고 단단하며 통처가 고정되고 점차 야위고 음식을 먹는데 문제가 생긴다. 때때로 오한발열이 있고, 여자일 경우 월경을 안하기도 한다. 낫빛이 어둡다. 舌邊暗或質紫, 或瘀斑, 脈細澀한 경우 처방은? 18

- ① 금령자산 + 실소산
- ② 팔진탕 화적환
- ③ 목향순기산
- ④ 격하죽어탕 + 육군자탕
- ⑤ 사물탕

2. 취중

1) 肝氣鬱滯 간기울결

증상	腹中氣聚, 攻竈脹痛(여기저기 쑤심), 時聚時散, 脘脇之間, 時或不適, 苔薄, 脈弦
치법	疏肝解鬱, 行氣消聚
처방	소요산

🔍 소요산(逍遙散) 📖

- 구성: 백출, 백작약, 백복령, 시호, 당귀, 맥문동 4g, 박하, 감초 2g, 생강 6g + 단치소요산(목단피, 치자)
- 설명: 疏肝解鬱, 健脾養血, 疏鬱解熱
 - 逍遙(搖): 消散氣鬱, 搖動血鬱
 - 逍遙: 藥能使病安, 則逍遙翺 翺自適也
- 적용: 治一切氣鬱之劑 / 憂鬱起病者, 有效 / 憤怒氣鬱而致病者, 諸症加重
 - 우울해서 병이 생긴 자에게 효과가 있고, 분노로 기울이 생겨서 병이 된 자(화병)에게는 효과 없음

🔍 화간전(化肝煎)

- 구성: 청피, 진피, 작약, 패모 8g, 목단피, 치자(炒), 택사 6g
- 소요산과 다름: 울분으로 인한 것에 화간전을 用
- 분노로 간이 상해서 기가 위로 거슬러 오를 때 用
- 적용: 治怒氣傷肝, 氣逆動火, 脇痛脹滿, 煩熱動血

2) 食滯痰阻 식체담조 📖 19 달기

증상	腹脹或痛, 便秘納呆, 腹部時有條狀物聚起, 重按則腹痛更甚, 舌苔膩, 脈弦滑 : 복창하거나 아픔, 변비, 납매, 누르면 더 심해짐
치법	消導通腑, 理氣化痰
처방	육마탕 (사마탕 + 대황·지실)

📖 소요산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 17

- 逍遙의 의미: 藥能使病安, 則逍遙翺 翺自適也
- 憤怒氣鬱而致病者에게 유효하다.
- 疏肝解鬱, 健脾養血하는 효과가 있다.
- 일체의 기울치료에 사용한다.
- 단치소요산은 經期感冒를 치료한다

📖 취중이다. 배가 부어오르고 혹은 아프며 변비가 있고 식욕이 없다. 복부에 물체가 모여 나뭇가시 모양으로 있다.

설태니 맥현활한 경우, 처방은? 19 달기

- 목향순기산
- 육마탕
- 소요산
- 보화환
- 격하축어탕

09

적취의 분류

- ① 오장적 (肥氣, 伏梁, 痞氣, 息賁, 奔豚) ② 血積 ③ 息積 ④ 痰積 ⑤ 水積
⑥ 경기 ⑦ 蟲積 ⑧ 장담 ⑨ 석가 ⑩ 징하현벽

1. 오장적(五臟積)

📖 오장적의 이름을 서술하시오 03 05 06 08 10 12 13 15

간적	심적	비적	폐적	신적
肥氣	伏梁	痞氣	息賁	奔豚

1) 간적(肝積) = 肥氣

: 우울한 감정 때문에 기혈이 멎어서 생김 / 좌측에 생김

원인	內傷憂鬱, 氣血凝結不散 스트레스, 감정기복 특히 우울감
증상	左脇下有塊, 狀如覆杯, 有頭足, 令人嘔逆, 或 兩脇痛引少腹, 足寒轉筋, 脈弦細 • 왼쪽 옆구리에 덩어리가 있어 잔을 얹어놓은 것 같고, 구역질, 양 옆구리가 아랫배까지 땅기면서 아픔, 다리시리고 쥐가 남 • 간을 말하면서 좌를 말함: 옛날 사람들은 우측은 폐, 좌측은 간에 속한다고 함
변증	失治, 令人發咳逆痰癰, 連歲不已 或胃弱食少, 大便溏薄, 不堪攻矣
치료	• 비기(肥氣)환: 形氣虛者, 補一三日, 攻一日 (1~3일 보약, 1일 공약) - 補正: 八珍湯 / 攻病: 肥氣丸 • 服肥氣丸後, 病減大半, 和平之劑調養, 服逍遙散: 비기환을 복용한 후에 병이 70% 정도 줄면 비기환을 끊고 화평한 약으로써 조양하는데 소요산을 쓴다. • 환자 상태에 따라 선보후공, 선공후보, 부정거사 3가지 방법을 用

🔍 비기환(肥氣丸)

- 구성: 시호 40g, 황련 28g, 후박 20g, 천초 16g, 감초 12g, 봉출, 인삼, 곤포 10g, 조각, 백복령 6g, 건강, 파두상 2g, 천오 0.8g
- ① 시호: 爲君, 入肝消積 대표적인 肝家藥 ② 곤포, 봉출, 후박, 천초, 조각: 利氣行滯, 消壅破結
- ③ 인삼, 감초, 복령: 補正氣不足, 減峻藥暴性 ④ 파두: 攻堅消積
- ⑤ 건강, 천오, 황련: 寒熱並用, 師瀉心之意, 消左脇痞塊

📖 간적에 비기환을 복용한 후 병이 크게 줄면 조기하기 위해 사용하는 화평한

약은? 18 19

- 도노산
- 소요산
- 부비소적탕
- 활담조식환
- 육미지황탕

2) 심적(心積) = 伏梁

원인	憂愁思慮, 心氣鬱結 근심걱정, 사려
증상	臍上有塊, 大如臂, 上至心下, 牢固不動, 堅硬不軟, 如屋之梁, 脈沈有力 • 배꼽위에 덩어리가 생겨서 크기가 팔뚝만하기도 하고 명치끝까지 미치기도 하고 단단하면서 움직이지 않음. 부드럽지 않고 대들보를 대놓은 것 같음
변증	失治, 時欲心煩, 夜眠不安, 身體股胫皆腫, 不可移動, 環臍而痛, 脈沈而芤
치료	- 복량환 - 形體虛者, 朝服伏梁丸, 晚服歸脾湯 - 虛甚者, 補二三日, 攻一日: 허증이 심하면 귀비탕을 이삼일 쓰고 하루 공한다 - 變症: 扶正祛邪, 歸脾湯下桃奴丸 (귀비탕으로 도노환을 삼김) - 病減大半, 服桃奴散 병이 크게 감소하면 도노산 씹

🔑 복량환(伏梁丸)

- 구성: 황련 60g, 후박, 인삼 20g, 황금, 계지, 복신, 단삼 4g, 건강, 창포, 파두상, 천오 2g, 홍두구
- ① 황련: 爲君, 瀉心, 消心經積熱 ② 황금, 건강, 계지, 천오: 사심탕의 뜻을 취함
→ 寒熱並用, 師瀉心之意, 消痞 軟堅
- ③ 복신: 安心神 ④ 창포: 開心竅 ⑤ 단삼: 行心血 ⑥ 인삼: 補心氣 ⑦ 파두: 攻心積之先鋒

🔑 도노환,산(桃奴丸, 散)

- 구성: 도노환 / 도노 120g
- 설명: 未服 / 만병의약고문

3) 비적(脾積) = 痞氣

원인	中氣虛弱, 痰食積結 : 중기허약하여 담과 음식이 뭉쳐서 생김
증상	胃脘有塊, 大如覆杯, 痞塞吐泄, 脈沈而牢 : 위안에 덩어리가 있고 잔을 얹어놓은 것 같고 답답하면서 토하고 설사
변증	失治, 令人四肢不收, 發黃疸, 飲食不爲肌膚
치료	- 비기(痞氣)환 - 形體虛者, 朝服痞氣丸, 晚服四君子湯: 형체 허한 사람은 아침에 비기환, 저녁에 사군자탕 - 虛甚者, 補二三日, 攻一日: 사군자탕을 2-3일간 복용 후 비기환 1일 복용 - 變症: 부비소적탕 - 病減大半, 服扶脾消積湯: 병이 감소하면 부비소적탕으로 조리

🔑 비기환(痞氣丸)

- 구성: 황련 32g, 후박 16g, 오수유 12g, 황금 8g, 촉사, 인진, 건강 6g, 백복령, 인삼, 택사 4g, 천오, 천초 2g, 계피, 파두상 1.6g, 백출 0.8g
- 설명
 - ① 후박, 사인, 오수유, 천초: 爲君, 溫脾散結, 消脾積
 - ② 황련, 황금, 건강, 천오, 계피: 寒熱並用, 師瀉心之意(사심탕의 뜻을 따름), 消痞 軟堅
 - ③ 인진, 복령: 滲脾濕, 利膀胱 ④ 인삼, 백출: 扶脾元 ⑤ 파두상: 攻堅消積

🔑 부비소적탕(扶脾消積湯)

- 구성: 인삼, 백출, 백복령, 인진호, 황련 12g, 자감초, 택사, 건강 4g
- 설명 ① 사군자탕(백출, 백복령, 자감초): 和中補脾 ② 인진, 택사: 利水退黃 ③ 황련, 건강: 消痞軟堅
- 적용: 治脾積失治, 傷脾元, 四肢不收, 黃疸, 飲食不爲肌膚

4) 폐적(肺積) = 息賁 ㉮ 19 탈기

원인	肺氣不肅, 痰凝不解: 폐기가 숙강 X, 담이 뭉쳐서 풀어지지 않음
증상	右脇下有塊, 狀如覆杯, 氣逆背痛, 脈浮牢 : 우측협하에 덩어리가 만져지고 잔을 얹어놓은 것 같음, 숨이 차고 등이 아픔
변증	失治, 痰愈盛, 氣愈逆, 灑淅寒熱喘咳, 發爲肺癰
치료	- 식분환 - 形體虛者, 朝服息賁丸, 晚服人參湯 / 虛甚者, 補二三日, 攻一日 (補: 인삼탕, 攻: 식분환) - 變症: 세신건강오미자탕 / 病減大半, 服豁痰調息丸: 나으면 활담조식환 조리

🔑 식분환(息賁丸)

- 구성: 황련 52g, 후박 32g, 천오, 길경, 백두구, 진피, 삼릉, 천문동, 인삼 8g, 건강, 백복령, 천초, 자완 6g, 청피, 파두상 2g

㉮ 심적에 대한 설명으로 옳은 것은? 11

가. 心之積 名曰伏梁

나. 臍上有塊 大如臂 (복원 미흡)

다. 上至心下

라. 名曰痞氣

마. 名曰奔豚

㉮ 오장적을 치료하여 병감대한 후 조양하는 것은? 17

① 肥氣 - 도노환

② 伏梁 - 소요산

③ 痞氣 - 부비소적탕

④ 息賁 - 육미지황환

⑤ 奔豚 - 활담조식환

㉮ 위안에 큰 쟁반을 얹어놓은 것 같은 적기가 있다. 오래 되어도 낫지 않으며 사지를 잘 쓰지 못하고 황달이 발생하며 음식을 먹어도 몸이 마른다. 처방은? 18

① 비기환

② 복령환

③ 식분환

④ 분돈환

⑤ 도노환

㉮ 오른쪽 협하에 잔을 얹어놓은 듯한 적기가 있다. 기가 더욱 상역하여 숨이 차고 으슬으슬하고 오한발열하며 기침하고 폐옹이 발생할 때 처방은? 19 탈기

① 肥氣丸

② 息賁丸

③ 伏梁丸

④ 痞氣丸

⑤ 奔豚丸

🔑 인삼탕(人蔘湯) - 구성: 인삼, 백복령, 천문동 12g, 자감초 4g - 설명: 大補肺氣
🔑 세신건강오미자탕(細辛乾薑五味子湯) - 구성: 오미자 16g(君), 세신, 건강, 계지, 감초 6g - 설명 ① 세신, 계지: 散寒消飲, 以開肺壅 ② 오미자: 斂肺止咳, 以平氣喘 ③ 감초: 和氣 / 건강: 和陽 - 적용: 治肺積失治, 灑淅寒熱喘咳, 形寒不渴, 脈遲
🔑 활담조식환(豁痰調息丸) - 구성: 패모, 상백피, 길경, 자완, 반하(薑製), 지각(麩炒) 120g - 설명: 豁痰調氣 - 적용: 목에 가래가 차서 숨이 안 쉬어지고 기침할 때 用

5) 신적(腎積) = 분돈

원인	驚恐傷腎, 分泌不利, 水積不消: 놀라거나 두려움으로 신을 상함, 수가 쌓여서 없어지지 않음
증상	氣從少腹起, 上衝咽喉, 如豚奔突之狀, 脈沈細附骨 - 배꼽아래부위에서 기가 일어나서 위로 치밀어 목구멍까지 이름 - 마치 파돈(복어)이 (물살을 거슬러) 치밀어 오르는 듯한 형상
변증	① 失治, 變爲喘逆, 骨瘦少氣, 不能起於牀 ② 失治, 氣衝咽喉如塞, 發作欲死, 神色驚怖
치료	- 분돈환 - 愈後, 服六味地黃丸 나온 후 육미지황환 조리

🔑 분돈환(奔豚丸)

- 구성: 후박 28g, 황련 20g, 천련자 12g, 백복령, 택사, 창포 8g, 현호색 6g, 전갈, 부자, 독활 4g, 천오, 정향, 파두상 2g, 육계 0.8g
- 설명
 - ① 부자, 오두, 육계: 爲君, 祛腎寒, 消腎積 ② 택사, 복령: 利水氣, 治奔豚 수기 빼냄
 - ③ 전갈, 독활: 祛風邪, 行氣滯 ④ 창포: 治風痰之痺塞 ⑤ 파두: 消頑結之積塊 적취 없앰

📖 분돈기에 대해 옳은 것은? 18 19

- ① 취증의 범주이다.
- ② 기체혈어로 인해 발생한다.
- ③ 예후가 불량하다.
- ④ 복부에 포기가 있고 고정불이하다.
- ⑤ 통증이 일정한 부위에 있다.

💬 腎積 奔豚과 奔豚氣 (감별)

📖 奔豚氣와 腎積奔豚, 衝疝을 감별 진단하시오 99

신적분돈	분돈기
기질성 질환	기능성 질환(신경정신장애)
積病	聚證의 범주
복부에 包塊(덩어리)가 있음, 固定不移, 통증이 일정한 부위에 있음	奔豚氣의 '氣'字는 깊은 의미가 있음 (秦伯末)
楊玄操: 신적분돈과 분돈기는 상이한 질환임	대부분 신적분돈과 분돈기를 같은 질병으로 인식함 증상이 같기 때문
氣滯血瘀로 형성	-
예후 불량	-

💬 奔豚氣의 병인병리

- ① 驚恐傷腎 ② 情志損傷: 스트레스 ③ 飲食傷胃: 음식 ④ 任陰不足: 음액부족
- ⑤ 誤汗傷陽: 땀을 잘못 내어 양기손상 ⑥ 衝氣上衝: 충기가 상충하는 것
- ⑦ 《골공론》 衝脈爲病, 逆氣裏急: 충맥에 병이 들면 기가 아래에서부터 역상해서 뱃속이 켕긴다
- ⑧ 腎主納氣, 肝主疏泄이 상실된 것
- ⑨ 衝脈隸于陽明 衝맥은 양명(위)에 예속된다
- ⑩ 衝任同出異流: 충맥과 임맥은 회음부위에서 같이 생겨서, 흘러가는 방향만 다름
- ⑪ 誤汗: 水寒之氣上衝 잘못 땀내면 차가운 물 기운이 상충해 켕김

[요약] 분돈기는 충기가 상충해서 생기는 것인데, 여기에 관여하는 것: 신, 간, 양명(위), 충맥, 임맥

🗨️ 奔豚氣의 진단

📖 奔豚氣의 진단에서 주된 증상, 전조 증상, 부가증상에 대해 쓰시오 07 09 10 13

- ① 주된 증상: 氣上衝 기가 위로 치밀어 오름
- ② 전조 증상: 臍部動悸 배꼽 주위가 뛰면서 불안해짐
- ③ 수반 증상
 - 喘逆短氣(천식), 兀兀欲吐, 食飲輒吐. 或腹痛, 痛及腰髀. 驚悸不寧, 心下煩亂, 惡聞人聲, 甚則喜怒無常, 不知人. 或 乍寒乍熱, 手足厥冷.
 - : 숨이 가빠지고 토할 거 같고 음식을 먹으면 바로 토함. 배가 아프고 통증이 허리나 엉덩이까지 퍼짐. 심장이 뛰면서 불안, 답답, 사람소리듣기를 싫어함, 심하면 즐거워하거나 화내는 것이 갑작스러움, 사람을 알지 못 함. 잠깐 추웠다가 더웠다가, 수족이 참
 - 수분 내지 수 시간 지속, 반복 발작
 - 情緒不好 時 심해짐 감정이 좋지 않을 때

🗨️ 奔豚氣의 치료원칙

📖 奔豚氣의 치료원칙을 기재하시오 99 08 10 12 14 15

- ① 충기 상충은 降逆平衝: 高者抑之
↳ 위로 치밀어오르는 것은 내리눌러야 한다
- ② 降胃: 衝脈隸于陽明, 治陽明即治衝也
↳ 충맥이 양명에 예속되므로 양명을 치료하는 것이 충맥을 치료하는 것이다
- ③ 平肝(肝火肝氣): 衝胃衝逆者, 多爲肝火肝氣之激發, 治肝即是治衝
↳ 충기와 위기가 치밀어오르는 경우는 간화나 간기가 격발시키는 것이다.
간을 치료하는 것이 곧 충을 치료하는 것이다.
- ④ 安腎: 腎爲衝脈之根, 安腎氣即是安衝氣
↳ 신은 충맥의 근본이므로 신기를 안정시키는 것이 곧 충기를 안정시키는 것이다

🗨️ 奔豚氣의 분류

1) 肝氣奔豚 (간기분돈)	병리	肝火上衝
	증후특성	實熱證
	증상	奔豚主症 + 肝鬱化火
	치법	疏肝清火, 降逆平衝
	처방	분돈탕
2) 腎氣奔豚 (신기분돈)	병리	水寒上逆
	증후특성	虛寒證
	증상	분돈주증 + 心腎陽虛
	치법	溫陽降逆, 散寒利水
	처방	계지가계탕 + 영계감조탕



분돈탕(奔豚湯) 계지탕 + 소시호탕 가감

- 구성: 李根白皮, 갈근 10g, 반하, 생강 8g, 자감초, 당귀, 천궁, 황금, 백작약 4g
- 설명
 - ① 이근백피 : 理氣清熱, 緩解疼痛, 專治奔豚氣逆
 - ② 갈근, 황금: 清肝降火
 - ③ 작약, 감초: 緩急止痛
 - ④ 생강, 반하: 降逆和胃
 - ⑤ 당귀, 천궁: 養血柔肝
- 적용: 治奔豚, 胸腹痛, 往來寒熱



계지가계탕(桂枝加桂湯) 계지탕 + 육계

- 구성: 계지, 작약, 생강 6g, 감초, 육계 4g, 대추 12g
- 설명
 - ① 육계: 禦寒, 制腎氣
 - ② 계지: 溫心腎, 降寒氣
 - ③ 작약, 감초: 緩急止痛
 - ④ 생강, 대조: 溫寒化飲, 和胃降氣
- 적용: 治陽虛陰寒上逆之奔豚



영계감조탕(苓桂甘棗湯)

- 구성: 백복령 16g, 계지 8g, 감초 4g, 대조 16g
- 설명
 - ① 계지: 保心氣
 - ② 복령: 安腎氣
 - ③ 계지, 복령: 化太陽之水氣
 - ④ 감초, 대조: 補中土而制水邪之溢
 - ⑤ 감란수: 諸藥下行
- 적용: 治太陽發汗而傷腎氣, 臍下悸, 欲作奔豚

📖 다음 중 奔豚氣의 전조 증상은? 17

- ① 兀兀欲吐
- ② 心下煩亂
- ③ 惡聞人聲
- ④ 氣上衝胸
- ⑤ 臍部動悸

📖 奔豚氣 치법으로 옳지 않은 것은? 17

- ① 降逆平衝
- ② 降胃
- ③ 平肝
- ④ 安腎
- ⑤ 補中益氣

📖 분돈기 치법에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은? 11

- 가. 治陽明即治衝 나. 治心即是治衝
다. 安腎氣即是安衝氣
라. 安肺氣即是安衝氣

- ① 가나다
- ② 가다
- ③ 나라
- ④ 라
- ⑤ 가나다라

2. 혈적(血積)

원인	타박, 추락
병리	瘀血蓄於胸腹而成. 瘀血成積: 어혈이 가슴이나 배에 쌓여서 생김
증상	痛有定處, 遇夜則甚, 面黃糞黑, 多怒善忘, 口燥便秘, 骨熱肢冷 • 통증이 한곳에 머물러있고 밤이면 심해짐, 설망 증상, 화를 잘 내고 잘 잊어버림, 속에서는 열나는데 팔다리는 차가움
치법	活血化瘀
처방	저당탕, 도인승기탕, 삼릉전원, 귀출파징탕
🔑 저당탕(抵當湯) • 구성: 수질(炒), 망충(炒) 4g, 도인 8g, 대황(蒸) 12g • 설명: 攻逐蓄血 (강한 약이므로 장기간 쓰지 않음) • 적용: 治一切瘀血, 結胸, 譫語, 漱水, 어혈성의 小腹硬滿과 월경불리를 치료	
🔑 삼릉전원(三稜煎元) • 구성: 대황 320g, 삼릉, 봉출 40g • 설명: 性寒, 破血通瘀 • 적용: 治婦人血積, 血塊, 血蠱, 어혈로 인한 小腹硬痛과 월경불순을 치료	
🔑 무극환(無極丸) • 구성: 대황 160g (단방) • 설명: 補血逐瘀 • 적용: 治經閉有血塊 (+ 급성 출혈에 대황 사용 多)	
🔑 귀출파징탕(歸出破癥湯) • 구성: 향부자(醋炒) 6g, 삼릉, 봉출(醋煮), 적작약, 백작약, 당귀미, 청피 4g, 오약 3g, 홍화, 소목, 관계 2g, 술 조금 • 설명 ① 삼릉, 봉출: 破堅行滯, 止痛 ② 향부자, 오약, 관계: 利氣溫裏 ③ 작약, 당귀미, 홍화, 소목: 破血 ④ 청피: 疏肝破氣, 散積消痞 • 적용: 治經閉腹痛, 有積塊疼痛: 월경이 나오지 않고 덩어리가 있어서 아픔	

3. 식적(息積)

병리	有所怫鬱, 氣爲之鬱: 억울한 감정으로 인해 기가 울체되어 생김
증상	脇下脹滿, 氣逆息難, 飲食如故, 未見形塊, 或有形塊 : 험하찬만, 기가 치밀어 오르고 숨쉬기곤란, 음식은 평상시처럼 먹음
치법	調暢氣機
처방	화기탕, 목향조기산 기기를 순환시키는 약 (조기) → 호흡을 편안하게 함

4. 식적(食積) = 일명 宿食不消

- 宿食不消라고도 하고 乳食不調라고도 한다.
- 음식물이 정체하여 소화되지 않는 증후이다.
- 內傷의 飲食傷을 참조하여 치료한다.

증상	食不消化, 成積, 痞悶
치법	평위산 + 축사, 향부자, 신곡, 맥아, 생강, 자소엽 / 保和丸

5. 담적(痰積) 📌

병리	痰濁凝聚胸膈而成: 담타이 흉격에 응체하여 형성
증상	① 麻木眩暈: 마목(감각이 빠근해지면서 둔해짐)현훈 ② 痞悶嘈雜: 답답하거나 조잡 ③ 平素多痰: 평소에 가래가 많은 호흡기 계통에 문제가 있다 ④ 涕唾粘稠: 콧물이나 침이 끈적끈적함 ⑤ 咳咯難出: 기침해서 뱉내려고 해도 잘 나오지 않음 ⑥ 胸間隱痛: 흉간이 은은히 아픔 ⑦ 咽門至胃脘窄狹如線: 목에서부터 명치까지 좁아진 듯한 느낌이 있음 ⑧ 目眩頭旋, 腹中累累有塊: 머리가 어지럽고 배에 덩어리가 잡히는 듯
치법	開胸滌痰
처방	도담탕, 공연단, 개기소담탕

☞ 담적에 대해 옳은 것을 고르시오 11
가. 痰濁凝聚 胸膈而成 나. 治法: 開胸滌痰
다. 胸間隱痛, 咽門至胃脘窄狹如線
라. 開氣消痰湯
① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

☞ 다음 증상이 나타나는 것은? 17
麻木眩暈, 痞悶嘈雜, 平素多痰, 涕唾粘稠,
咳咯難出, 胸間隱痛, 咽門至胃脘窄狹如線,
目眩頭旋, 腹中累累有塊
① 혈적 ② **담적** ③ 식적 ④ 수적
⑤ 충적

☞ 피부의 감각이 없고 어지럽다. 속이 답답하며 가슴앓이가 있다. 평소 가래가 많은데 콧물이나 타액처럼 끈끈하여 뱉어도 잘 나오지 않는다. 가슴 사이가 은근히 아프다. 목구멍에서 명치까지 실처럼 좁아진 것 같다. 눈이 아찔하며 머리가 빙빙 돈다. 뱃속에 덩어리가 여러 개 있다. 처방은? 18 19
① **개기소담탕** ② 보화환 ③ 목향조기산
④ 귀출파징탕 ⑤ 성출환

6. 수적(水積)

병리	水飲成積
증상	胸脇引痛, 漉漉有聲, 足脛脹滿 : 흉협이 땅기면서 아프고 꼬르륵 소리가 나고 다리가 부음
치법	▷ 其治有三 ① 多飲水漿而成: 십조탕, 궁하탕 (물을 빼냄) 물 많이 마셔서 생긴 경우 ② 喜吃茶飲而成: 성출환 - 차 많이 마셔서 ③ 多飲酒而成: 대금음자 - 음주 많이 해서
🔍 십조탕(十棗湯) • 구성: 원화(微炒), 감수, 대극(炒) 등분 • 설명: 攻逐水飲 • 적용: 治傷寒有懸飲伏飲, 脇下引痛 / 胸背脇引痛, 心下痞 硬滿, 乾嘔, 咳煩을 목표로 함	
🔍 궁하탕(芎藭湯) · 이진탕 + 천궁, 청피, 지각, 백출 • 구성: 천궁, 반하, 적복령 8g, 진피, 청피, 지각 4g, 백출, 자감초 2g, 생강 10g • 설명: 이진탕(祛痰) / 천궁(行宿血) / 청피, 지각(破氣行滯) / 백출(補脾) • 적용: 逐水利飲에 통용 / 담음의 통치방 / 흉막염, 늑막염(倍劑) / 담 걸린 데	
🔍 성출환(星朮丸) • 구성: 우담남성, 백출, 석고, 황금, 작약, 박하 등분(丸服) • 설명: 우리나라는 뱀에 걸석(위석, 시석) 생기는 경우 X BUT, 중국은 차를 물처럼 마시니까 생김 • 적용: 治喫茶成癖	
🔍 대금음자(對金陰散子) · 평위산 + 평위산가감 • 구성: 진피 12g, 건갈 8g, 적복령, 축사, 신국 4g, 창출, 후박 3g, 감초 2g, 생강 10g • 설명: 溫中和胃整腸 • 적용: 治酒食傷, 和胃消痰, 治酒滯	

7. 경기(聚氣) 📖

📖 聚氣란 무엇이며, 처방을 쓰시오 11

정의	脇下痛, 按之則愈, 復發, 爲聚氣. : 옆구리가 아픈데 누르면 낫고, 다시 재발하는 것을 경기라 함
증상	聚氣者, 飲積脇下痛也, 按之則止, 不按復痛, 以水氣得按暫散, 故痛暫止也. 《의종금감》 : 수음이 쌓여서 옆구리가 아픈 것 (요즘이라면 담음으로 인한 협통) : 누르면 통증이 그치고 누르지 않으면 다시 아픈 것은 눌렀을 때 수기가 잠시 흩어지기 때문에 고로 통증이 잠시 그침
처방	궁하탕 (담음협통에 씀)

8. 충적(虫積) = 九蟲積 요새는 잘 X

병리	腹內蟲多, 積聚成塊
증상	腹中不時塊痛, 面青, 時吐清水苦水, 腹中咬痛, 腹痛多在臍周, 時作時止, 或睡時流涎, 脘腹膨大
처방	묘응환
🔍 묘응환(妙應丸) • 구성: 빈랑 48g, 흑축 12g, 대황, 雷丸, 석회, 蕪荑, 목향, 사군자 4g • 적용: 治蟲積	

9. 장담(腸覃) - 장에 버섯모양으로 융종, 폴립 같은 것이 생긴 것

📖 腸覃의 특징은? 12

- 覃: 蕈의 省文으로 서로 통용

- 腸覃: ① 腸外息肉生如蕈狀 ② 腸內如瘰癧肉如蕈

병리	寒氣客于腸外, 與衛氣相搏, 結而爲瘕
특징	① 氣病而血不病: 기병은 있으나 혈병은 없음 ② 胞宮과 무관 ③ 月經按時來潮: 월경은 제때 함
증상	始如鷄卵, 久如懷胎, 按之堅, 推之移, 月事時下, 或多或少 : 누르면 단단하고 움직이지 않으며 나중엔 임신한 것처럼 커짐

📖 聚氣는 어디에 속하는가? 08 11 13 17

- ① 瘀血脇痛 ② 痰飲脇痛 ③ 食積脇痛
④ 氣鬱脇痛 ⑤ 風寒脇痛

📖 경기는 어디에 해당하는가? 18

- ① 기울협통
② 식적협통
③ **담음협통**
④ 풍한협통
⑤ 어혈협통

치법	利氣行滯, 攻堅散寒
처방	이진탕 + 향부자, 삼릉, 봉출, 별갑 / 향릉환
조리	愈後, 服四君子湯

🔍 향릉환(香稜丸)

- 구성: 목향, 정향 20g, 회향(炒), 삼릉(酒浸), 지각(麸炒), 봉출(用巴豆30粒, 去殼, 同炒, 巴豆色黃, 去豆不用), 청피, 천련자 40g (이기해주는 약 多)
- 설명: 利氣行滯, 消氣結
- 적용: 腸覃病, 氣病而血不病, 宜服此

10. 석가(石瘕) 자궁에 생기는 혹

= 일명 血瘕 / 石瘕: 久則堅硬如石

📌 石瘕의 증상 및 처방에 대해 기하시오 05

병리	寒邪客于胞宮, 瘀血內留所致 한사가 포궁에 들어감 → 자궁혹, 자궁암
특징	① 先氣病而後血病 ② 胞宮과 관련: 자궁에 생기는 질환임 ③ 月事不下: 월경을 하지 않음
증상	少腹結塊, 日漸長大, 狀若懷子, 月事不下 : 아랫배의 뭉쳐있는 덩어리가 날로 커져서 임신한 것 같음, 월경이 나오지 않음
치법	活血化瘀, 攻下惡血
처방	통경환, 화혈통경탕, 오수유탕
조리	愈後, 服四物湯

🔍 통경환(通經丸)

- 구성: 대황, 청피, 건강, 계심, 천초, 봉출, 건칠(炒), 당귀, 도인, 홍화 20g
- 적용: 治月候不通, 或血瘕

🔍 화혈통경탕(和血通經湯)

- 구성: 당귀, 삼릉(炮) 10g, 봉출(炮) 8g, 목향, 숙지황, 육계6g, 홍화, 관중, 소목4g, 혈갈(別研) 2g
- 적용: 治婦女受寒經閉, 惡血積結, 堅硬如石

🔍 오수유탕(吳茱萸湯)

- 구성: 당귀, 육계, 오수유, 목단피, 반하, 맥문동 4g, 방풍, 세신, 고본, 건강, 백복령, 목향, 자감초 2g
- 설명 ① 방풍, 세신, 고본: 泄風透邪 ② 육계, 오수유, 건강: 溫經散寒 ③ 당귀, 목단피: 和血 ④ 반하, 목향: 利氣 ⑤ 복령, 감초: 和脾 ⑥ 맥문동: 和胃
- 적용: 治因寒(한사는 뭉치게 하는 성질을 가지고 있음), 經行腹痛, 痛時喜按, 形體實者, 宜服

11. 징가현벽(瘕瘕瘕瘕)

瘕	堅而不移. 腹中堅硬, 按之應手: 단단하여 움직이지 않음, 누르면 손에 반응이 있음
瘕(가)	堅而能移. 腹中雖硬, 忽聚忽散, 無有常處 : 단단하지만 움직임, (뱃속이 단단하지만 찾으려 하면 흩어짐) 취증과 비슷. : 실제로 있는 것은 아니고 거짓으로 있는 적취
瘕	腹內近臍左右, 各有一條筋脈急痛, 如臂如指如弦之狀 : 배꼽좌우에 근맥이 땅기면서 아프며 손가락, 거문고 줄처럼 나타남
瘕	偏僻在兩脇之間, 有時而痛: 양 옆구리 사이에 한쪽에 치우쳐 있음

- 瘕因傷食, 瘕因傷血, 瘕原傷氣, 瘕則傷精 (큰 의미는 x, 정확하게 나누기 어려움)
- 瘕瘕瘕瘕, 得冷則痛: 냉기를 얻어서 통증 생김

📌 치법

- 行血順氣에 치중
- 破血消瘀와 導滯散氣로 보좌

📌 瘕, 瘕瘕, 積, 聚 / 瘕, 瘕

瘕, 瘕瘕, 積, 聚	瘕, 瘕
① 瘕와 瘕瘕는 흉격 사이의 병	① 배꼽 아래에 나타남
② 적과 취는 肚腹內의 병	② 하초의 병
③ 상초와 중초의 병	③ 항상 부인에게 나타남: 부녀의 적취
④ 남자에게 많음	

📌 石瘕에 대해 옳은 것은? 11

- 가. 氣病而血不病 나. 月經按時來潮
다. 利氣行滯 攻堅散寒
라. 少腹結塊, 狀若懷子, 月事不下

- ① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

📌 石瘕에 대해 옳은 것은? 19

- 가. 先氣病而後血病 나. 月事不下
다. 活血化瘀, 攻下惡血
라. 腸內如瘕肉如韮

- ① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

📌 石瘕의 설명 중 옳은 것은? 17

- ① 증상: 少腹結塊, 日漸長大, 狀若懷子, 月事不下
② 기병이고 혈병이 아니다.
③ 처방: 보중익기탕
④ 포궁과 무관하다.
⑤ 치법: 利氣行滯, 攻堅散寒

📌 다음 빈칸을 채우시오 05

- (瘕): 腹內近臍左右, 各有一條筋脈急痛, 如臂如指如弦之狀
- (瘕): 偏僻在兩脇之間, 有時而痛
- (瘕): 堅而不移. 腹中堅硬, 按之應手
- (瘕): 堅而能移. 腹中雖硬, 忽聚忽散, 無有常處

📌 瘕瘕에 대한 설명으로 옳은 것은? 17

- ① 흉복이나 두복 사이의 병이다.
② 상초와 중초의 병이다.
③ 남자에게 많다.
④ 하초의 병이며 부인에게 나타나는 부녀의 적취다.
⑤ 補氣潤血하며 破血消瘀, 導滯散氣로 보좌한다.

10 적취의 예후

積聚癥瘕, 不轉動者, 難治, 必死	덩어리가 생겨서 움직이지 않고 딱딱해져 있으면 난치
五積中, 奔豚證, 最爲難治	오적중에 분둔증(신적분둔)이 최고로 난치
醫爲病所困者, 惟陰虛之難補, 久積之難除	의사가 곤란스러운 것은, 음허증은 보하기 어렵고 오래된 적취는 제거하기 어렵다

11 적취의 조리

令人眞氣實, 胃氣強, 則積自消失, 更能斷厚味, 節色慾, 戒暴怒, 正思慮, 庶乎萬全而無害
진기가 실하고 위기가 강하면 적이 저절로 사라진다. 기름진 음식을 끊고, 색욕을 적절히 조절하고, 화내는 것을 경계하고, 생각을 바르게 해야 한다.
만전을 기하여서 해가 없도록 하라

12 대장 용종

정의

- 대장용종: 내강으로 돌출하는 경계가 선명한 용기
- ┐ 용종이 1개인 경우) 고립성 용종(solitary polyp)
- └ 용종이 많이 밀집한 경우) 폴립 포시스(polyposis)
- ↳ 용종증 증후군) 대장의 polyposis를 주증상으로 하는 증후군

용종의 분류

상피성 용종	신생물성 상피성 용종	adenomatous polyp 악성 용종
	비신생물성 상피성 용종 (악성x)	hyperplastic, juvenile, mucosal, Peutz-jeghers, inflammatory polyp
비상피성 용종: 점막하 종양		lipoma, carcinoid tumor, leiomyoma, lymphangioma

용종증 증후군 분류

유전성 용종증 증후군	유전성 선종성 용종증 증후군	100개 ~ 수천 개의 용종, 암성 변화 : 가족성 선종성 용종증, 가드너 증후군, 터코트 증후군
	유전성 과오종성 용종증 증후군	포이츠-예거 증후군, 연소성 용종증, 카운덴병
비유전성 용종증 증후군		염증성 용종증, 과형성성 용종증, 림프양 용종증

대장용종의 변증시치

1) 大腸濕熱 대장습열

증상	대변이 시원하지 않거나 무름, 점액과 혈액을 끼고 있음, 색은 선홍색 혹은 복통이 있음 + 口苦, 舌紅, 苔黃膩, 脈濡數
병리	濕熱蘊遏大腸, 損傷腸道脈絡
치법	清熱利濕, 涼血解毒
치방	백두옹탕 습 지유산 가감

- 🔍 백두옹탕 합 지유산 가감(白頭翁湯 合 地榆散 加減)
- 구성: 백두옹 15g, 秦皮 20g, 황련 10g, 황백 10g, 황금 10g, 치자 10g, 지유 30g, 茜草根 15g, 복령 20g
 - 가감 ① 大便不暢: + 대황 ② 腹脹滿痛: + 목향·지실 ③ 복통분: +작약·감초 ④ 점액변: +패장초·인동등

☞ 괄호 안에 알맞은 말은? 14

醫爲病所困者, 惟()之難補, ()之難除

답) 陰虛, 久積

☞ 의사가 병 때문에 곤혹스러운 경우는? 19 (복원오류인듯 합니다)

- 가. 氣虛而難補 나. 陰虛而難補
다. 濕熱而難除 라. 久病(아마 積)而難除
답) 나, (라)

☞ 괄호 안에 알맞은 말은? 03 06 10

12 13 14 15

令人眞氣實, 胃氣強, 則積自消失,
更能斷(厚味), 節(色慾),
戒(暴怒), (正思慮),
庶乎萬全而無害.

☞ 적취의 조리에 대한 설명이다. 옳은 것은? 11

- 가. 斷厚味 나. 戒暴怒
다. 節色慾 라. 正思慮

① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라

⑤ 가나다라

☞ 진기가 견실하고 위기가 강하면 적취가 없어진다. 만전을 기하려면 무엇을 더해야 하는가? 18

- 가. 斷厚味 나. 戒暴怒
다. 節色慾 라. 正思慮

① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라

⑤ 가나다라

2) 氣滯血瘀 기체혈어

증상	- 腹部的 발작성 刺痛, 固定不移 / 복창, 설사, 자암색의 점액혈변 - 얼굴이 거무칙칙함 / 舌質紫暗 혹 瘀斑. 脈弦細 혹 澀
병리	氣機鬱滯, 血脈瘀阻, 虛實挾雜.
치법	行氣活血, 化瘀解毒
치방	격하촉어탕가감

🔑 격하촉어탕가감 (膈下逐瘀湯加減)

- 구성: 당귀미 10g, 적작약 15g, 오약 10g, 도인 10g, 홍화 6g, 지각 10g, 향부자 10g, 목단피 10g, 현호색 10g, 천련자 15g, 천궁 10g, 백화사설초 30g, 紅藤 30g
- 가감 ① 변혈: + 血餘炭·선학초·삼칠분

3) 脾胃虛寒 비위허한

증상	- 잡은 설사 또는 혈변, 먹으면 배변 / 항문에 下墜感. 腹中隱痛 또는 은근한 통증 지속 - 納呆 / 食後脘腹脹悶 / 面色萎黃, 形寒肢冷, 舌淡, 苔薄白, 脈沈細無力
병리	中虛寒凝, 氣弱不運
치법	健脾和胃, 溫中化濕
치방	부자이중탕 합 삼령백출산 가감

🔑 부자이중탕 합 삼령백출산 가감 (附子理中湯 合 參苓白朮散 加減)

- 구성: 부자 5g, 건강 5g, 백출 30g, 당삼 15g, 산약 15g, 복령 20g, 사인 5g, 진피 10g, 가자 10g, 후박 15g, 자감초 6g
- 가감 ① 自汗, 短氣, 困倦: + 황기 ② 失血, 복통 지속: + 당귀 ③ 肢冷: + 계지
- ④ 출혈이 많으면 건강을 炮薑으로 바꾸고 + 백급·오적골·삼칠근

📖 대장용종의 처방

🔑 활혈소식탕 (活血消息湯)
- 구성: 단삼 12g, 지유, 능소화, 반지련 6g, 도인, 적작약, 천산갑(炮), 조각자, 삼릉, 목단피, 괴화, 산자고, 우슬 4g - 설명: 消胃腸管息肉 (息肉: 용종, 폴립), 通經活絡, 祛瘀散結, 化痰軟堅
🔑 강잠오매환 (僵蠶烏梅丸)
- 구성: 오매(炒炭), 백강잠(炒) 200g - 설명: 治直腸息肉, 위/장의 폴립

13

대장암

📖 대장암

1) 암 발생 빈도	- 남자: 위 > 간 > 폐 > 대장 - 여자: 자궁경부 > 위 > 유방 > 대장 5년 생존율: 국소암 91%, 인근 침투 시 63%, 전이암 7%
2) 증상	- 초기: 무증상 3대 증상: ① 혈변과 하혈 ② 설사와 변비 ③ 복통 - 혈변: 어두운 색·암흑색이면 반드시 검진 必 - 출혈성 빈혈(피로, 동계, 흉통)
3) 예후	대부분 수술 후 4년 이내 재발
4) 위험인자	① 동물성 지방: 세균 번식시켜 담즙에서 발암 물질 생성 ② 염증성 대장염: 대장암 환자의 1%, 궤양성 대장염 환자 암 발생률 10배 높음 ③ 유전: 25%가 가족력 있음
5) 기타 관련인자	① 비만 ② 고콜레스테롤 혈증, 관상동맥질환 ③ 숯불에 구운 고기, 생선 또는 튀긴 음식 ④ 맥주: 직장암과 관련

☞ 대장암의 병기

☞ 대장암의 病期(5단계)를 기하시오 02 03 06 08

Stage 0	상피내암
Stage 1	① 점막하층까지 침범 ② 근육층까지 침범
Stage 2	① 장막하층까지 침범 또는 대장이나 직장 주위 조직까지만 침범 ② 내장 복막까지 침범 또는 직접 인접 장기나 구조물까지 침범
Stage 3	장벽의 침범 부위에 상관없이 대장 또는 직장 주위 림프절 전이
Stage 4	원격 전이

☞ 대장암의 예방

- ① 지방질 섭취에 의한 열량 전체 열량의 30% 이하로 줄일 것
- ② 하루 섬유소 섭취량 30g 까지 높일 것
- ③ 여러 가지 야채와 과일을 매일 섭취할 것
- ④ 비만을 피할 것
- ⑤ 음주는 적당히 할 것
- ⑥ 매일 80mg 이상의 칼슘을 섭취할 것
- ⑦ 흡연을 삼갈 것

14

소장과 암 발생

- 1) 소장: 장 길이의 75%, 점막 표면적의 90%를 차지
- 2) 전체 위장관 종양의 1~6%, 악성(소장암)은 1%에 불과함

3) 종양 발생이 드문 이유

☞ 소장에 종양 발생이 드문 이유를 기재하시오. (6가지) 99 03

- ① 음식물 통과시간 짧음: 암 유발인자 노출 감소
- ② 알칼리성 내용물: 암 유발인자 형성 억제
- ③ 소장 점막에 효소가 많음: 암 유발인자 불활성화
- ④ 장내세균 희소: 암 유발인자 결핍
- ⑤ 액체 상태의 내용물: 점막 손상 적음
- ⑥ 장내 면역글로불린의 고농도 유지
- ⑦ 점막 세포의 교체 주기 빠름

15

대장암의 변증과 처방

변증	처방
① 濕熱內蘊	① 부정건비탕
② 瘀毒結阻	② 부정양음탕
③ 脾腎陽虛	③ 탁리소독음 + 괴황지유환
④ 氣血兩虛	④ 직장암: 선방활명음 + 홍화(時逸人)
⑤ 肝腎陰虛	

☞ 대장암의 변증

1) 습열내온(濕熱內蘊)

증상	腹部陣痛, 便中夾血, 或 裏急後重, 肛門灼熱, 或 발열, 오심, 홍민, 舌紅, 苔黃膩, 脈滑數 : 배아프고 피가 나오고 이급후중 증상, 항문 열감 등
병리	濕熱內蘊, 痺阻腸道
치법	清熱祛濕, 解毒散結
치방	가감정장음

☞ 청장음가감(淸腸飲加減)

- 구성: 패장, 마치현, 의이인 12g, 백두옹 6g, 괴화, 황백, 고삼, 황금, 적작약 4g, 지유, 감초 3g
- 설명: 淸熱祛濕, 解毒散結
 - 청장음: 治腸癰腹痛, 拒按, 右足不能屈伸 (원래 장옹에 써서 금은화 등이 많이 들어가 있음)
 - 급성염증, 충수염, 맹장염, 2-3일 정도 짧게 쓰는 약
- 적용: 治濕熱內蘊

☞ 대장암의 병기 중 stage 3를 쓰시오
12 13 15

☞ 대장암의 병기 중 stage 3는? 17

① 장벽의 침범 부위에 상관없이 대장 또는 직장 주위 림프절 전이

- ② 점막하층 또는 근육층까지 침범
- ③ 장막 하층 또는 대장이나 직장 주위 림프조직까지만 침범
- ④ 내장 복막까지 침범 또는 직접 인접 장기나 구조물까지 침범
- ⑤ 원격 전이

☞ 점막하층 또는 근육층까지 침범한 경우 대장암의 병기 단계를 고르시오 18

- ① Stage 0 ② Stage 1 ③ Stage 2
- ④ Stage 3 ⑤ Stage 4

☞ 점막하층 침범, 대장 및 주위 조직 침범한 경우 대장암 병기 단계는? 19

(복원 오류인듯 합니다 장막하층인듯 합니다!
- 아마 stage 2)

- ① Stage 0 ② Stage 1 ③ Stage 2
- ④ Stage 3 ⑤ Stage 4

☞ 소장에 종양발생이 드문 이유로 옳은 것은? 11

- 가) 소장 점막에 효소가 많아서 암 유발인자가 불활성화 된다.
- 나) 음식물 통과시간이 짧아 유발 인자에 대한 노출이 감소한다.
- 다) 점막 세포의 교체 주기가 빠르다.
- 라) 산성 내용물이 있어 암 유발인자 형성이 억제된다.

☞ 소장은 장 길이의 75%, 점막 표면적의 90%를 차지하나 전체 위장관 종양의 1~6%, 악성은 1%에 불과하다. 그 이유로 옳지 않은 것은? 17

- ① 음식물의 통과시간이 짧다.
- ② 소장 점막에 효소가 많다.
- ③ 내용물이 알칼리성이다.
- ④ 점막세포의 교체 주기가 느리다.
- ⑤ 장내 면역 글로불린이 고농도로 유지된다.

☞ 소장은 장 길이의 75%, 점막 표면적의 90%를 차지하나 전체 위장관 종양의 5% 밖에 되지 않는 이유로 옳지 않은 것은? 18 19

- ① 음식물 통과시간이 짧아 유발 인자에 대한 노출이 감소된다.
- ② 내용물이 산성이기 때문에 암 유발 발생 확률이 감소한다.
- ③ 점막에 효소가 많아서 암 유발 인자의 형성이 억제된다.
- ④ 점막 세포의 교체주기가 빠르다.
- ⑤ 액체 상태의 내용물이므로 점막 손상이 적다

2) 어독결조(瘀毒結阻): 독소가 장을 막아서 생김

증상	煩熱口渴, 腹痛瀉下膿血, 色紫暗量多, 이급후중, 舌質紫或瘀點, 脈澀而細數
병리	瘀毒內阻於腸道
치법	清熱散結, 化瘀解毒
치방	격하촉어탕가감

🔑 격하촉어탕가감(膈下逐瘀湯加減)

- 구성: 단삼, 의이인, 반지련, 藤梨根, 패장 30g, 건지황, 천산갑(炮) 15g, 당귀미 12g, 홍화, 도인, 적작약, 천궁 10g
- 설명: 清熱散結, 化瘀解毒
- 적용: 治瘀毒結阻

3) 비신양허(脾腎兩虛)

증상	면색창백, 少氣無力, 畏寒肢冷, 복통, 五更泄瀉, 舌胖淡, 苔薄白, 脈浮細無力
병리	脾虛腎衰, 陽氣不振, 血絡瘀阻
치법	溫補脾腎
치방	부자이중탕 합 사신환 가감

🔑 부자이중탕 합 사신환 가감(附子理中湯 合 四神丸 加減)

- 구성: 당삼, 의이인 30g, 백출 15g, 부자(炮), 복령 12g, 보골지, 가자, 육두구, 오수유, 건강, 진피, 자감초 10g
- 설명: 溫補脾腎
- 적용: 溫補脾腎

4) 기혈양허(氣血兩虛): 팔물탈증/팔진탕증

증상	면색창백, 脣甲不華, 少氣無力, 神疲懶言, 脫肛下墜, 舌淡, 苔薄白, 脈沈細無力 : 입술, 손톱에 핏기가 없이 힘이 없음, 말하기 싫어함 등의 허증 증상
병리	氣虛血衰, 脾氣不行, 痰瘀互結
치법	益氣養血, 健脾補腎
치방	팔진탕가감

🔑 팔진탕가감(八珍湯加減)

- 구성: 인삼, 황기(炙) 12g, 八月札 8g, 단삼, 대조 6g, 백작약, 백출 5g, 당귀, 복령, 숙지황, 천궁, 진피, 자감초 4g, 승마, 생강 3g
- 설명: 益氣養血, 健脾補腎
- 적용: 治氣血兩虛

5) 간신음허(肝腎陰虛)

증상	形體消瘦, 五心煩熱, 頭暈耳鳴, 腰膝酸軟, 遺精帶下, 盜汗, 舌紅或絳, 少苔, 脈弦細 : 오심해서 전체적으로 열이 나는 경우는 거의 없음, 손발 등 일부만 열
병리	痺阻日久, 正虛邪戀, 肝腎陰虛, 虛火擾絡
치법	滋陰益腎, 降火生津
치방	지백지황환가감

🔑 지백지황환가감(知柏地黃丸加減)

- 구성: 건지황, 숙지황 24g, 사삼 20g, 구기자 15g, 지모, 백작약 12g, 황백, 목단피, 산수유, 맥문동, 진피 10g, 오미자, 택사 6g
- 설명: 滋陰益腎, 降火生津
- 적용: 治肝腎陰虛

16

암

☞ 암(종양)이란?

Tumor	양성 종양과 악성 종양으로 분류
Cancer	악성 종양
Carcinoma	악성 상피세포암 ex) 위, 폐, 유방, 자궁, 피부 등
Sarcoma(육종)	뼈, 근육에서 발생하며 carcinoma보다 악성
혈액암	백혈병, 임파종 등

☞ 암의 유해

국소적 유해	전신적 유해
①塊를 형성하여 가압통증 유발	① 전신적 쇠약증
② 중추와 말초의 신경장애 유발	② 철결핍성 빈혈
③ 국소 조직의 괴양 유발	③ 골수 파괴 (빈혈, 감염, 내출혈)
④ 각 부위의 유통로를 폐색시킴	④ 혈전인자 유리시켜 혈관 폐쇄
⑤ 염증을 유발함	⑤ 혈액 점도 증가: 혈류 장애
⑥ 부종	⑥ 알부민 결핍: 부종
-	⑦ 근, 골 분해로 혈중 칼슘 농도 증가
	⑧ 호르몬 분비 교란
	⑨ 면역 결핍 증상

☞ 발암과정

1) 암 유발 초기 단계	① 암 유발인자(예, 담배)의 장기적 자극으로 정상 세포 1개가 돌연변이 되지만 정상세포로 계속 증식 생존함
	② 담배 계속 피우면 결국 비정상 세포로 변하지만 암은 아님
2) 발암 촉진 단계	① 담배 끊으면 돌연변이 세포는 없어 질 수가 있음
	② 담배 계속 피우면 재차 돌연변이 세포가 되면서 조기암 세포로 변함
	③ 조기 암 세포가 되면 대부분 악성 암으로 진전함
	④ 초기 발생 암은 1ng 정도이나 10~20년간 1억 회 분열 후 1mg이 됨

☞ 정상세포와 암세포

정상세포	암세포
일정 패턴 분열 증식	멋대로 분열
동료 세포 모두 동일	세포마다 크기 모양 다름
특수 기능 유지	기능상실, 증식기능만有
세포 간 대화 협동	세포 간 협동 연락 없음
일정 영역 고착 증식	여러 곳으로 이동 증식
면역계 보호 작용	면역계 파괴
이웃 세포 위해 필요 시 자살	자살 유전자 상실
일정 분열 지속 후 사망	영구적 분열 증식

☞ 암의 예방

① 균형식 섭취	② 황록색 야채, 과일, 섬유식	③ 우유와 된장을 권장
④ 비타민 A, C, E 섭취	⑤ 표준체중 유지 저지방식, 과식 절제	⑥ 짜고 맵고 뜨거운 것 피함 태양 자외선 피함
⑦ 훈제 생선 피함 곰팡이, 부패 음식 피함	⑧ 과음 금지 / 금연	⑨ 운동: 땀 날 정도 스트레스 피하고 기쁜 마음 유지
⑩ 몸을 청결하게 유지 발암물질 함유 제제 피함	⑪ 방사능 피함	⑫ 호르몬 요법 주의점 파악
⑬ 발암성 병원균 피함: H. pylori(위장병), Papilloma virus(성병)		

☞ 암환자의 정신심리

- 암 발견부터 사망 시까지 5단계 심리변화를 보임
- 단계에 따라 환자를 이해하고 대화법을 구사해야 함

① 충격단계	내가 암에 걸리다니
② 부인단계	진단이 틀렸을 거야
③ 분노단계	만사를 부정적으로 판단
④ 우울단계	몸이 초췌해지고 통증 심함, 성기능 상실, 우울, 불안, 불면 증 등 정신증상 나타남
⑤ 수용단계	죽음을 각오하고 종교에 귀의하는 등 차분히 준비

☞ 암환자와 가족의 교육 포인트

- ① 사망 선고를 받은 환자를 제외한 치료 중인 환자에게 암은 완치될 수 있음을 인식시켜야 함
- ② 암은 숨기지 말고 알릴 사람에게는 알리도록 함
 - 가능한 친구나 종교단체가 적극 방문하여 위로해 주어야 함
 - 심층적인 대화 가능한 전문인을 선정하여 대화를 시켜야 함
- ③ 치료시마다 환자와 전문인은 다음 사항을 대화할 수 있어야 함
 - 육체적 변화 상태, 성기능 상태, 심리적 변화 상태
- ④ 암 치료 중에도 인생을 가능한 즐겁게 향유하며 적극적으로 사회 참여 할 수 있게 해주어야 함
- ⑤ 사랑하는 자의 적극적 간호가 필요함, 환자는 성적 욕구가 강렬함, 간호하는 측에서 솔선해주지 않으면 우울에 빠지고 난감하게 됨
- ⑥ 신을 적극 의지하게 함
- ⑦ 암의 병리과정 치료 과정, 치료 효과, 부작용 등을 교육시켜야 함

☞ 정신 심리요법의 이점

- ① 호르몬계와 면역계와 신경계는 뇌의 의식적 사고에 따라 상호적으로 지배되고 있음
: Psycho-neuro-immuno-endocrinology 언급 X
- ② 소망적 사고와 즐거운 감정은 병태 생리를 치유의 방향으로 가속화시키며 제반 증상을 완화시키거나 제거할 수 있음이 입증되고 있음

☞ 항암제의 부작용

☞ 항암제의 부작용에 대해 기하시오 06

- ① 인체 정상 세포의 파괴 ② 골수 장애: 백혈구 감소(감염 유발), 적혈구 감소(빈혈), 혈소판 감소(내출혈)
- ③ 탈모 ④ 구토 ⑤ 설사 ⑥ 신경 장애

17

癌痛 암통

☞ 암통

특징	① 종양의 압박, 침범을 받은 조직신경에서 발생하는 통증 ② 초기: 통증 별로 없음 ③ 말기: 통증 발생 많음 마약성 진통제 사용 증가, 통증관리중요 ④ 대부분 지속적인 통증임, 병소가 커짐에 따라 심해짐 ⑤ 휴식과 수면 방해 ⑥ 통증제거는 말이기 암환자의 삶의 질 개선과 생존기간의 연장에 중요함
분류	① 국소형: 통증 위치 고정 ② 미만형: 통증 부위 불명확함

☞ 암통의 치료처방

☞ 암통의 치료에서 사용할 수 있는 처방을 기하시오 (3가지 이상) 05

: 철통방, 유물현작탕, 암통령, 지통항암방, 가미작약감초탕

18

암 치료 효과 판정

著效	모든 병태가 4주 이상 사라진 경우
유효	암 크기 30-50% 감소, 4주 이상 지속
불변	암 크기 감소 25% 이하
진행	암 크기 25% 이상 증가
[참고] 5년 생존: 암 치료 후 5년 생존률은 영구적 치유 가능성을 의미	

II. 장옹

1

장옹이란?

- ☑ 腸癰 = 縮脚腸癰 (요새의 맹장염 증상과 유사): 장옹이 생기면 다리를 펴지 못하고 오므리고 있기 때문
- 장에 통증과 부종을 야기하는 內癰 질환
 - 熱毒이 안에 모이고 어혈이 장에 뭉쳐서 癰膿(붓고, 종기, 고름)이 발생하는 병증
 - 임상 특징: 오한발열, 少腹腫痞, 疼痛拘急
 - 범주: 충수염, 복막염, 골반염증, 골반농양
 - 옹의 4대 증상: 紅熱腫痛 (발적, 열, 붓고, 아픔)

2

병인병리

① 飲食不節 ② 勞傷過度 ③ 外邪侵襲 ④ 情志所傷

→ 장관의 氣滯血瘀를 유발하고 어혈의 정체를 일으키는 모든 원인은 腸癰의 발병과 관련 있음

음식부절 (飲食不節)	• 폭음폭식, 膏粱厚味 향신료 or 맛이 진한 음식들 • 恣食生冷產後, 早食涼物, 飲涼茶 : 산후에 너무 일찍 차가운 것, 날 것 or 차가운 차를 일찍 마심 • 行經時 貪涼: 월경 시 차가운 것을 먹거나 몸을 차게 함 ↳ 이런 것들은 腸胃痞塞, 運化不通, 氣血凝滯而成
노역과도 (勞傷過度)	• 用力過度, 急暴奔走, 跌仆損傷, 飽食後 負重奔走, 產後, 勞動過早: 힘을 과하게 쓰고, 갑자기 달리고, 미끄러져 다치고(타박상), 식후 무거운 것을 지고 달리거나 걷기, 산후에 너무 일찍 노동을 함 ↳ 이런 것들은 損傷腸絡하여 瘀血凝阻於腸中而成하게 됨
외사침습 (外邪侵襲)	• 寒溫不調 脾胃虛弱 外邪乘虛侵襲 / 寒濕爲最: 추위나 더위를 조절하지 못하고, 실내온도가 적당하지 못할 때 추울 때, 비위가 허약하면 몸으로 침입함 • 한습으로 인한 것이 가장 많다. ↳ 氣機失調 → 經絡受阻 → 氣滯血瘀 → 瘀血阻滯而成
정지소상 (情志所傷)	• 喜怒不節, 憂思驚恐: 근심 걱정, 두려움 등이 많음 ↳ 腸胃痞塞, 運化失常, 氣血凝滯而成

3

진단근거

- ① 少腹痛, 腹皮緊急, 按之痛甚: 소복통, 뱃가죽 팽팽, 누르면 통증 심해짐
- ② 발열, 오한, 自汗(식은 땀) 수반
- ③ 혹 腿縮難伸: 다리를 오므리고 펴지 못함(통증)

4

장옹의 종류

1) 小腸癰(소장옹)	臍左疼痛, 左腿不能屈伸 : 배꼽 왼쪽이 아프면서 왼쪽다리 굴신 못함
2) 大腸癰(대장옹)	臍右疼痛, 右腿不能屈伸 : 배꼽 오른쪽이 아프면서 오른쪽다리 굴신 못함 ↳ 제일 多, 충수염, 맹장염과 관련 많음
3) 盤腸癰(반장옹)	繞臍生瘡, 或膿從臍中出 : 배꼽 주위에 종기(부스럼)가 생김, 혹은 고름이 배꼽으로 나오기도 하는 것

5

아동과 노인 장옹의 주의점

- 1) 아동
- ① 稚陽之體: 어린 아이들은 양기가 많지만 완전히 성숙한 양기가 아니라 주의해야 함
 - ② 起病較急: 발병 비교적 빠름
 - ③ 복통, 발열 극렬
 - ④ 變證較多: 변증이 비교적 많음
 - ⑤ 病情을 정확히 진술X

☞ 장옹의 범주에 속하는 양방병명을 기재하시오 (4개 이상) 99
답) 충수염, 복막염, 골반염증, 골반농양

☞ 장옹의 병인병리 4가지를 쓰시오 06
답) ① 飲食不節 ② 勞傷過度 ③ 外邪侵襲 ④ 情志所傷

☞ 소장옹과 대장옹의 차이에 대해 쓰시오 12

☞ 배꼽 왼쪽 부위가 아프고 왼쪽 다리를 굴신하지 못할 때 병은? 19 탈기
① 대장옹 ② 소장옹 ③ 반장옹 ④ 위옹 ⑤ 방광옹

2) 노인

- ① 正氣虧虛: 정기가 허약함
 ② 발병증상이 명확하지 않아 초기에 진찰받는 경우 적음 → 감각이 둔하고 여러 증상을 표현하지 못하기 때문
 ③ 全腹部隱痛(전복부가 은은히 아픔), 右少腹痛(오른쪽 소복의 통증)의 특징 불명확
 ④ 癰膿易潰 중기고름이 쉽게 터짐

6

감별진단

1) 胃痛	胃脘痛. 吐酸, 噯氣, 嘈雜 (수반 부위가 다름)
2) 蟲痛 요새 거의X	- 아동에게 많음, 臍周痛 - 발작성 隱痛 혹은 絞痛, 통증 부위 넓음 (요새는 거의 없음)
3) 淋證 비뇨기 증상	- 小便頻數短澀, 少腹拘急, 痛引臍中 - 滴瀝刺痛: 뚝뚝 떨어지거나 찌르듯이 아픔 - 欲出未盡: 잔뇨감
4) 疝氣(腹疝)	- 腹中攻築作痛(내리치는 듯한 통증), 按引上下 - 국부에서 腫大한 덩어리(장관과 내용물)가 만져짐 - 산통이 배에만 나타나는 경우 감별이 필요함

7

장옹의 치료원칙

1) 通裏攻下 (통리공하)	六腑以通爲順, 腸癰爲腑症: 육부가 소통이 잘 되어야 정상적인 기능을 유지함
2) 清熱解毒 (청열해독)	(장옹은) 實證과 熱證이 많음 - 積滯, 瘀血, 外邪는 모두 열을 유발함
3) 活血化瘀 (활혈화어)	不通即痛: 소통이 안 되면 통증이 있으므로 잘 통하도록 어혈 제거해야 함 (허증통증: 不營則通)
[참고] 虛證(만성), 寒證의 장옹: 溫陽散結, 破瘀排膿	

8

장옹의 변증시치

- ① 瘀滯證(어체증): 癰膿未成, 氣血瘀滯 - 고름이 아직 형성 X 기혈 막힘
 ② 蘊熱證(온열증): 癰膿已成, 瘀滯化熱 - 고름 이미 형성, 어혈이나 기체가 열을 발생시킴 (화열 = 화생)
 ③ 毒熱證(독열증): 癰膿已潰, 熱毒熾盛 - 고름이 터져서 천공, 열독이 치성
 ④ 虛寒證(허한증): 慢性腸癰, 膿成陽虛 - 고름이 성하고 양허증상 (만성장옹)

1. 어체증(瘀滯證)

증상	腹痛陣作(아팠다 안 아팠다) 按之加劇(누르면 더 심해짐) 腹皮微急(뱃가죽 긴장됨) 脘腹脹悶(완복 더부룩) 噯氣納呆(트림, 납매) 惡心欲吐(오심, 구토) 대변정상 or 비결 발열오한 약간 있음
舌脈	舌質 정상 혹은 暗紅, 舌苔薄白 혹은 薄黃, 脈弦緊
치법	通裏攻下(主), 清熱解毒 & 活血祛瘀(佐)
치방	대황목단피탕

🔍 대황목단피탕(大黃牡丹皮湯) = 大黃湯

- 구성: 대황, 망초 6g, 목단피, 도인, 과루인 10g
- 설명: 可下之: 설사시키는 처방
 - ① 대황: 瀉熱毒, 瀉積滯, 行瘀血 ② 망초: 攻下泄熱 ③ 도인, 동과인: 去瘀散結
 - ④ 목단피: 涼血解毒 ⑤ 과루인: 散結消癰
- 적용: 治腸癰, 脈遲緊, 膿未成

📌 노인장옹의 특징을 쓰시오 12

📌 산기와 장옹의 감별점은? 19 탈기

- ① 고환이 붓고 아프다.
 ② 오한, 발한이 있다.
 ③ 소변이 나가지 않는다.
 ④ 신물과 트림이 나온다.
 ⑤ 국부에 압통이 있다.

(복원이 잘못된건지 ,답이 정확하진 않습니다..)

📌 六腑以通爲順, 腸癰爲不症의
 치료법으로 옳은 것은? 02 03 07 08
 09 10 12 14 18

- ① 청열해독 ② 통리공하 ③ 활혈화어
 ④ 온양산결 ⑤ 파어배농

📌 급성장옹의 치법을 모두 고르시오 11
 가. 통리공하 나. 청열해독 다. 활혈화어
 라. 온양산결
 답) 가, 나, 다

📌 급성 복증 중 실증과 열증이 많고,
 積滯, 瘀血, 外邪는 모두 열을 유발하는
 것의 치료법으로 옳은 것은? 19 탈기
 ① 통리공하 ② 파어배농 ③ 청열해독
 ④ 온양산결 ⑤ 청열해독(복원오류인듯)

📌 腸癰의 주된 병기는 熱毒瘀結腸中이고,
 변증은 일반적으로(瘀滯證),(蘊熱證),
 (毒熱證)의 세 유형으로 나누고, 치료는
 (通裏攻下),(清熱解毒),(活血化瘀)
 을 大法로 한다. 99

📌 40세 남자가 복통, 누르면 통증 심해
 짐, 오한, 발열, 구토, 대변 정상 혹은 비결,
 설질암 있음. 치료법은? 18 19

- ① 통리공하 위주 청열해독, 활혈화어로 보좌
 ② 통리공하, 청열해독 위주, 활혈화어 보좌
 ③ 먼저 통리공하 이후 청열해독 활혈화어
 ④ 청열해독 활혈화어를 주로 하고 통리공하로 보조
 ⑤ 활혈화어를 주로 하고 청열해독, 통리공하로 보조

2. 온열증(溫熱證)

증상	복통이 瘀滯型보다 극열함 腹皮繃急: 배가 많이 긴장함 拒按: 누르면 더 아픔 右少腹(오른쪽 아랫배)에서 腫塊(덩어리) 촉진 구토, 便滯 不爽(濕熱) 壯熱, 自汗, 大便祕結, 小便 短赤(熱盛) 혹은 胸脘痞悶, 腹脹
舌脈	舌紅, 苔黃糙, 脈弦數(열성). 苔黃膩, 脈滑數(습열)
치법	通裏攻下, 清熱解毒(主), 活血化瘀(佐)
치방	선방활명음 + 대황묵단피탕

🔑 선방활명음(仙方活命飲) = 眞人活命飲

- 구성: 금은화 12g, 당귀미, 조각자, 진피, 천산갑(燒) 6g, 유황, 패모, 천화분, 백지, 적작약, 甘草節 4g, 방풍 3g, 몰약 2g 酒煎服
- 설명
 - 仙方: 仙人所傳之方, 功效神奇 신선이 전해준 처방처럼 효과가 아주 신기하다
 - 活命: 定痛回生 통증을 멎게 해서 다시 살게 함
 - 消毒之聖藥
 - 瘡瘍 초기의 習用劑 습관적으로 먼저 선택해서 쓰는 처방
 - 酒煎服 술로 달여서 복용
- 적용: 治 一切癰疽毒腫, 未成者內消, 已成者即潰, 排膿止痛

3. 독열증(毒熱證)

증상	- 복통극심, 彌漫至全腹部, 腹皮繃急 - 手不可近: 뱃가죽 긴장되어 손을 대지 못하게 함 - 心下滿硬, 腹脹, 矢氣不通, 壯熱 - 口乾唇燥(입술이나 입이 마르고), 面紅目赤, 嘔吐不能進食, 小便赤澀
舌脈	舌質紅絳, 舌苔黃糙(누렇게 거침) 或黃膩, 脈洪數
치법	通裏攻下(先), 清熱解毒, 活血化瘀(後)
치방	복방대승기탕, 대함흉탕, 백호탕, 가감해독탕

🔑 복방대승기탕(複方大承氣湯)

- 구성: 후박, 나복자(炒) 15-30g, 지각, 적작약, 대황 15g, 도인 9g, 망초(沖) 9-15g
- 설명: 通裏攻下, 行氣活血
- 적용: 治 一般性腸閉塞, 屬于陽明腑實, 而氣脹較明顯者 (양명부실증에 속하는 장폐색에 쓸 수 있음)

🔑 대함흉탕(大陷胸湯)

- 구성: 대황 12g, 망초 8g, 감수(가루) 2g
- 설명: 瀉水逐飲, 消腫散結
- 적용: 治大結胸, 心下至少腹硬滿而痛, 不大便 | 대결흉 | 습성 늑막염 | 복막염
+ 심하(명치)에서 아랫배까지 꼭 찬 것 같고 단단하고 아프고 대변이 안 나옴

🔑 가감해독탕(加減解毒湯)

- 구성: 포공영 15g, 목단피 7.5g, 적작약, 치자, 후박 6g, 황련, 황백, 대황, 당귀, 우슬 5g
- 설명: 清熱解毒, 理氣祛瘀
- 적용: 治熱毒熾盛, 腹痛極烈

4. 허한증(虛寒證) - 만성장음

증상	- 少腹微急, 隱痛拒按, 身無大熱 - 按之則軟: 눌러보면 덩어리 부드러움 - 肌膚甲錯: 피부가 거칠게, 하얗게 일어남
舌脈	舌質淡暗, 苔白膩 或黃, 脈細數無力
치법	除濕排膿, 振奮陽氣: 양기를 끌어올림
치방	의이부자패장산, 목단산, 패장탕

🔑 의이부자패장산(薏苡附子敗醬散)

- 구성: 의이인 10g, 패장 6g, 부자(炮) 2g
- 설명: 溫陽散結, 破瘀排膿, 利尿, 진통, 鎮痙, 鎮咳 / 패장(소염, 解凝, 배농, 이뇨, 祛瘀. 除癰腫)
- 적용: 治腸癰, 身無熱, 腹濡冷: 장음 증상, 열이 없으면서 배가 부드럽고 차가움
+ 治筋急拘攣: 힘줄이 당겨서 오그라들어, 不可屈伸: 펴지 못함 / 治贅疣: 근육경련, 사마귀

🔑 목단산(牧丹散)

- 구성: 목단피, 인삼, 천마, 백복령, 황기, 의이인, 도인, 백지, 당귀, 천궁 4g, 관계, 감초 2g, 목향
- 설명: 천마 - 消癰腫(벌록) 웅증을 소산시킴
- 적용: 治腸癰冷證(장음의 냉증을 치료하는 약), 腹軟而痛, 時下膿血

📖 35세 여성이 배가 아파서 내원하였다. 뱃가죽이 매우 딱지고 오른쪽 아래에 종괴가 만져지며, 고열이 있고, 대변이 비결하고, 소변이 붉고 짙다. 설질홍, 태황조, 맥현수하다. 어떤 상태의 장음인가? 19 탈기

- 열이 쌓인 증후로 고름이 이미 생김
- 열독 형성 중기로 고름이 이미 터짐
- 어혈이 막힌 증후로 종기에 고름이 있음
- 만성 고름으로 양허
- 음냉으로 고름이 생김

📖 장음의 치료법으로 옳게 연결된 것은? 17

- 온열증 - 청열해독 위주로 치료하고, 통리공하, 활혈화어를 더한다.
- 어체증 - 통리공하 위주로 치료하고, 청열해독, 활혈화어로 보좌한다.
- 독열증 - 청열해독, 활혈화어한 이후 통리공하한다. → 통리공하 먼저
- 허한증 - 청열해독과 배농부장을 함께 한다.
- 장음성옹 - 청열해독, 활혈화어하고 통리공하는 하지 않는다. → 모두 함

🔑 패장탕(敗醬湯)

- 구성: 패장 20g(균약), 의이인, 당귀 8g, 백작약, 천궁 4g
- 설명: 性平
- 적용: 腸의 癰腫, 潰瘍 등 외과질환을 다스림

9

역대 장옹의 분류와 치료

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) 未有膿之腸癰: 아직 고름이 생기지 X | 脈遲緊. 대황목단피탕, 도인승기탕 |
| 2) 已有膿之腸癰: 이미 고름이 생긴 장옹 | 脈洪數. 삼인탕 |
| 3) 虛冷之腸癰: 허한증, 허냉증의 장옹 | 목단산, 의이부자패장산, 십선산 + 복령 |
| 4) 下膿之腸癰: 이미 터진 고름 | 蠟礬丸, 雲母膏 |

🔑 삼인탕(三仁湯)

- 구성: 의이인 12g, 동과인 10g, 도인, 목단피 8g
- 적용: 治腸癰成膿 장옹의 고름이 형성된 경우
 - 胃癰과 腸癰으로 인한 복통, 흥민, 변조, 복부창만, 不能食, 소변불리 / 충수염이 의심되는 경우

🔑 십선산(十宣散) = 內托十宣散

- 구성: 인삼, 황기, 당귀, 후박, 길경, 관계, 천궁, 방풍, 백지, 감초 4g
- 설명: 消惡肉, 止痛生肌
- 적용: 治一切癰疽瘡癤, 已成潰潰, 未成速散, 敗膿自出 / 허한 장옹에 쓸 수 있음

🔑 납반환(蠟礬丸)

- 구성: 황랍 80g, 백반(가루) 160g
- 설명: 護膜解毒止痛 / ① 백반: 收斂止血消毒 ② 황랍: 지혈
- 적용: 治腸癰, 解毒內消, 治癰疽惡瘡
(초기에 열 있으면서 홍열중통의 염증증상이 있으면 사용 X)

📖 【脈洪數者, 膿已成, 不可下?】 금궤요략

장옹에서는 맥이 홍삭하니(열독치성) 농이 이미 형성된 것이기에下해서는 안 된다?

→ 옳은 말이 아님

【腸癰成膿】

- 氣血瘀滯, 熱毒熾盛의 단계
- 熱盛肉腐(열이 성해서 살이 썩는 것)는 "청열해독, 활혈화어"만하고 "通腑" 하지 않으면 取效가 어려움 = 통리공하도 해야함)
- 膿은 유형지물이니 通腑해야 함 (대황으로 통리공하 해야함)
- 膿未成이든 已成이든 通下할 수 있음
- 重用大黃

10

장옹의 예방

- ① 飲食有節
- ② 勞逸適度: 노동과 휴식의 균형
- ③ 情緒舒暢: 마음이 조급하지 않도록 정서 조절
- ④ 病後調養: 특히 산후와 월경 중 調攝에 주의함

11

장옹의 조리

- ① 와상휴식
- ② 음식금기: 유동식, 맵 고 기름지고 찬 것을 금함, 毒熱症 환자는 금식
- ③ 주의관찰: 체온, 혈압, 脈象, 舌象, 대변횟수와 상태, 정신상태, 특히 腹部體徵에 주의
- ④ 용약횟수: 중증은 1일 4회 복약
- ⑤ 보조치료: 침구, 관장, 수액

📖 수승화강

- 水不勝火면 身中賊이니 熱不能煩엔 心上工하라
: 수불승화면 몸속의 도적이니 열(번열)을 견디지 못하는 것엔 마음 다스리는 것을 가장 높은 방법으로 삼아 치료한다.
- 간울화화, 아래 쪽은 차가움, 위 쪽으론 뜨거움 → 수승화강의 방법을 써서 치료함
- 우리 몸의 자율신경이 문란해지는 것은 수승화강이 흐트러져서 발생하는 경우가 대부분

☺ 장옹에는 허증과 한증이 있는데 이 때 사용할 수 있는 처방은? 18

- ① 대황목단피탕
- ② 선방활명음
- ③ 백호탕
- ④ 대함홍탕
- ⑤ **목단산**

☺ 虛冷之腸癰을 치료하는 처방은? 03

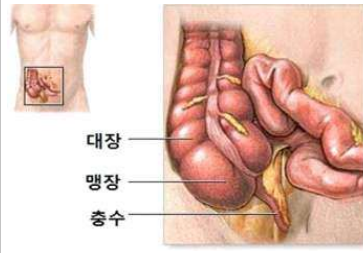
답) 목단산, 의이부자패장산, 십선산 + 복령

☺ 未有膿之腸癰하고, 脈遲緊할 때 사용할 수 있는 처방을 기하시오. 05

답) 대황목단피탕, 도인승기탕

12

충수염이란?



맹장 끝에 붙어 있는 약 10cm 길이의 충수돌기에 생기는 염증 : 맹장염, 충양돌기염, 충수돌기염이라고 하기도 함

- ① 전 인구 7-12% + 20 - 30대에 가장 흔함
- ② 남자 > 여자 : 1.3-1.6배
- ③ 원인: 장 결석, 과일 씨, 바름, 기생충 등의 이물질이 충수에 들어가 충수를 폐쇄시켜 일으킨 염증
- ④ 병태: 폐쇄된 충수 내에 산소가 없어지면 혐기성 균이 증식하여 염증 유발

☞ 충수염을 진단할 수 있는 진단요점에 대해 기하시오. 99 05

13

충수염의 진단 요점

- ① 복통
- ② 식욕부진, 구역, 구토
- ③ 국한성 복부압통
- ④ 미열
- ⑤ 적혈구 증가

☞ 충수염의 진단요점과 전형적인 증상에 대해 기하시오. 10

☞ 충수염의 전형적 증상은? 12 13 15

☞ 충수염의 진단 기준으로 옳지 않은 것은? 17

- ① 복벽 근육 경직 및 우하복부 피부 과민감각
- ② 식욕부진
- ③ 구역 구토
- ④ 백혈구 증가
- ⑤ 고열

☞ 충수염에 대한 신체검사로 옳은 것은? 18 19

- ㄱ. 미열
- ㄴ. 복벽근육 경직 및 우하복부 피부 과민감각
- ㄷ. 맥버니 포인트
- ㄹ. 직장수지검사상 좌측 부위 압통
- ① ㄱㄴㄷ ② ㄱㄹ ③ ㄴㄹ ④ ㄹ
- ⑤ ㄱㄴㄹ

☞ 충수염 검사 중 McBurney's point를 잡는 방법에 대해 기하시오. 06 07 09

☞ McBurney's point란? 12 14

14

충수염의 신체 검사

- 1) 발열: 미열 → 심한 고열 아님 ☞ 충수염의 신체검사에 대해 기하시오 08
- 2) 우하복부 압통(McBurney point) 및 反癰癰 (체위변동에도 압통점 불변)
- 3) 복벽근육 경직 및 우하복부 피부 과민감각
- 4) 직장수지검사상 우측 부위 압통
- 5) Rovsing's sign, Psoas sign, Obturator sign

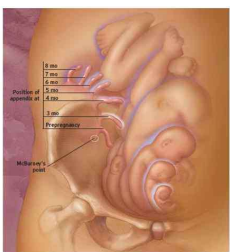
McBurney's point	- 급성충수염 특유의 압통점 - 우측 상장골극과 배꼽을 연결하는 선상에서 장골극으로부터 1.5 - 2 인치 거리에 위치 - 정상상태에서는 충수의 기저부에 해당함	
Rovsing's sign	충수염에 있어서 McBurney 점에 대칭적인 복벽(좌측)에 압력을 가하면 맥버니 점에 특징적인 격통을 느끼는 징후	
Psoas(요근) sign	반듯이 누워 오른 다리를 뻗고 검사자가 다른 다리(왼쪽)를 누른 상태에서 다리를 들어 올릴 때 요근에 통증을 느끼는 징후	
Obturator sign	환자가 오른 무릎과 hip을 구부린 상태에서 검사자가 다리를 회전시키면 통증이 유발되는 징후	

15

진단의 문제점

- 1) X-Ray나 CT로는 충수염을 명확히 진단하기 어려움
- 2) 증상 기준으로 진단하여 수술함: 수술 시기 놓치면 충수 파열로 복막염 유발되기 때문
- 3) 어린이와 노인: 증세가 심하지 않기 때문에 오판 가능성 많음 (오진율: 15%)
- 4) 충수염으로 개복 수술한 경우: 10-20% 정상

cf) 임신 중 충수염



: 임신부의 배가 불러오면 맥버니 포인트도 위치가 변화함 (위로 올라가게 됨)

16

진단의 중요성

- ① 충수 천공과 천공 이전은 수술 환자의 예후에 큰 영향을 미침 (천공 되기 전에 치료를 해야 함)
- ② 천공 전 수술: 사망률 0%
- ③ 천공 후 수술: 100명중 1명 사망, 노인의 경우 사망률 15%
- ④ 발병부터 천공까지의 시간: 24~36시간
- ⑤ 발병 후 24시간 이내 수술을 원칙으로 함

17

감별진단

- 1) 위장염, 대장염
- 2) 여성 골반 내 질환: 난소소포 파열, 골반 내 염증, 자궁외임신
- 3) 비뇨생식기 질환: 수뇨관 결석, 신결석, 신우신염
- 4) 기타 급성 복증: 소화성 궤양 천공, 급성 담낭염, 급성 췌장염, 장폐색증

18

합병증

- 1) 천공(perforation) 2) 복막염(peritonitis) 3) 충수농양(appendiceal abscess)
- 4) 복강내 농양(abdominal abscess) 5) 문맥염(pylephlebitis)

19

충수염과 항생제

case1	case2
📍 콜럼부스소아병원 • 7~17세 102명 관찰 • 수술 65명: 효과 89% 기간 21일 • 비수술 37명: 76% 기간 8일 • 후유증 차이 없음	📍 핀란드 투르크대학 • 18~60세 530명 • 무작위로 분류한 그룹 수술, 한 그룹 항생제 10일간 투여 • 수술: 99.6% 효과 • 항생제 1년 관찰: 72.7% 효과, 27.3% 수술, 후유증 無

🔍 맹장의 역할 맹장 = 충수

- ① 맹장: 유익한 박테리아 저장고, 면역체계 유지 기여
- ② 맹장 제거한 사람: 몸에 이로운 박테리아 모두 빠져나감 → 질병 회복시간 길어짐
- ③ 맹장이 있는 동물: 내장 내 림프조직 밀도 높음
+ 면역체계에서 중요한 역할, 림프조직은 유익한 박테리아 성장 자극
- ④ 유익한 박테리아가 맹장에 보관됨: 설사병 나도 소실 안 됨 (애리조나 미드웨스턴대)

20

충수염의 한약처방

🔍 가미정리탕(加味正理湯)

- 구성: 창출 6g, 소엽, 향부자, 자실, 나복자 4g, 진피, 반하, 복령, 후박, 곽향, 목향, 감초 3g, 대황 4~8g, 도인 4~6g, 과루인 4~12g, 목단피 12g, 생강 4g
- 적용: 급, 만성 맹장염
- 화농성 충수염, 천공성 충수염: + 의이인 20g, 패장 8g, 금은화 28g

🔍 의이인탕(薏苡仁湯)

- 구성: 금은화 20g, 포공영, 패장, 과루인 12g, 목단피, 현호색 8g, 대황, 도인, 소회향 4g
- 설명: 消炎, 排膿, 破瘀血
- 적용: 충수돌기염, 한국성 복막염, 류마티스관절염 + 모든 부종, 즉 濕熱과 어혈이 병발한 증후에 응용

📖 충수염의 합병증에 대해 3가지 이상
기하시오 06

📖 맹장에 대한 설명이다. 옳지 않은
것은? 19 탈기

- ① 유익한 박테리아의 저장고이다.
- ② 맹장을 절제한 환자는 질병의 회복시간이 짧다.
- ③ 맹장은 면역체계에서 중요한 역할을 한다.
- ④ 맹장이 있으면 내장 내 림프조직의 밀도가 증가한다.
- ⑤ 림프는 유익한 박테리아의 성장을 돕는 역할을 한다.

Ⅲ. 탈항

01

탈항이란?

- 일명 腸痔, 脫肛痔, 盤腸痔
- 肛門脫出也(제병원후론)
- 직장이 항문 밖으로 탈출하는 질환
- 현대의학의 '직장탈'과 유사
- 古名 脫肛: 직장탈출, 痔脫出(치질), 息肉脫出을 포함하여 설명

02

병인병리

- 허증: 氣虛下陷, 關門^{항문}失守
- 실증: 熱下墜(습열이 아래로 물림) 飲食失當(음식을 적절히 섭취 X)
 - 肺與大腸爲表裏 / 胃爲六腑之大源 / 脾爲肺之母氣 / 腎開竅於二陰
→ 故로 폐, 비, 신, 위의 병변은 대장에 직접적인 영향을 주어 탈항을 발생

1. 氣虛下陷^{기허하陷}, 關門失守^{관문실수}

- 氣虛脫肛의 병리
- 素體虛弱, 中氣不足 / 勞力耗氣 / 飢飽不勻 / 思慮傷脾 久病之後 / 氣虛不復 → 이런 경우에 생김

소아	• 先天不足(선천부족) • 後天失養: 허약감이 타고나기도 했고 후천적으로 영양을 제대로 섭취 못해서 발생 • 久咳久瀉: 기침이나 설사가 오랫동안 낫지 않음 • 脾腎氣虛: 비신의 기가 허해짐
노인	• 腎氣不充: 신기 충분 X • 房勞傷腎(방로로 신기 손상) / 精虧氣少, 損傷真元 • 苦寒攻伐失當: 황련해독탕 등과 같은 고한한 약으로 원기가 손상됨
부인	• 分娩過多: 출산을 많이 함 • 產時過度用力: 출산 시 힘을 지나치게 많이 씀

2. 飲食失當^{음식실당}, 濕熱下墜^{습열하추}

- : 음식을 적당히 섭취하지 않아 습열이 아래로 물림 → 濕熱脫肛의 원인이 됨
- 飲食不節, 恣食辛辣厚味
 - 飲酒取醉

03

감별진단

- 痔瘡^{치창}: (=치질) 항상 극렬한 동통과 출혈이 있음
- 內痔^{내치}: 치핵이 돌출
- 外痔^{외치}: 항문에 이물감이 있어 탈항과 착각하기 쉬움
- 脫肛^{탈항}: 대개 통증과 출혈이 없음, 다만 직장이 항문 밖으로 빠져 나옴

04

변증요점

1. 허실감별

허증	• 형체허약, 面色皸白, 권태무력, 頭暈心慌, 항문탈출 • 無疼痛赤腫: 통증, 발적, 부종이 없음 • 舌淡, 脈弱(맥은 약하고 설은 담백하다: 핏기가 거의 없음)
실증	面赤身熱, 便乾尿赤, 肛門疼痛, 紅腫瘙癢, 舌紅苔黃, 脈數

2. 탈항의 危症

- 久病虛勞之人, 脫肛不收, 忽然神亂心慌, 冷汗如珠如油, 呼吸不能接續, 脈象如蛛網遊絲 元氣暴脫의 危症임
- : 구병, 허로운 사람에서 탈항이 들어가지 않고 갑자기 정신이 혼미해지면 가슴이 두근두근 뛰고 기름처럼 식은 땀이 나고 호흡이 이어지지 않고 맥상이 영겨있다.
→ 원기폭탈의 위증

☞ 탈항에 관여하는 장기 배합으로 옳은 것은? 11

- ① 간비신대장 ② 비폐심방광 ③ 폐비신위
④ 심폐신담 ⑤ 신간폐소장

☞ 탈항을 유발하는 장부 4가지를 기하시오. 06 13
답) 폐, 신, 비, 위

☞ 탈항과 관련관 장부는? 17

- ① 폐신비위 ② 간신편비 ③ 심간비위
④ 비위폐간 ⑤ 간심비폐

05

치료원칙

① **重在治本**: 근본을 치료하는데 중점을 두어야 한다.

- 만성 설사, 이질, 久咳(오랜 기침), 변비 등 기존 질환의 치료
- 虛者補之(허한 사람 보하고), 陷者升之(쳐진 사람 올리고), 脫者收之(빠진 사람 수렴시키고), 熱者清之(열이 있는 사람은 청열하기)

② **苦寒攻下の 慎用**

- 虛證이 많으므로 大下大利, 行氣破氣를 慎用. 濕熱證일지라도 中病即止 조심히 써야 함

06

변증시치

1. 기허하함(氣虛下陷)

증상	• 排便後肛門脫出. 若病久虛甚, 咳嗽行路排尿時 • 疲倦無力, 頭暈心悸, 食減便溏, 舌淡胖, 有齒痕, 脈弱 • 稍用力即脫出: 조금만 힘을 줘도 탈출 • 氣短聲低: 호흡이 짧고 목소리가 기어들어감
병리	氣虛下陷, 不能固攝
특징	脾肺氣虛의 증상
치법	補氣升提
처방	보중익기탕, 제항산

🔍 제항산(提肛散)

- 구성: 인삼, 백출, 천궁, 황기, 진피, 당귀, 감초 4g, 시호, 승마, 황금, 황련, 백지 2g
- 적용: 治氣虛, 脫肛下垂, 脫肛便血, 脾胃虛弱

2. 비신양허(脾腎兩虛)

증상	• 直腸滑脫不收, 肛門常有下墜感, 신피핍력, 行動氣促, 두훈심계 • 요슬산연, 소변빈삭, 야뇨 多, 대변건결, 설담, 맥세약
병리	고령, 或 虛勞日久, 脾腎雙虧, 정혈부족
특징	• 고령환자나 虛勞한 사람에게 많음 • 夜尿頻多(야뇨빈다)
치법	脾腎雙補(비신쌍보)
처방	대보원전 + 토사자, 육종용, 오미자 또는 + 녹용 (토사자, 육종용, 오미자: 固澁下焦)

🔍 대보원전(大補元煎)

- 구성: 인삼, 숙지황, 구기자, 산약, 두충 8g, 산수유, 당귀, 자감초 4g
- 설명: ① 인삼, 산약, 자감초: 補中益氣 ② 숙지황, 산수유, 구기자, 두충: 滋腎填精 ③ 당귀: 補血潤燥
- 性溫 / 補腎回陽, 益氣養血 / 肝腎陰虛 + 氣虛
- 過色嗜眠: + 황기, 백출
- 적용: 治氣血大壞, 精神失守, 危劇等證

3. 습열하추(濕熱下墜)

증상	• 항문작열종통, 면적신열(面赤身熱), 구건구취, 흥완비민, 복창변결, 소변단적 • 설홍, 태황니혹황조, 맥유삭
병리	濕熱蘊積, 結于腸道, 下逼直腸
치법	清火瀉熱利濕
처방	양격청장산

🔍 양격청장산(涼膈清腸散)

- 구성: 생지황, 백작약, 당귀, 천궁, 황금, 황련, 형개, 방풍, 승마, 향부자, 감초 4g
- 설명 1) 肛門腫痛, 灼熱刺痒: + 금은화, 황백, 괴화, 치자 2) 便結不通: 초결명, 대황
- 清火瀉熱利濕 ① 생지황, 황금, 황련: 涼血清熱燥濕 ② 향부자, 백작약, 당귀, 천궁: 調氣活血
③ 형개, 방풍: 祛風 ④ 승마: 解毒升提
- 적용: 治濕熱脫肛

☞ 탈항의 변증시치 3가지를 기하시오.

07 09

☞ 탈항의 변증시치 중 氣虛下陷의 증상, 병리, 치법, 처방에 대해 기하시오. 06

☞ 배변 후 항문이 밖으로 빠져나온다. 심하면 기침할 때나 걸을 때도 항문이 빠져나오기도 한다. 피로하고 힘이 없으며 호흡이 짧고 목소리가 낮다. 어지럽고 식욕이 없으며 변이 묽다. 설질담반하고 치흔이 있고, 맥약하다. 처방은? 19 탈기

① 대보원전 + 녹용

② 양격청장산

③ 제항산

④ 승양제습탕

⑤ 지각산

☞ 탈항의 변증시치 중 濕熱下墜의 증상, 병리, 치법, 처방에 대해 기하시오 05

☞ 탈항을 4가지로 분류하시오 07

☞ 허탈항 비폐기허 기 아래로 처짐에 쓰는 처방은? 18

- ① **삼기탕**
 ② 사물탕 가 백출 복령
 ③ 팔미원
 ④ 대보원전
 ⑤ 양격청장산

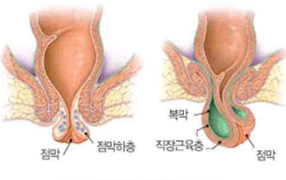
☞ 급하나 대변이 나오지 않고 항문에 종창이 있으나 들어가지 않는 것을 기취탈항이라고 한다. 처방은? 18

- ① 제항산
 ② 황기탕
 ③ **지각산**
 ④ 양격청장탕
 ⑤ 사물탕

☞ 탈항의 조리법에 대해 2가지 이상 기하시오 06

07	탈항의 분류
기허탈항 (氣虛脫肛) ▷ 其治有四	① 脾肺虛寒下陷: 삼기탕, 보중익기탕 + 저근백피, 가자 ② 血虛: 사물탕 + 백출, 복령 ③ 腎虛寒: 팔미원 ④ 臨產用力太過: 사물탕 + 인삼, 감초, 승마 氣虛脫肛이란 명칭보다는 '虛脫肛'이 좋을듯함 參芪湯 • 구성: 인삼, 황기(蜜炒), 당귀, 백출, 생지황, 백작약(酒炒), 백복령 4g, 승마, 길경, 진피, 건강(炒) 2g, 자감초 1.2g • 적용: 治肛門虛寒脫出, 肺腎虛者, 多有此證, 宜升之
열탈항 (熱脫肛)	• 熱脫肛, 其治有三 ① 氣熱: 條芩, 승마(6:1 비율)를 糊丸服 ② 血熱: 사물탕 + 황백, 승마 ③ 濕熱: 승양제습탕
활탈항 (滑脫肛)	① 瀉痢不止而滑脫: 설사나 이질과 같이 쭉쭉 빠져나오는 것 ② 처방: 위관전 + 오미자, 오매, 문합, 목향
기취탈항 (氣聚脫肛)	• 항문의 기가 모여서 탈항이 생기는 것 ① 氣聚不散, 裏急而不得出, 外脹而不得入 - 外脹而不得入: 밖으로 빠져나와 다시 들어가지 않음 ② 枳殼散: 지각을 燒灰存性하여 糝付 태워서 재를 내서 바름

08	탈항의 조리
① 飲食宜清淡: 辛辣, 肥甘厚味한 음식을 삼감 ② 節制飲酒: 음주 X ③ 不宜用力過度: 휴식 많이 취하고 규칙적인 생활을 함 ④ 清潔肛門	

09	직장탈 (直腸脫, proctocoele)
☞ 직장 헤르니아(rectal hernia)	
정의	골반 바닥부분의 근육이 취약해져서 직장을 고정시키는 힘이 약화되었기 때문에 직장이 內臟하여 항문을 통해 밖으로 탈출한 상태
증상	① 기립 또는 복압을 가하면 직장점막 탈출 ② 동통은 없지만 불쾌감 있음 ③ 장시간 탈출 → 점막 미란 → 출혈, 점액분비 증가
	

10	항문소양증(pruritus ani)
개요	다양한 원인으로 항문 주위가 가려움
증상	특히 밤이나 배변 후 심해짐
원인	① 항문을 자주 비누로 씻어 지방질을 제거했을 때 ② 화장지로 과도하게 닦았을 경우 ③ 사람에 따라 자극성 기호품이 유발: 카페인, 맥주, 우유, 초콜릿, 토마토, 땅콩, 홍차 등 ④ 진균 감염 ⑤ 피부 습진성, 건성 ⑥ 촌충
치료	① 항문을 가급적 건조하게 유지 (필요 시 유아용 파우더 사용) ② 비누 자주 사용 말고 이유 없이 피부 연고 사용 말 것 ③ 비비거나 긁지 말 것 ④ 배변 후 물휴지 사용 ⑤ 자극성 음료 피함 ⑥ 과도한 수분 섭취 금함(하루 6컵 이내)
처방	항문지양탕(고삼 30g, 지부자, 사상자 16g, 황백, 설탕 10g - 治肛門搔痒症)

IV. 염증성 장질환

01

염증성 장질환

구분

특이성	• 시겔라증, 장티푸스, 아메바성 이질, 방사선 장염, 항생제 연관 대장염, 결핵성 장염
비특이성	• 원인불명 / 궤양성 대장염, 크론병, 베체트 장염

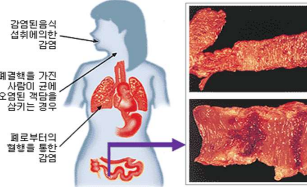
비특이성 염증성 장질환의 원인

① 불분명 ② 추정학설: 감염설, 알레르기설, 정신육체질환설, 자가면역설 등

02

결핵성 장염

정의	장 점막에 결핵균의 감염이 일어나 국소적, 전신적인 장애를 초래한 상태
원인과 발병기전	① 폐결핵 환자 객담의 연하 - 가장 많음 (침 삼켜서 오히려 장결핵을 유발할 수 있음) ② 결핵균에 감염된 우유 ③ 폐결핵의 혈액을 통한 전파 ④ 인접 장기 결핵의 직접 전파
증상	① 전신 증상: 발열, 권태감, 식욕부진, 체중 감소 ② 국소 증상: 복통, 설사, 복부 팽만감, 배변 이상 ③ 그러나 특이증상 없으므로 검사에 의한 감별 필요
치료	폐결핵과 같이 항결핵 요법 시행
장결핵 주증상	발열, 혈변, 설사, 복통, 체중감소



03

장결핵의 변증시치

脾虛氣滯 (비허기체)	증상	• 복통, 복창, 장명, 설사(복통은 따뜻한 것과 주물러주는 것을 좋아함) • 면색위황, 정신 피로, 무기력. 舌淡胖, 苔白. 脈沈細無力
	병리	脾陽不振, 寒凝氣滯
	치법	溫陽健脾, 理氣燥濕
	처방	후박온중탕가미
	후박온중탕가미(厚朴溫中湯加味) 뱃속이 차가워지면 쓰는 처방	• 구성: 당삼 18g, 창출 10g, 백출 10g, 건강 10g, 초두구 6g, 후박 6g, 진피 10g, 목향 6g, 복령 15g, 백편두 15g, 자감초 10g, 대추 12g. 1일 1첩 • 가감 ① 설사가 많지 않으면 + 황련·산약·적석지 ② 복통이 심하면 + 천련자·현호색·삼칠근 ③ 晨泄, 腰酸肢冷 + 四神丸
痰凝血瘀 (담음혈어)	증상	• 설사와 변비 교대, 복창, 복통, 痛處不移 / 우하복부에서 包塊 ^{포괴} 촉진 • 舌淡紅, 苔薄白, 脈弦澀
	병리	痰瘀阻于腸道, 氣血痺阻不通
	치법	消痰化痰, 軟堅散結 ^{연견산결}
	처방	격하죽어탕가미
	격하죽어탕가미(膈下逐瘀湯加味)	• 구성: 오령지 당귀 천궁 도인 목단피 적작약 오약 현호색 향부자 홍화 지각 패모 모려 삼릉 아출 • 가감: ① 納呆 + 사인·맥아 ② 大便秘結 + 망초
氣陰兩虛 (기음양허)	증상	• 몸 나른, 무기력 / 두훈, 이명, 조열, 도한 / 복통, 복창, 大便不調 ^{대변정상X} • 舌紅, 苔薄白 或 少苔, 脈細數
	병리	氣陰虧耗, 虛火上炎
	치법	滋陰益氣, 清熱降火
	처방	지백지황탕가미
	지백지황탕가미(知柏地黃湯加味) 원래는 신음허에 쓰는 처방	• 구성: 생지황 산약 산수유 목단피 택사 지모 황백 지골피 태자삼 白薇 芩實 사삼 • 가감: ① 眩暈, 두통 + 조구등·모려 ② 潮熱, 咽乾 - 택사·복령 + 은시호·호황련 ③ 咳嗽 + 패모·백부근 ④ 痰中夾血 + 백급·선학초·삼칠분

비특이성 염증성 장질환은? 18

- ① 시겔라병
- ② 궤양성 대장염
- ③ 장티푸스
- ④ 방사선 장염
- ⑤ 항생제 연관 대장염

크리스마스 썰 모으는 것 모두 폐결핵 환자를 위한 것임. 현재 우리나라는 폐결핵 발병이 많지는 않으나, 해외에서는 아직 많음

04

장결핵(장노)의 처방

 腸癆 = 장결핵의 처방: 소복죽어탕, 가미이공산 (癆 = 결핵관련)

 소복죽어탕(少腹逐瘀湯)

- 구성: 당귀, 포황 12g, 오령지(炒), 적작약 8g, 몰약, 현호색, 천궁, 관계 4g, 건강, 소회향(炒) 0.8g
- 적용: 治下焦少腹之瘀, 治小腹積塊疼痛

 가미이공산(加味異功散)

- 구성: 황기 12g, 인삼, 산약 6g, 복령 5g, 백출(炒), 진피, 삼릉, 봉출, 백편두, 의이인 4g, 목향, 자감초 2g, 생강 6g, 대추 4g
- 설명: 氣健脾, 活血散結
① 산약, 백편두, 의이인: 益氣健脾, 淡滲利濕 ② 황기, 삼릉, 봉출: 開胃進食, 調和氣血
- 적용: 治腸癆

05

장티푸스

한의학적 병명	濕溫 습온병 / 열병  장티푸스의 한의학적 병명을 쓰시오 12
특징	① 장티푸스균이 소장벽 림프절 내에서 증식하면서 전신으로 확산 ② 혈중에 균이 가득 차게 됨 (균혈증) ③ 폐, 담낭, 신장, 중추로 확산
증상	① 오한 발열: 7-10일까지 점차 악화하여 3-5주간 지속, 열이 악화와 완화를 반복함 ② 위장증상: 복통, 복부 팽만, 변비 또는 수프 같은 설사 ③ 간, 비장: 비대 ④ 호흡기 증상: 기침, 인후통 ⑤ 발진: 가슴에 1-2주 내 발생 ⑥ 치료하지 않으면 환자의 30%에 합병증 유발 - 장천공(돌발적 출혈) - 체온 하강하며 쇼크사
원인	Salmonella typhi, 오염된 물, 육류, 계란, 낙농품 섭취
합병증	장천공, 만성 보균자, 골수염
예후	환자의 15%는 재발 (=만성 보균자로 이행됨)
습온의 처방	습온달원음, 소시호탕, 인령이인탕

 습온달원음(濕溫達原飲) = 달원음 가감

- 온역의 대표적 처방
- 구성: 금은화, 빈랑, 지유 12g, 후박, 초과, 황금, 백작약, 시호, 대황 8g
- 설명
① 疏透(시호) ② 推瀉(대황) ③ 清熱解毒(금은화) ④ 涼血瀉腸(지유) ⑤ 芳香健胃化濁(빈랑, 후박, 초과)
- 적용: 治濕溫初中期

 소시호탕(小柴胡湯)

- 구성: 시호 12g, 황금 8g, 인삼, 반하 4g, 감초 2g, 생강 6g, 대추 4g
- 설명: 和解, 止嘔, 退熱
① 시호, 황금: 消炎解熱 ② 반하, 생강: 止嘔 ③ 인삼, 감초, 대조: 위장기능 향진
- 적용: 治少陽病, 半表半裏, 治濕溫回復期, 餘熱未清

 인령이인탕(茵苓苡仁湯)

- 구성: 의이인 8g, 인진 6g, 황금, 복령, 택사, 금은화 5g, 행인, 지각 4g, 후박 2.4g
- 설명: 清熱祛濕, 理脾和胃
- 적용: 治溫病濕熱證(발열, 舌苔膩, 納呆, 脘腹脹悶, 或 頭身重痛, 便溏)

 장티푸스의 가장 흔한 4가지 증상은 무엇인가? 03
 장티푸스의 증상을 3가지 이상 기하시오 06

06

방사선 장염

정의	복부 - 골반 방사선 치료 후 발생하는 직장과 소장의 가역적 손상
발생빈도	2.5 ~ 25%
임상증상	1) 급성 위장관 증상 ① 치료 중 발생한 증상: 방사선 치료 1-2주 동안 발생, 오심, 구토, 설사 ② 치료 후 발생한 증상: 세포독성과 관련 있음 ↳ 설사, 후중, 점액성 분비물, 출혈, 복통, 오심 2) 만성 위장관 증상: 치료 종료 후 수개월 ~ 수년에 걸쳐 발생 ↳ 산통성 복통, 오심, 구토, 흡수장애, 빈변, 후중, 변실금, 출혈, 혹 변비

07		방사선 장염의 변증시치	
화독협습 (火毒挾濕)	증상	- 오심구토, 身熱心煩, 口渴不欲多飲, 완민복창, 不思飲食, 大便稀爛頻多, 鮮紫紅色 - 或表面有白凍(흰 젤리와 같은 것이 묻어나옴) - 或 복통, 이급후중, 肛門灼熱, 小便短赤, 舌紅, 苔黃膩 或燥, 脈滑數	
	치법	瀉火解毒清營, 化濕理氣消滯	
	처방	해독제생탕	
		해독제생탕(解毒濟生湯) 습열로 인한 설사에 응용 - 구성: 천궁, 당귀, 황백, 지모, 천화분, 금은화, 맥문동, 원지, 시호, 황금, 서각, 복신 4g, 감초, 홍화 2g, 童便(沖) 1잔 - 설명: 治脫疽初期, 惡寒發熱, 體倦作渴, 或腫或紫, 或麻或痛, 神志恍惚不寧	
어열교조 (瘀熱交阻)	증상	- 腹部刺痛(배가 찢리듯 아픔), 大便變細或便秘(대변이 가늘어지고) - 色暗紅 或 柏油樣, 口乾, 時有發熱, 夜間尤甚, 舌質紫紅 或瘀斑, 脈細澀	
	치법	泄熱涼血, 活血化瘀	
	처방	윤장환 + 혈부죽어탕	
		윤장환(潤腸丸) - 구성: 도인, 마자인, 당귀미, 대황, 강활(변이 너무 무르게 나오는 것을 치료해줌) - 적용: 治脾胃伏火, 大便秘澀, 不思飲食	
음휴기모 (陰虧氣耗)	증상	- 腹部隱痛, 大便燥結, 色暗紅, 口乾唇燥, 乾嘔, 面色潮紅, 自汗盜汗 - 消瘦乏力: 몸이 여위고 힘이 없음 - 舌紅苔少或花剝: 설태가 없거나 마치 꽃을 그리는 듯한 형태 - 或 舌光紅無津, 脈細軟	
	치법	滋陰益氣	
	처방	생맥산 + 황기, 황정, 건지황, 당귀, 별갑, 귀판	
비신양허 (脾腎陽虛)	증상	- 血性便, 或油脂狀便, 久瀉不止, 甚則滑脫不禁, 腸鳴腹痛, 晨起瀉甚 - 食少神疲, 面色萎黃, 形寒肢冷, 腰膝酸軟, 舌淡, 苔薄白, 脈沈遲	
	치법	온보비신, 삼장지설	
	처방	부자이중환 + 진인양장탕	

08		항생제 연관 대장염 (CDI)	
명칭		① 항생제 연관 설사: 항생제를 사용하는 환자에게 나타나는 설사 엄청 다 ② 항생제 연관 대장염: 대장에 염증이 증명된 경우 ③ 위막성 대장염: 대장의 염증이 진행하여 偽膜을 형성한 경우	
원인		Clostridium difficile 증식 → 외독소 분비 → 대장조직 손상	
항생제		클린다마이신, 세팔로스포린, 암피실린, 아목시실린	
임상증상		1) 위막성 대장염 ① 설사, 복통, 발열, 오한, WBC증가, 저알부민혈증, 잠혈반응 ② 합병증: 탈수, 저혈압, 전신부종, 독성 거대결장, 장천공 2) 위막 음성 대장염 위막이 생기지 않는 대장염 ① 50%에서 위막 없이 점막 부종과 붉은 발적만 보임 ② 증상은 위막성 대장염과 비슷하나 정도가 약함 3) 항생제 연관 설사 : 증상 경미, 전신 증상 없음, 항생제 중단하면 호전됨	

☞ 항생제 연관 대장염의 원인을 쓰시오
08 12 13

- ☞ 항생제 연관 대장염의 원인은? 17
- ① Salmonella typhi
 - ② Clostridium difficile
 - ③ Shigella flexneri
 - ④ Entamoeba
 - ⑤ Tubercle bacillus

09		항생 연관 대장염의 변증시치	
습열내온 (濕熱內蘊)	증상	- 傾瀉暴注, 下利色青, 或蛋花樣水稀便, 항문작열, 이급후중, 복통장명 - 發熱身重, 或高熱煩渴, 尿赤短小, 舌紅, 苔黃膩, 脈弦數或細數	
	치법	清熱解毒, 分利清濁	
	처방	葛根苓連湯 + 포공영, 패장초, 연교, 금은화, 목단피, 천화분, 활석, 차전자, 감초	
열성상음 (熱盛傷陰)	증상	- 大瀉之後 / 糊便頻繁量少: 풀칠한 듯한 대변 / 高熱不退, 或日晡潮熱 - 口乾欲飲, 或不思飲, 顴紅, 或五心煩熱, 尿短赤 / 舌紅少苔而乾, 脈細數	
	치법	清熱養陰, 益氣升清	
	처방	청호별갑탕 + 갈근, 연교, 인삼, 금은화, 치자, 패장, 황금, 감초	

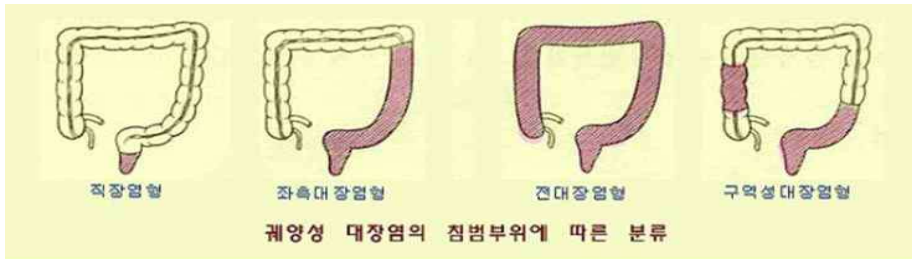
비허습성 (脾虛濕盛)	증상	- 面色㿔白, 神疲懶言, 短氣乏力, 食少納呆, 口渴不飲, 面浮肢腫 - 頻繁入圞, 舌淡胖, 苔薄白, 脈沈緩
	치법	益氣健脾, 利濕止瀉
	처방	삼령백출산 + 갈근, 차전자
비신양허 (脾腎陽虛)	증상	- 形體消瘦, 四肢厥逆, 畏寒踠臥, 腹脹肢腫, 大便清稀, 完穀不化 - 滑脫不禁, 舌淡苔白, 脈沈細
	치법	溫補脾腎, 澁腸止瀉
	처방	眞人養臟湯

10 궤양성 대장염 UC: U:cerative Colitis

1. 개괄

📌 궤양성 대장염의 정의(특징)은 무엇인가? 03

특징	① 이유 없이 대장에 생기는 염증 ② 깊이 패지 않고 직장에서도 대장 상부로 상행 확산 (크론병: 깊이 패며 소장에서 대장으로 하행 확산)
위치	직장(50%), 좌측 결장(30%)
빈도	최다 발현 연령 15-35세 (여)남 / 70세 이상에서도 발생
원인	자가 면역성인 자가 염증반응으로 궤양화
치료 목표	증상 완화, 재발 빈도 감소 (완치 어려움)
증상	1) 초기 증상 📌 궤양성 대장염의 초기 증상에 대해서만 기하시오 05 ① 좌측 하복부통: 배변 후 완화 ② 점액 혈변: 或有或無 ③ 돌연 배변: 이급후증 (배변 후 일어서면 변의 느낌) 2) 평상시 발작하면 ① 1일 20-30회 혈변, 설사 ② 직장 통증 ③ 고열, 구토 ④ 식욕감퇴, 체중감소 3) 악화되면 ① 빈혈 ② 복막염 ③ 장 천공 ④ 중독성 거대결장
합병증발작	관절염(20%), 결절성 홍반증, 구강궤양(10%)



2. UC와 DC의 비교

궤양성 대장염 UC	크론병 DC
① 최근 증가	① UC의 1/8에 해당(UC에 비해 적음)
② 직장에서도 대장으로 상행 확산	② 회장에서 대장으로 하행 확산
③ 패임 없이 표면 염증 (연속적 확산)	③ 깊이 패임 (비연속적 확산)
④ 항생제 병용: 효과 별무	④ 항생제 병용: 효과 좋음

📌 공통적 증상

- 원인: 양자 모두 원인 불명, 유전
- 유발인자: 감염, 알레르기, 음식, 스트레스 등
- 치료법 동일
- 양자 모두 계속적인 악화: 3년 후 수술하게 됨 (완치 쉽지X)
- 양자 모두 2-3개월마다 또는 2-3년마다 재발하는 자가 대부분

Cf 미확정성 장염(indeterminate colitis)

: UC와 DC 양쪽의 특징이 혼재하여 어느 한쪽으로 분류하기 어려운 장염 → 5 - 20%

📌 궤양성 대장염에 대한 설명으로 옳은 것은? 11

- 가. 깊게 패이지 않고 직장에서도 대장 상부로 상행 확산한다.
- 나. 자가면역 질환으로 자가반응으로 궤양이 생긴다.
- 다. 초기 증상은 좌하부 복통, 점액혈변, 이급후증이다.
- 라. 합병증으로는 관절염, 구강궤양, 결절성 홍반이다

① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라 ⑤ 가나다라

📌 궤양성 대장염에 대한 설명으로 옳은 것은? 17

- ① 회장에서 대장으로 하행 확산한다.
- ② 자가면역 질환으로 자가반응으로 궤양이 생긴다.
- ③ 항생제 사용 시 효과가 있다.
- ④ 깊게 패이며 비연속적 확산이다.
- ⑤ 부위: 직장 30% 좌측결장 50

📌 궤양성 대장염에 대한 설명으로 옳은 것은? 18 19

- ① 깊이 패인다.
- ② 소장에서도 대장으로 확산한다.
- ③ 항생제 병용 시 효과가 좋아진다.
- ④ 비연속적으로 확산한다.
- ⑤ 표면성 염증이다.

📌 궤양성 대장염과 크론병에 대해 비교하시오 05 06 07 08 09 12 13 14 15

3. UC의 중등도 평가

	경증	중등증	중증
설사	3회 이하	7회 이상	11회 이상
혈변	조금	심함	계속 출혈
체온	정상	37.5도 이상	
맥박수(분)	정상	90회 이상	
혈색소(Hb)	정상	75% 이하	수혈 필요
ESR	정상	30mm 이상	
진찰 소견	정상	복부 압통	압통, 팽만
X-Ray	정상	장 마비	장 마비, 장 확장

☞ 궤양성 대장염을 경증, 중등증, 중증으로 평가할 때, 설사와 ESR의 평가 기준에 대해 각각 기하시오 05

4. UC에서 수술이 필요한 경우

- ㄱ 응급수술: ① 심한 출혈 ② 장의 천공 ③ 독성 거대결장
- ㄴ 계획수술: ① 내과적 치료로 증상이 안정되지 않는 경우
② 증상 조절 가능하지만 약의 부작용 심한 경우
③ 치료에 잘 반응하지 않는 합병증이 발생한 경우
④ 대장암의 위험성이 높은 환자

11	크론병 DC: Crohn's disease
특징	① 이유 없이 소장이나 대장에서 발생한 염증으로 류마티스 관절염을 합병한 자가 많음 ② 악화된 곳이 깊이 패임 ③ 소장에서 대장으로 하행 확산되는 경향을 보임 ④ 소장만 염증 있는 자: 60% (주로 회장) ⑤ 대장만 염증 있는 자: 20% ⑥ 소장과 대장 모두 염증 있는 자: 20% ⑦ 류마티스 관절염 환자는 소장보다 대장염에 더 많이 합병함
발병	① 주로 20대 발생하고 2-3개월 지속 후 사라짐 ② 2-3년마다 다시 재발 → 우리나라에서는 드문 편
증상	① 식사 후 우측 하복부통 (cf. 궤양성대장염: 좌측 하복부통) ② 가끔 혈변, 설사, 발열 ③ 구토, 식욕부진, 체중 감소 ④ 1/3 환자: 항문열창 ⑤ 아구창(구내염)도 흔히 합병 ※ 내시경 상 중주성 궤양, 조약돌 점막 모양 ※ 악화될 경우: 장폐색, 신장염, Vit B12 결핍, 관절염, 대장암

☞ 크론병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 17

- ① 항생제 병용: 효과 없음
- ② 중주성 궤양
- ③ 조약돌 모양 표면
- ④ 아구창 합병
- ⑤ 비타민 B12 결핍

12 UC와 DC

1. UC와 DC의 일반 요법

① 영양	고단백식, 고섬유식, 종합비타민, 저지방식
② 담즙산 보충	회장에서 흡수되어야 할 담즙산 흡수가 감소되어 대장으로 배설되기 때문에 담즙산 결핍 상태를 막기 위해 보충 (DC의 경우)
③ 급성 발작기	10시간 이상 수면 취하고 영양 수액법 실시 외상휴식
④ 복통 조치	온찜질 또는 따뜻한 병으로 마사지 실시
⑤ 스트레스 피함	-
⑥ 금기	유제품, 가스 생성 음식 (탄산 함유), 카페인

☞ 궤양성 대장염과 크론병의 일반적 처치를 기하시오 08

2. UC와 DC의 변증시치

: ① 비허습조 ② 비신양허 ③ 음혈허허 ④ 간울비허 ⑤ 습열내온 ⑥ 기체혈어

비허습조 (脾虛濕阻)	증상	• 完穀不化, 음식감소, 腹痛喜按, 면색위황, 형체소수, 신피핍력 • 舌淡, 苔薄白膩, 脈細弱 + 大便時瀉時瀉(똥은변 또는 설사)
	치법	健脾助運, 化濕止瀉
	처방	삼령백출산

비신양허 (脾腎陽虛)	증상	- 반복설사, 黎明腹痛, 腸鳴即瀉, 瀉後痛減, 形寒肢冷, 요슬산연 - 舌淡, 脈沈細 + 病久延年(병이 오래되어 몇 년간 지속됨)
	치법	溫腎健脾, 化濕止瀉
	처방	四神丸 + 익지인, 백출, 복령, 산약, 의이인, 감초
음혈허 (陰血虧虛)	증상	- 久瀉不止, 便下膿血, 腹中隱痛, 오후미열, 頭暈目眩, 불면, 도한 - 心煩易怒, 消瘦乏力, 舌紅少苔, 脈細數
	치법	養陰清熱, 益氣固腸
	처방	생맥산 + 육군자탕 + 오매, 지모, 황기, 산약, 검실
간울비허 (肝鬱脾虛)	증상	- 右少腹或臍周脹痛, 痛則欲便, 便後痛減, 大便稀溏, 胸脇脹悶, 噯氣食少 - 抑鬱惱怒 혹은 정서 긴장하면 복통설사 발생 - 腹鳴, 矢氣頻作, 舌淡苔薄, 脈弦
	치법	健脾化濕, 疏肝理氣
	처방	痛瀉要方 + 복령, 지각, 오약, 백편두, 모과, 의이인, 감초
습열내온 (濕熱內蘊)	증상	- 복통설사, 반복발작, 便中挾膿挾血, 이급후중, 신열, 항문작열 - 口苦口臭, 脘痞 嘔惡, 小便短赤, 舌紅, 苔黃膩, 脈數或滑數
	치법	清熱利濕, 理氣止痛
	처방	白頭翁湯 + 백작약, 椿根皮, 의이인, 백출, 오매, 목향, 패장, 산사, 감초
기체혈어 (氣滯血瘀)	증상	- 腸鳴腹脹, 腹痛拒按, 痛有定處, 瀉下不爽, 噯氣少食, 면색암흑 - 腹部或有痞塊, 肌膚甲錯, 舌紫黑, 瘀斑瘀點, 脈澀或弦
	치법	行氣活血, 健脾益氣
	처방	격하죽어탕

3. UC와 DC의 기타 처방

┐ 大瘕泄 UC: 부비역간청장전, 오매환, 귀평음

└ 伏梁 DC: 복량패장산, 치국한성장염방

扶脾抑肝清腸煎 = 통사요방 + α - 구성: 백작약, 복령 10g, 인삼, 백출(炒), 산사(炒), 신곡(炒), 秦皮 8g, 방풍(炒), 陳皮 6g, 자감초 - 설명: 증상 개선 후 作丸服 - 적용: 치만성궤양성결장염
귀평음 (潰平飮) - 구성: 백작약, 차전자, 목향, 나복자(炒), 산약, 지유, 백두옹 6g, 당귀, 빈랑 4g - 설명: 養血活血, 柔肝健脾, 行氣導滯 ① 당귀: 養血和血 ② 백작약: 柔肝止痛 ③ 목향, 빈랑: 行氣導滯 ④ 차전자: 滲濕下行 ⑤ 나복자: 消食行氣 ⑥ 지유: 涼血止血 ⑦ 백두옹: 清熱解毒 ⑧ 산약: 補氣養陰 통사요방 - 적용: 治大瘕泄
복량패장산 (伏梁敗醬散) = 의이부자패장산 + α - 구성: 의이인, 패장초 20g, 적작약, 백작약 8g, 당귀, 목단피, 황금, 지각, 죽여, 진피 6g, 부자, 감초 4g, 황련 2g - 설명: 清熱化濕, 活血行氣 ① 의이인, 패장: 清熱利濕 ② 지각, 진피: 理氣消滯 ③ 당귀, 적백작약, 목단피: 活血化瘀 ④ 황금, 황련, 죽여: 化濕清熱 - 적용: 治伏梁
치국한성장염방 (治局限性腸炎方) - 소시호탕 + 갈근금련탕 가감 - 구성: 시호, 황금, 복령, 진피, 갈근, 황련, 인삼, 감초 6g

13 베체트병

UC, DC와 함께 대표적인 자가면역질환, 비특이성 염증성 장질환 중 하나

1. 정의

: 피부, 점막, 안 증후군의 하나로 교원병과 유사한 질병 (서양사람보다 동양사람에게 多)

2. 4대 특징 - 입, 피부, 외음부, 눈

☞ 베체트병의 주 증상은 무엇인가? 03

- ① 재발성 아프타 (구강 궤양)
- ② 피부의 결절성 홍반 또는 농포 형성 (모낭염양 피진)
- ③ 외음부 궤양
- ④ 재발성 전방 축농성 홍채염 또는 포도막염

3. 원인: 불명

4. 증상의 경과

: 보통 구강점막 → 피부 → 외음 → 눈의 순서로 증상이 경과함

5. 베체트병의 진단기준(국제)

- 진단: 아래 내용 중 2가지 이상에 해당 시 베체트병

재발성 구강 궤양: 12개월 내 3번 이상 재발 (가장 중요)
① 재발성 성기 궤양 ② 안구 병변: 포도막염 ③ 피부 병변: 홍반성 결절 ④ 피부자극 검사(pathergy test) 양성

6. 베체트 장염 = 베체트병 + 장염증상

정의	베체트 병으로 밝혀진 환자가 복통, 설사, 혈변 등의 위장관 증상을 호소하는 경우
임상증상	우하복부 복통(가장 흔함), 설사, 혈변, 복부 종괴, 체중감소
감별진단	크론병, 장결핵, 아메바 대장염

7. 베체트병의 변증유형

☞ 베체트병의 변증시치를 기하시오 09

- ① 열독형 ② 음허형 ③ 허한형 (통용: 생지사심탕) ☞ 베체트병의 한의학적 병명과 병리 02 03 06
- 베체트병은 상한금괴의 狐惑病과 비슷 / 호혹병: 구강·성기에 염증이 생기는 것

1) 열독형(熱毒型)

증상	• 오한발열, 식욕부진, 心煩躁擾, 狀如傷寒(상한병에 걸린 듯함), 노적변건, 태황니, 맥현삭 • 坐臥不寧: 마음이 불안하고 편치 않음
특징	초기 발병이 급함, 젊은 여성에게 다발
치법	清熱化濕, 消解毒火
처방	濕熱壅遏湯

🔑 습열옹알탕(濕熱壅遏湯)

- 구성: 토복령 20g, 생지황, 甘草稍 10g, 당귀 8g, 적작약, 도인, 연교 6g, 길경, 시호 4g, 홍화 2g
- 설명: 清熱解毒, 活血利濕
- 적용: 治狐惑病, 眼紅赤疼痛, 口腔舌側潰瘍, 陰部潰瘍

2) 음허형(陰虛型)

증상	• 구강과 음부 궤양 반복발작 / 眼結膜刺痒難忍(눈이 간지러워 뜨지 못함) • 장기간 微熱不解, 頭暈目眩, 口乾煩燥, 自汗盜汗, 舌紅, 脈細數
치법	清熱養陰, 和肝除煩
처방	육미삼자탕, 청리감자탕

🔑 육미삼자탕(六味三子湯)

- 구성: 숙지황, 산수유, 산약, 택사, 복령, 목단피, 맥문동, 작약, 토사자, 여정자, 구기자, 당귀, 국화
- 설명: 滋補腎陰, 調和陰陽
- 적용: 治狐惑病

🔑 청리자감탕(淸離滋坎湯)

- 구성: 숙지황, 건지황, 천문동, 맥문동, 당귀, 백작약, 산수유, 산약, 백복령, 백출 4g, 목단피, 택사, 황백, 지모, 자감초 3g
- 설명: 滋陰降火健脾
- 적용: 治陰虛火動, 潮熱盜汗, 痰喘心慌 / 베체트병, 자율신경실조증, 갱년기장애
- 금기) 陽虛便滑, 不可用: 양허해서 변이 묽은 사람들은 쓸 수 없음

3) 허한형(虛寒型)

증상	• 장기간 반복발작, 구강과 외음부 궤양, 면색창백, 외한, 하지부종, 요슬땀립, 식욕부진 • 복장, 혹은 五更泄瀉(새벽 설사) / 舌淡苔白, 脈沈細無力
특징	脾胃陽虛, 寒邪凝滯로 氣滯血瘀가 초래됨
치법	補脾益腎, 活血化瘀
처방	호혹녕

🔑 호혹녕(狐惑寧)

- 구성: 인삼, 백출, 복령, 반하, 부자(炮), 삼릉, 봉출, 당귀미, 적작약, 홍화, 건강, 육계, 감초
- 설명: 溫補脾胃, 活血化瘀
- 적용: 治狐惑病

☞ 베체트병의 증상 경과 순서로 옳은 것은? 17

- ① 외음, 피부, 눈, 구강
- ② 피부, 눈, 구강, 외음
- ③ 눈, 외음, 피부, 구강
- ④ 외음, 구강, 눈, 피부
- ⑤ 구강, 피부, 외음, 눈

☞ 베체트병의 증상 경과는? 18 19

- ① 구강점막 외음 피부 눈
- ② 구강점막 외음 눈 피부
- ③ 구강점막 눈 외음 피부
- ④ 구강점막 피부 외음 눈
- ⑤ 구강점막 피부 눈 외음

☞ 베체트병의 국제 진단 기준에 대해 명확하게 기하시오 05 07 08 09 11 12 13 15

☞ 베체트병 진단 기준 중 가장 중요한 것은? 17

- ① 재발성 성기 궤양
- ② 안구병변: 포도막염
- ③ 재발성 구강궤양
- ④ 피부 병변: 홍반성 결절
- ⑤ 피부자극 검사 양성

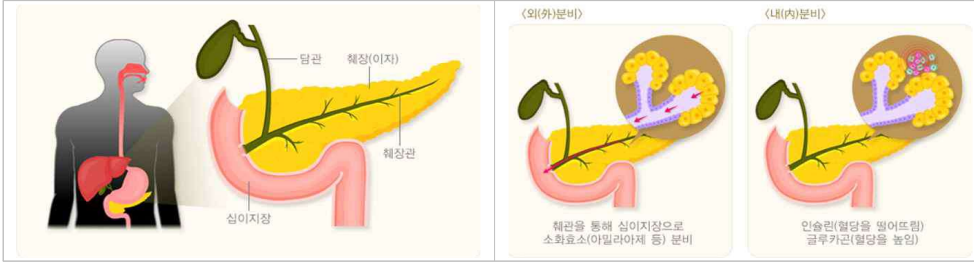
☞ 베체트병 환자이다. 구강궤양과 음부궤양이 있고 장기간 반복발작하였다. 얼굴이 창백하고 추위를 싫어한다. 하지가 부어있고 허리가 시큰거리며 힘이 없다. 설담태백 맥침세할 때 처방은? 18 19

- ① 습열옹알탕
- ② 육미삼자탕
- ③ 호혹녕
- ④ 반하사심탕
- ⑤ 육군자탕

V. 췌장 질환

01

췌장의 구조와 기능



02

급성 췌장염

1. 특징

- ① 췌장의 부종, 종창, 여러 정도의 자가분해(autodigestion), 괴사 또는 출혈을 동반한 급성 염증성 장애
② 원인 제거되면 정상 기능 회복 (→ 만성췌장염과의 차이점)

2. 원인 (발작 유발 요인)

☞ 급성 췌장염의 3대 원인을 쓰시오 02 03 05

- ① 담석증, 담낭, 담도질환 (30~75%) > ② 알코올, 과음 (15%) > ③ 고지혈증 (4%)
④ 바이러스감염 ⑤ 약물 ⑥ 복부수술 ⑦ 혈관염

3. 급성 췌장염 유발 약물

☞ 급성 췌장염을 유발하는 약물은? 09

- ① Azathioprine(면역억제제) ② Estrogen ③ Tetracycline(항생제) ④ Valproic acid(전간치료제)
⑤ Metronidazole(항생항원충제) ⑥ Sulindac(비스테로이드성 항염증제) ⑦ 이노제(Thiazide, Furosemide)

4. 병태

- ① 췌장 소화효소를 분비하는 분비관이 막힌 결과 소화액이 췌장 자체를 소화시켜 염증 유발
② 담즙이 췌장 내로 역류하여 췌장에 염증 유발
③ 소장의 소화액이 췌장으로 역류
④ 췌장 조직이 파괴되면서 생긴 독성물질이 심장, 폐, 신장을 파괴
⑤ 췌장이 혈관확장물질을 유리 하여 혈압을 강하시켜 쇼크 유발

5. 증상

- 1) 포식 후, 과음 후 돌발적으로 상복부 통증 유발 (95%)
: ① 걷거나 누우면 더 아픔 ② 앞쪽으로 구부려 앉으면 완화 ③ 통증이 등으로 방산(좌/우)
2) 복부 팽만, 구토, 구역 (84%) 3) 심하면 발한, 급맥, 저혈압 4) 경증 황달 5) 발열: 37.7~38.3도
6) 배꼽 주위 탈색 7) 증상은 5~6일 내 자연 소실

6. 예후

☞ 급성 췌장염에서 예후가 나쁜 경우를 쓰시오 12

대부분 환자	자연 치유됨	사망률	경증의 10%, 중증의 50%
예후가 나쁜 환자	55세 이상, 혈당 200 이상	만성췌장염 환자	급성 증상이 자주 재발함

불량예후 인자: Ranson / Imrie 기준

입원 당시	① 나이 > 55세 ② 백혈구: 16,000/uL 이상 ③ 혈당: 200mg/dl 이상 ④ 혈청 LDH > 400IU/L ⑤ 혈청 AST > 250 IU/L
처음 48h 동안	① Hct 감소 > 10% ② 수액 저류 > 4000ml ③ 저칼슘증 < 1.9mmol/L(8.0mg/dl) ④ 저산소증(PO2 < 60mmHg ⑤ 수액투여 후 BUN 증가 > 1.8mmol/L(5mg/dl) ⑥ 저알부민증 < 3.2g/dl

7. 치료지침

: 염증이 가라앉을 때까지 췌장을 쉬게 하면 1주 내로 치료됨

- ① 입원 후 안정 ② 원인 제거 ③ 3~4일 경구 금지 ④ 전해질 조정(水液注) ⑤ 영양 수액제
⑥ 진통: 마약 주사 ⑦ 담석 발견 시: 수술 ⑧ 회복 시: 고탄수화물, 저지방, 저단백질을 소량씩 섭취

☞ 급성 췌장염에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 17

- ① 포식과 음주 후 돌발적인 상복부 통증
② 복부팽만, 구역, 구토
③ 발한, 급맥, 저혈압
④ 배꼽 주위 탈색
⑤ 통증이 등으로 방산되며 구부려 앉을 때 심해진다.

☞ 입원 당시 급성 췌장염의 불량 예후 인자가 아닌 것은? 17

- ① 백혈구 수치 16000uL 이상
② 혈당 200 이상
③ 나이 55세 이상
④ 혈중 알부민 3.2g/dl 이상
⑤ 혈당 200 이상(복원 오류 아님)

03	급성 췌장염의 한방치료
변증시치	처방
간울기체	통어청이탕
비위실열	가감대시호탕
간담습열	대황전제, 담이탕

1. 간울기체(肝鬱氣滯)

증상	완협창통, 구건인건, 애기頻作, 乾嘔或嘔吐, 甚則大便秘結, 苔薄膩, 脈弦
특징	水腫型輕症
치법	소간이기, 청열통부
처방	청이탕

🔑 청이탕(淸胰湯) - 대시호탕 가감

- 구성: 시호, 백작약, 대황(後下) 6g, 황금, 호황련, 목향, 현호색, 망초(沖) 4g
- 설명: 이기해울, 청열해독, 통리공하
 - ① 시호, 황금, 황련, 대황: 진정, 소염, 해열 ② 시호, 백작약: 진경, 진통 ③ 목향: 理氣止痛
 - ④ 현호색: 活血理氣 ⑤ 대황, 망초: 瀉下
- 적용: 治 급성췌장염

2. 비위실열(脾胃實熱)

증상	발열, 완복만통拒按, 비색불통, 대변건결, 구건, 설태황니, 흑조, 맥활삭
특징	水腫型重症 또는 出血壞死型
치법	청열공하
처방	청이탕 + 대승기탕

3. 간담습열(肝膽濕熱)

증상	복부창통, 발열, 구갈, 目黃身黃, 소변황적, 오심구토, 대변비결, 설태황니, 맥현삭
특징	膽道感染으로 초래된 型
치법	疏肝利膽, 通腑泄熱 (通腑: 통리 공하 泄熱: 청열해독)
처방	- 청이탕 + 용담사간탕 - 인진호탕 + 용담초, 백작약, 의이인, 판람근, 울금, 백모근, 金錢草

🔑 통어청이탕(通瘀淸胰湯)

- 구성: 연교 10g, 금은화 8g, 시호, 지실, 대황(後下), 당귀, 도인, 현호색, 포황 6g, 용담초, 적작약, 망초(沖) 4g, 감초 2g
- 적용: 治 급성췌장염

🔑 가감대시호탕(加減大柴胡湯)

- = 대시호탕 - 반하, 지실, 생강, 대추 + 용담초, 지각, 울금, 목향, 박초
- 구성: 시호 8g, 황금, 용담초, 지각, 백작약, 울금, 대황 6g, 목향, 朴硝(沖) 4g
- 설명: 疏肝利膽, 淸熱利濕, 瀉滯腑積
- 적용: 治 급성췌장염

🔑 대황전제(大黃煎劑)

- 구성: 대황(生) 40g
- 설명: 연속 2-3일 복용, 복통 줄어들면 분량을 5돈으로 줄여 나올 때까지 복용
- 적용: 治 급성췌장염

🔑 담이탕(膽胰湯)

- 구성: 인진, 백작약 8g, 금은화, 대황, 포공영 6g, 황금, 향부자, 천련자, 지실, 법반하, 시호 4g, 황련, 감초 2.4g
- 설명: 淸熱利濕解毒, 行氣止痛健胃
 - 복통소실(1~6일) / 발열소실(1~7일) / 구토정지(1~2일) / 혈청 amylase 정상회복(1~2일)
- 적용: 治 (담낭 관련하여 생긴) 급성췌장염

☺ 급성 췌장염 수종형 경증이다. 상복부 옆구리가 부어오르면서 아프다. 입과 목구멍이 마르고, 트림이 잦다. 대변비결하고 태박니할 때 처방은? 19탈기

- ① 삼령백출산
- ② 격하촉어탕
- ③ 대승기탕
- ④ 청이탕
- ⑤ 시호계지탕

04	만성 췌장염
특징	췌장이 만성적으로 계속 파괴되면서 기능 상실 (cf. 급성췌장염은 원인 제거 시 정상회복)
원인	① 알코올: 70~80% ② 특발성: 10~30% ③ 유전성 ④ 영양실조
발병자 특징	① 알코올 중독자 ② 영양 결핍자 ③ 유전성
병태	1) 췌장이 점증적으로 섬유화되고 췌장 내에 결석도 생성되어 비가역적으로 기능 상실 : 만성 석회화성 췌장염 2) 췌장 소화액 분비 조직이 자가분해 3) 췌장 분비관이 폐쇄되어 췌장액이 췌장을 자가 소화: 폐쇄성 췌장염 4) 췌장 내에 결석 생성 5) 췌장 내분비 기능 상실 ① Insulin 분비 저하: 혈당 상승 ② Glucagon 분비 저하: 혈당 감소 ③ Somatostatin 분비 저하 : 췌장 조직 증식 억제 6) 췌장의 외분비 기능 상실 ① Panceratin 분비 저하 : 소화기능 상실 ② 중탄산 분비 저하 : 십이지장액 중화 불가능 7) 만성 췌장염 환자 중 췌장암 발생률 증가
증상	• 대부분 증상 없는 자가 많음, 증상 나타나면 ① 좌측 상복통이 자주 재발하면서 좌측 상부 요통으로 방산 ② 통증은 2~3시간 지속되며 , 발작 기간은 2주 정도 ③ 기타: 구토, 구역, 가스, 식욕부진, 체중감소 ④ 소화 효소 결핍으로 만성적 설사
치료	① 진통 요법 ② 금주 ③ 저지방식 ④ 소화효소제 투여: 제산제 병용

05	급성과 만성 췌장염의 비교												
	<table> <tr> <th>급성췌장염</th><th>만성췌장염</th></tr> <tr> <td> 공통 증상 ① 좌측 상복통 : 예리함, 어깨로 방산, 식후 점점 심해짐, 누우면 악화, 앞으로 구부리면 편함 ② 복부 팽만, 소화불량 ③ 구토, 구역 ④ 발열 ⑤ 급맥 ⑥ 황달(가끔) </td><td></td></tr> <tr> <td> 증상차이 • 돌발적, 일시적 증상 • 체중감소 없음 </td><td> • 지속적, 재발성 • 체중 감소함 </td></tr> <tr> <td> 주원인 담석증 </td><td> • 만성적 음주 • 10년 이상 매일150g이상 음주 </td></tr> <tr> <td> 기타 원인 음주, 고지혈증, 감염, 약물 </td><td> 영양결핍 </td></tr> <tr> <td> 치료 상의 차이 • 3~7일 내 자연치유 • 합병증:2~4주 내 치유 </td><td> 계속 악화되며 불치 </td></tr> </table>	급성췌장염	만성췌장염	공통 증상 ① 좌측 상복통 : 예리함, 어깨로 방산, 식후 점점 심해짐, 누우면 악화, 앞으로 구부리면 편함 ② 복부 팽만, 소화불량 ③ 구토, 구역 ④ 발열 ⑤ 급맥 ⑥ 황달(가끔)		증상차이 • 돌발적, 일시적 증상 • 체중감소 없음	• 지속적, 재발성 • 체중 감소함	주원인 담석증	• 만성적 음주 • 10년 이상 매일150g이상 음주	기타 원인 음주, 고지혈증, 감염, 약물	영양결핍	치료 상의 차이 • 3~7일 내 자연치유 • 합병증:2~4주 내 치유	계속 악화되며 불치
급성췌장염	만성췌장염												
공통 증상 ① 좌측 상복통 : 예리함, 어깨로 방산, 식후 점점 심해짐, 누우면 악화, 앞으로 구부리면 편함 ② 복부 팽만, 소화불량 ③ 구토, 구역 ④ 발열 ⑤ 급맥 ⑥ 황달(가끔)													
증상차이 • 돌발적, 일시적 증상 • 체중감소 없음	• 지속적, 재발성 • 체중 감소함												
주원인 담석증	• 만성적 음주 • 10년 이상 매일150g이상 음주												
기타 원인 음주, 고지혈증, 감염, 약물	영양결핍												
치료 상의 차이 • 3~7일 내 자연치유 • 합병증:2~4주 내 치유	계속 악화되며 불치												

06	만성 췌장염의 한방치료
① 간울기체: 시호계지탕 ┏ 급성발작 → 급성 췌장염에 준하여 치료 ② 비위실열: 향울육군자탕 ┗ ③ 비허설사: 십육미유지음 + 작약감초탕 + 금은화 ④ 혈어복통	
1. 비허설사(脾虛泄瀉)	
증상	• 大便時澇 時瀉, 納穀不化, 稍進油膩, 大便次數明顯增加, 반복발작 • 음식부진, 食後飽悶不適, 面色萎黃, 肢倦乏力, 舌淡苔白, 脈細弱
치법	익기건비
처방	삼령백출산

☞ 만성 췌장염의 원인 4개? 10

☞ 만성 췌장염의 원인으로 가장 많으며 70~80%를 차지하는 것은? 11 17

- ① 영양실조 ② 당뇨병 ③ 유전
④ 고지혈증 ⑤ **알코올**

☞ 만성 췌장염 발병자의 특징을 쓰시오 13

☞ 만성 췌장염의 병태에 대해 설명하시오 03

☞ 만성 췌장염의 증상이 아닌 것은? 02 (선지 복원X)

☞ 급, 만성 췌장염의 증상과 원인 및 치료를 비교하시오. 02 05 06

☞ 급성, 만성 췌장염 비교 시 가장 흔한 원인을 한가지씩 기하시오. 07 08 12

☞ 급성, 만성 췌장염의 증상 차이와 주된 원인을 쓰시오. 14

☞ 만성 췌장염은? 18 19

- ① 체중감소 없음
② 원인 제거 시 증상 사라짐
③ 주원인은 담석증
④ 3~7일 자연치유
⑤ **지속성 재발성**

☞ 만성췌장염 환자이다. 대변이 묽기도 하고 설사하고 소화도 안 되고, 기름진 것을 조금만 먹어도 대변횟수가 증가하고, 반복 발작하며 식욕이 없고, 식후에 더부룩한 포만감이 있으며 편치 않고, 얼굴이 누렇게 되고, 사지에 힘이 없다. 사용하는 처방은? 18

- ① 위관전
② 불환금정기산
③ 오령산
④ **삼령백출산**
⑤ 청이탕

2. 혈어복통(血瘀腹痛)

증상	- 腹痛經久不愈, 疼痛時輕時重, 如刺如割 - 痛處固定不移, 腹部可扪及腫塊, 拒按, 舌紫, 脈澱
치법	활혈화어
처방	소복죽어탕, 격하죽어탕

🔑 시호계지탕 - 소시호탕 + 계지탕

- 구성: 시호 8g, 계지, 황금, 작약, 인삼, 반하 6g, 감초 2g, 대추 4g, 생강 6g
- 적용: 치 만성궤장염

🔑 향울육군자탕(香鬱六君子湯)

- 구성: 복령 8g, 백작약(炒) 7.2g, 시호, 인삼, 백출, 진피, 반하, 향부자, 울금, 목향 4g, 감초 2.4g
- 설명: 소간건비
- 적용: 치 만성궤장염(간울비허형)

☺ 만성 궤장염 환자이다. 동통이 때때로 발생하고, 좌상복부가 칼로 찌르듯이 아프고 지속적으로 재발하며 통처가 고정되어 있다. 처방은? 19 탈기 (선지 복원 오류인듯)

- ① 대시호탕 + 용담초, 지각, 울금, 목향, 박초
- ② 삼령백출산
- ③ 청이탕
- ④ 인진호탕
- ⑤ 작약감초탕

- 답은 소복죽어탕 or 격하죽어탕

07	궤장암	
3대 증상	① 복통(70%): 상복부에 극심한 통증, 등으로 방산 ② 체중감소(80%) ③ 황달(50%)	 
위험인자	흡연, 동물성 지방, 유전	
경과, 예후	- 예후 불량함 - 국소암: 완전 절제 시 5년 생존율 20% - 재발률 높음	
한방치료	오미소이탕, 시호용담탕	

☺ 궤장암의 3대 증상을 기하시오 99 02 13

☺ 궤장암의 예후를 설명하시오 09

🔑 오미소이탕(五味消胰湯) - 구성: 백화사설초, 포공영 16g, 단삼, 의이인 12g, 적작약 6g - 설명: 활혈화어, 청열해독 - 적용: 치 궤장암
🔑 시호용담탕(柴胡龍膽湯) - 구성: 백화사설초, 토복령, 의이인 12g, 인진, 포공영 6g, 복령, 울금, 생지황, 시호, 단삼 4.8g, 치자, 황금, 대황 4g, 용담초 2.4g, 황련 1.2g - 설명: 활혈화어, 청열해독 - 적용: 치 궤장암

08 궤장암의 변증시치

1. 濕濁阻遏 (습탁조알)

증상	- 가슴과 위안이 답답하다. / 대변이 묽거나 설사한다. - 머리가 무겁고 몸이 피곤하다. / 몸과 눈이 모두 누런데 어두운 황색이다. - 속이 메스꺼워 구역질하고 식욕이 없으며 배가 은근히 아프다. - 입이 말라도 물을 마시려하지 않는다. - 舌質淡, 苔白膩 / 脈沈細 혹은 沈遲
치법	健脾利濕, 化濁解毒
처방	茵陳五苓散加減

🔑 인진오령산가감(茵陳五苓散加)

- 구성: 인진 30g, 저령·백복령 각 12g, 백출 10g, 택사 15g, 계지 10g, 菝葜 20g, 진피·법반하 각 10g, 石見穿·산자고 각 30g, 감초 5g

2. 氣滯血瘀(기체혈어)

증상	- 脘腹이 창만하다. / 오심 구토하거나 딸꾹질한다. - 상복부의 통증은 지속적이며 통증의 부위가 고정되어 있다. - 뱃속에 痞塊가 있다. 얼굴이 거무칙칙하다. 몸이 수척하다. - 舌質靑紫하고 혹은 瘀斑이 있으며 苔薄하다. 脈弦細 혹은 澱하다
치법	行氣化瘀, 軟堅散結
처방	膈下逐瘀湯加減

🔑 격하축어탕가감(膈下逐瘀湯加減)

- 구성: 오령지 10g, 향부자 12g, 오약 9g, 현호색 30g, 홍화 10g, 도인 10g, 적작약 15g, 지각 10g, 단삼 30g, 천산갑(炮) 10g, 八月札 10g, 패모 15g, 莢芩 30g, 藤梨根 30g, 감초 5g

3. 肝鬱蘊熱(간울온열)

증상	- 상복부와 옆구리가 창만하다. 배가 아파서 손을 댈 수 없다. - 몸과 눈이 누렇다. 식욕이 없다. 트림하며 속이 메스껍다. - 변조증이 나고 화를 잘 낸다. 열이 난다. 소변이 黃赤色이다. - 대변이 乾結하다. 舌質紅而燥하고 苔黃厚膩하다. 脈弦 혹은 滑數하다.
치법	疏肝解鬱, 清熱解毒
처방	소복축어탕, 柴胡疏肝散加減

🔑 시호소간산가감(柴胡疏肝散加減)

- 구성: 시호 10g, 백작약 30g, 향부자 15g, 지각 10g, 천궁 6g, 백화사설초·토복령·白毛藤·兩面針·垂盆草·虎杖·芩芩 각 30g, 감초 5g.

4. 氣血虧損(기혈후손)

증상	- 배가 팽만하며 은근히 아프다. 종괴가 만져진다. 식욕이 없다. - 몸이 나른하고 힘이 없다. 온몸이 수척하다. 얼굴이 누렇게 뜬다. - 舌質淡하고 혹은 瘀點이나 瘀斑이 있다. 苔薄白하다. 脈沈細하다.
치법	益氣養血, 化瘀散結
처방	十全大補湯加減

🔑 십전대보탕가감(十全大補湯加減)

- 구성: 황기·당삼·당귀 각 15g, 백출(炒) 12g, 숙지황·백복령·저령 각 15g, 계혈등 30g, 별갑(炙) 9g, 구기자 12g, 패모 15g, 천산갑(炮) 9g, 蜚休 30g, 감초 6g

VI. 기타 장질환

01

게실

1. 게실증과 게실염

특징	① 게실증: 장벽에 고무풍선처럼 주머니(게실)가 생긴 ② 게실염: 게실에 염증이 생긴 경우		
위치	① 동양: 맹장, 상행결장(95% 이상) ② 서양: S자상 결장, 하행결장(90% 이상)		
원인	① 동양: 유전적 소인 ② 서양: 저섬유식품		
증상	: 환자의 10-25%만 나타남 (증상 없는 경우 多)		
	게실증 증상	① 좌측 하복부통, 식사 후 악화 ② 복통은 배변 후 완화	③ 설사 또는 변비, 가끔 혈변 ④ 복부 팽만
증상	게실염 증상	① 게실증 증상 모두 갖춤 ② 급성 돌발성 좌측 하복부통	③ 동일 부위에 지속적인 통증 ④ 발열, 오한, 구토, 구역, 식욕상실
빈도	① 50대 이상 30-40%, 70대 50% ② IBS(과민성대장증후군) 환자에게 많음 ③ 40-50% 환자가 60-80대에서 발생		
발병기전	① 장벽의 저항 약화 ② 대장의 분절 내 압력 상승 ③ 저섬유질 식이: 장 내압 상승		
합병증	출혈, 장 천공, 복막염, 장폐색, 장 농양, 누공		
예후	① 잘 치료하면 67% 환자 재발 없음, 33% 환자 재발 ② 환자의 2/3가 1-2년 내 재발		
일반요법	① 매일 동일 시간에 배변할 것 ② 복통 시 온찜질 ③ 금기: 사과 껍질, 씨 종류, 옥수수, 팝콘, 오이, 밤, 딸기, 커피, 술 ④ 좋은 음식: 고섬유식, 껍질 벗긴 사과, 씨 없는 포도, 복숭아, 당근, 양배추		
한의학적 고찰	① 복통의 범주 ② 병리: 濕熱挾瘀, 氣機不暢 ③ 치법: 清熱化濕, 理氣活血, 消積止痛		

진성게실 VS 가성게실

진성게실	가성게실
근육층을 포함한 장벽의 전층이 돌출	점막층과 점막하층만 돌출
선천적으로 발생	후천적으로 발생
우측 대장에 주로 1개가 발생	좌측 대장에 여러 개가 발생
동양인에게 흔함	서양인에게 흔함

2. 혈관성 장질환

종류	① 허혈성 장질환 ② 혈관확장증 ③ 혈관종
위장관의 혈액 공급	① 복강동맥: 위, 십이지장, 췌장, 비장, 간장에 혈액 공급
	② 상장간막 동맥 (SMA): 소장의 대부분, 우측 대장에 혈액 공급
	③ 하장간막 동맥 (IMA): 횡행결장의 원위부에서 근부위 직장까지 혈액 공급

3. 장허혈

1) 급성 장간막 허혈증 (AMI: Acute Mesenteric Ischemia)

원인	① SMA 폐색: 50% ② 비폐색성 SMA 허혈: 25% ③ 기타: 정맥 혈전, IMA 폐색, 동맥염
병의 전도를 결정하는 요인	① 허혈을 일으킨 기간 ② 혈관이 막힌 속도 ③ 혈관이 막힌 정도 ④ 측부 순환의 발달 정도
증상	① 고령이면서 율혈성 심부전, 부정맥, 최근 심근경색, 저혈압 등이 있는 환자가 갑자기 복통을 호소하면 AMI를 의심해야 함 ② 복통: 갑자기 생기고 심함, 배꼽 주위에 쥐어짜는 듯한 양상 ③ 설사, 구토, 전신쇠약 ④ 압통 증가, 반발통, 복근강직: 장 괴사 진행
진단	의심되면 당일 내로 혈관조영술(arteriography) 실시

☞ 게실 발생 요인은 무엇인가? 03

☞ 게실증의 동서양 차이점을 쓰시오 12 13 15

☞ 게실에 대해 옳은 것은? 17

- 동양인은 S 결장에서 발생한다.
- 서양인은 유전 소인이 강하다.
- 근육층을 포함한 장벽 전층의 돌출은 진성 게실이다.
- 가성 게실은 좌측 대장에 여러 개 발생한다.
- 가성 게실은 동양인에게 흔하다.

☞ 게실에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? 18

- 동양인에게서 주로 맹장 상행결장에서 생긴다.
- 동양인은 유전적 소인이 많다.
- 서양인은 저섬유식으로 발생한다.
- 진성게실은 주로 동양인에게서 생긴다.
- 가성게실은 근육층을 포함한 장벽 전층이 돌출된다.

2) 만성 장간막 허혈증 (CMI: Chronic Mesenteric Ischemia)

특징	① 반복적인 허혈에 의해 복통을 호소하는 질환 ② 식후에 통증이 많이 나타남 ③ 식후엔 위장 혈류 증가하고 소장 혈류 감소하기 때문에 통증 유발함
선행 요인	① 고령 ② 당뇨 ③ 고혈압 ☑ 위급상황에서 혈류량을 가장 먼저 줄이는 곳 = 소화관 - 근육이나 심장에 혈액이 많이 가야되니까 가장 혈액이 필요하지 않은 위장관 쪽의 혈류량을 줄임 - 과하게 운동을 하는 사람들은 위장의 혈류량이 줄어들고 갈증 나서 물도 많이 마시기 때문에 운동하는 사람들은 위장이 상한 경우 다
증상	① 식후 30분 후 배꼽 주위나 심와부의 묵직한 통증, 압통은 없음 ② 통증 서서히 증가하다 1-3시간 후 소실 ③ 식사량 감소, 체중 감소

3) 장간막 정맥 혈전증 (MVT)

선행 요인	울혈성 심부전, 췌장염, 복부의 염증성 질환, 간문맥 고혈압, 복부 외상
증상	① 심한 복통: 내원 전 평균 5-14일간 지속 ② 오심, 구토 ③ 하부위장관 출혈, 혈성 설사, 토혈: 장 경색을 시사 ④ 복부 압통, 장음 감소, 복부 팽만
치료	① 장 경색 소견이 없으면 내과적 치료 ② 있으면 수술

4) 대장 허혈증 (CI: Colonic Ischemia) = 허혈성 대장염(ischemic colitis)

특징	① 고령에 흔함 ② 허혈성 장 손상의 가장 흔한 형태임 ③ 특정 원인 못 찾음 : 소혈관의 국소적 비폐쇄성 허혈 때문 ④ 호발 부위: splenic flexure(비만곡부), 측부순환이 발달하지 않았기 때문
증상	① 돌발적인 腹部絞痛 ② 변실금 ③ 혈변 ④ 가벼운 복부팽만 이나 압통
치료	괴저나 천공 의심되지 않으면 보존 치료

5) 혈관확장증 (vascular ectasia)

① 고령에서 반복적인 하부위장관 출혈의 가장 흔한 원인 ② 노화에 따른 퇴행성 병변 ③ 주로 맹장, 상행결장에 있고 다발성임 ④ 남녀비율은 비슷함	⑤ 50세 이상에서 호발 ⑥ 출혈은 전형적, 반복적이며 소량임 ⑦ 약 15%에서는 다량 출혈을 보임
--	---

4. 허혈성 장질환의 한약처방

- 혈액순환에 문제가 있는 질환으로 활혈거여하며 피를 잘 통하게 해줘야 함
- 활락효령단, 소복죽어탕, 격하죽어탕



활락효령단(活絡效靈丹)

- 구성: 당귀, 단삼, 유향, 몰약 10g
- 적용: 心腹疼痛에 因涼, 因熱, 氣鬱, 血鬱을 막론하고 효과가 있음
 - 內外瘡瘍과 心腹四肢疼痛을 치료 / 氣血凝滯로 인한 자에 奇效

☞ 대장 허혈증 호발 부위와 그 이유는?
12

☞ 다음 중 허혈성 대장염에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 17

- ① 고령에 흔하다.
- ② 호발 부위는 측부 순환이 발달하지 않은 hepatic flexure이다.
- ③ 허혈성 장 손상의 가장 흔한 형태이다.
- ④ 소혈관의 국소성 비폐쇄성 허혈로 인한 것이다.
- ⑤ 괴저나 천공이 의심되지 않으면 보존적 치료를 한다.

☞ 고령에 흔하며 허혈성 장 손상의 가장 흔한 형태이고 호발 부위는 splenic flexure 이며 소혈관의 국소적 비폐쇄성 허혈로 인한 것을 특징으로 하는 질병은?
18 19

- ① 과민성장증후군 (18)
- 장간막 정맥 혈전증 (MVT) (19)
- ② AMI
- ③ CMI
- ④ 대장허혈증(CI)
- ⑤ 혈관확장증

02

장폐색

1. 장폐쇄 - 일레우스(ileus)

특징	• 병적 상황으로 인해 위장관의 내용물이 하부 장관으로 운반되지 못하는 상태 • 모든 개복술 후 대장 운동 억제에 기인한 마비성 장폐쇄 발생 장폐쇄가 있으면 수술한 적 있는지 물어보기 • 72시간 지나도 장운동 회복 안 되면 마비성 장폐쇄로 취급
원인	① 소장: 유착, 탈장, 악성 종양 등이 80%이상 ② 대장: 대장암 60-80%, 염전 5-15%, 유착(수술 후 상처가 아물면서)은 드물

2. 장관폐쇄의 기전

기계적 폐쇄	비기계적 폐쇄	혈관성 허혈
장관 내강의 원인	마비성 장폐쇄	동맥의 혈전
내부 원인	경련성 장폐쇄	동맥의 색전
외부 원인	거대 결장	정맥의 혈전
	가성 폐쇄	저혈류량 증후군

3. 증상 - 4대 증상: 痛, 吐, 脹, 閉

- ① 복통: 간헐적絞痛(쥐어짜는 듯한 통증) / 상복부 또는 배꼽 주위에 발생
- 지속적 복통으로 변하면 교액이나 장 천공을 의심
- ② 구토: 담즙 함유 구토 또는 대변 냄새 나는 구토
- ③ 복부 팽만: 대장 폐쇄나 S상 결장 염전 시에 심함
- ④ 증상 시작 후 24시간 이내 탈수 심하면 교액 발생을 의심
- ⑤ 배변 정지

4. 진단

- ① 특징이 될 만한 병력 인지가 중요
- ② 개복수술 받은 적 있는 사람이 복통, 구역, 구토, 배변 정지를 보이면 먼저 장폐쇄를 의심
- ③ 단순복부촬영: 가스가 차 있는지 확인
- ④ 설사가 없으면서 복부산통 호소하는 환자가 X선 사진 상 가스나 액체로 가득 찬 장관 보이면 소장폐쇄로 진단

5. 치료목적: ① 복부팽만과 폐색 완화 ② 장벽 괴사 예방

6. 장폐쇄의 변증시차

- 치료원칙: 通腑散結
- 처방: 조각마인전, 활혈통기음

1) 부실열결(腑實熱結)

증상	- 腹部絞痛陣作, 休時如常, 腹軟壓痛, 或 觸知腫塊, 구토, 복창, 矢氣不通, 대변비결, 口乾苦 - 舌紅, 苔黃, 脈洪有力
병리	實熱內蘊(실열이 쌓임), 腑結不通 실증 + 열이 뭉쳐있음
치법	瀉熱通腑
처방	대승기탕 + 나복자, 감초

2) 한결장부(寒結腸腑)

증상	- 腹中突然絞痛(배가 아프면서 대변도 통하지 않음), 得熱稍緩, 大변불통, 手足厥逆 - 舌暗淡, 苔白潤, 脈弦緊
병리	寒邪直中, 凝滯腑氣
치법	溫寒通腑
처방	大黃附子湯(대황, 부자, 세신) +백작약, 후박, 감초

☞ 과거에 폐복 수술을 받은 일이 있는 사람이 복통, 구역, 구토, 배변정지를 보이는 경우 우선 이 질환을 의심해야 한다. 무엇인가? 03

☞ 장폐색의 4대 증상을 기하시오 08 12 13 14 15

☞ 장폐색의 4대 증상은? 17

- ① 복통 구토 복부팽만 배변정지
- ② 복통 복부팽만 장명 발열
- ③ 복통 구토 배변정지 발열
- ④ 복통 발열 소화불량 방귀
- ⑤ 복통 배변정지 장명 구토

☞ 개복수술을 한 적 있는 사람이 복통, 구역, 구토, 배변정지 증상을 보일 때 의심하는 질환은? 18 19

- ① 덩핑증후군
- ② 장폐색
- ③ 장계실증
- ④ 허혈성 대장염
- ⑤ 과민장증후군

☞ 장폐색은 腸腔이 硬塞不通하고 氣血의 운행이 不暢하여 (痛), (吐), (脹), (閉)의 4대 증상이 나타나므로, 한의학의 (腑實熱結), (寒結腸腑), (食滯內積), (血瘀腸腑)의 범주에 속한다. 치료원칙은 (通腑散結)하여 臟腑를 通暢시키는 것이다. 99

☞ 장폐색의 치법으로 옳은 것은? 17

- ① 통부산결 ② 활혈거어 ③ 청열해독
- ④ 온중산화 ⑤ 자음강화

3) 식체내적(食滯內積)

증상	복창복통, 胃脘脹痛, 拒按, 噯腐吞酸, 厭食嘔惡, 大便秘結, 舌苔垢膩, 脈滑
병리	腸腑食積, 傳導失常
치법	消導通腑
처방	소도승기탕

4) 혈어장부(血瘀腸腑)

증상	腹部疼痛較劇, 痛處不移, 推按, 或捫及腫塊, 구토빈번 대변비결, 舌質靑紫, 脈澀
병리	瘀血阻絡, 腸腑壅滯
치법	祛瘀通腑
처방	도인승기탕 + 홍화, 지실, 후박, 당귀, 우슬, 천궁

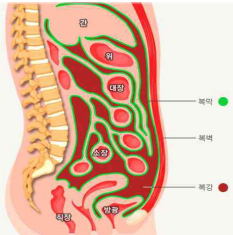
㉞ 오목가슴에 창통이 있고 신물이 나고 트림을 하며 속이 더부룩하다. 처방은?

19 탈기

- ① 대항부자탕 + 백작약, 후박, 감초
- ② 소도승기탕
- ③ 대승기탕 + 나복자, 감초
- ④ 소복승기탕
- ⑤ 도인승기탕 + 홍화, 지실, 후박, 당귀, 우슬, 천궁

03

복막염

특징	복강 내 여러 기관을 둘러싸고 있는 복막의 감염증		
원인	- 다음과 같은 병든 조직이 파괴되어 이물 및 병원균 확산 ① 충수염, 대장염, 게실염 ② 소화성 궤양, 췌장염, 담낭염 ③ 골반염 등		
증상	① 돌발적 복통: 지속적으로 심해짐 ② 옆드리거나 움직이면 몹시 아픔 ③ 가만히 누워 있기를 원함		④ 발열, 오한, 구토, 구역 ⑤ 호흡곤란, 저혈압, 급맥, 현기증 ⑥ 복수
분류	급성	급성 범발성 복막염	천공성 복막염, 속발성 복막염, 원발성 복막염, 비감염성 복막염
		급성 국한성 복막염	황색막하 농양, 간장하 농양, 골반 농양
	만성	담즙성 복막염	-
		결핵성 복막염	티프스성 복막염, 유착성 복막염
처방	① 복방인동등전 ② 加味正理湯: 충수염 천공성 복막염 ③ 托裏消毒飲 + 포공영 12g: 화농성 복막염 ④ 심육미유기음(유방암, 나력, 갑상선 질환) + 의이인 12g, 패장 8g, 시호, 산사 4g : 만성 복막염		

㉞ 과민성 장증후군은 () 환자 60%에서 나타난다. ()에 알맞은 것은? 17

- ① 만성위염 ② 우울증 ③ 식도역류
- ④ 구강궤양 ⑤ 비궤양성 소화불량

㉞ IBS 증상으로 복통, 변비, 설사, 복부팽만, 두통, 피로가 있는데, 이를 발생률 순서대로 쓰시오. 13

㉞ 과민성 장증후군 증상에서 빈도가 잦은 것부터 순서대로인 것은? 17

- ① 설사 변비 복통 복부팽만 두통 피로
- ② 복부팽만 변비 설사 복통 피로 두통
- ③ 피로 두통 복통 복부팽만 설사 변비
- ④ 변비 설사 복부팽만 두통 복통 피로
- ⑤ 복통 설사 피로 두통 변비 복부팽만

㉞ 과민성장증후군의 증상을 빈도가 높은 순으로 나열하시오. 18

- ① 설사 복통 변비 피로 두통 복부팽만
- ② 피로 설사 복부팽만 두통 복통 변비
- ③ 변비 설사 피로 복부팽만 두통 복통
- ④ 변비 설사 복부팽만 두통 복통 피로
- ⑤ 복통 설사 피로 두통 변비 복부팽만

04

과민성 장증후군 IBS

특징	① 기질적 병변 전혀 없음 ② 장의 비정상적 과민 상태 ③ 복통과 배변 상태의 변화(변비, 설사, 변비 설사의 반복) 등 다양한 증상이 3개월 이상 지속
빈도	① 성인의 1/3: 약간씩은 지니고 있음 ② 소화기 관련 외래 환자의 25-50%: 여성이 약간 많음 ③ 사춘기 후반에 발생, 평생 지속 ④ 가슴앓이(식도역류 = 조장증) 환자의 60% ⑤ 비궤양성 소화불량증의 30% ⑥ 다음 증상을 지닌 자가 자주 발생: 편두통, 불안, 우울증, 천식, 알레르기성 비염, 습진, 월경불순, 배뇨장애, 심계항진, 담도경련
증상	- 매우 다양한 증상을 보이며, 30% 환자만이 동일 증상을 나타냄 ① 증상 2-3 개월 지속 후 사라짐 ② 증상 빈도 : 복통(74%) > 설사(60%) > 피로(42%) > 두통(38%) > 변비(23%) > 복부 팽만 (22%)

병태	1) 장관의 운동 장애	정신적 자극이나 특정 음식에 의해 장이 과민반응을 일으켜 장 운동 리듬이 교란을 일으킴
	2) 내장 감각의 과민반응	장관 감각 수용체의 이상, 척수의 후각 신경세포의 흥분도 증가, 중추신경의 내장 감각 조절 이상 등으로 내장 감각 역치의 변화
	3) 정신 병태 생리	불안, 우울 등 정신증상이 있는 자는 증상이 강하게 나타남
	가벼운 스트레스 후 복통 / 식사 후 복통 / 설사와 변비 / 복부 팽만감 / 배변 후 잔변감	
진단법	1) 일반 소화기 질환과 비교할 때 다음 7가지 증상이 다르게 나타남 ① 밤에 무증세 ② 혈변 없음 ③ 경증 변비 ④ 야간 설사 없음 ⑤ 체중 감소 없음 ⑥ 발열 없음 ⑦ 초도 발생은 40대 이전	
	2) 다음과 같은 병리검사 상 이상이 없어야 함 : 배변의 WBC (-), 감상선가능 정상, 일반 화학 검사 모두 정상	
	3) 모든 위장 질환이 전혀 없어야 함	
	4) 장기간 관찰하여 어떤 음식에 증상이 유발하는지 발견해야 함	
주증상의 특징	1) 복통의 특징 ☞ IBS 복통의 특징에 대해 3가지 이상 기하시오. 06	① 식사 중, 식사 후: 좌하복통 ② 음식이 맹장 도달 시(6시간 후): 우하복통 ③ 장내 가스 이동 시 통증 위치 이동함 ④ 배변 후 통증 사라짐 ⑤ 좌하복통 가장 많고 좌상복통 가장 적음 ⑥ 복부 만지면 살살 아픔 ⑦ 스트레스와 긴장 시 복통 악화
	2) 변비의 특징	① 경증임: 배변 약간 힘든 정도 ② 변의 모양: 토끼 똥 또는 치약 모양(가늘다) ③ 변비 위주 환자의 80-90%가 복통을 겪함 ※ 변비 - 설사 교대되는 자 : 변비 증상 수일 지속되다가 설사 증상이 수일 지속됨
	3) 설사의 특징	① 설사량 적음: 기상 시 묽은 배변 ② 점액질 섞인 변 ③ 혈변은 없음 ④ 裏急後重 있음 ⑤ 설사 위주 환자는 복통 거의 없음
	4) 복부팽만의 특징 ☞ IBS의 증상 중 복부팽만의 특징적인 증상은? 12	① 하복부에 가스가 가득 찼다고 느낌 ② IBS 환자는 장벽이 예민하여 적은 가스에 의해서도 불쾌감과 복통을 느낌 ③ 대부분 IBS 환자의 장내 가스량은 정상임
IBS가 아닐 가능성이 많은 증상	① 노년에 발생 ② 점진적이며 지속적인 경과 ③ 증상에 의한 빈번한 자각 ④ 발열 ⑤ 심각한 체중감소 ⑥ 치질이나 치열이 아닌 직장출혈 ⑦ 지방변 ⑧ 탈수 ⑨ 긴 병정 후에 생긴 새로운 증상	
IBS 유발 음식	① 밀가루(60%) ② 옥수수, 우유(44%) ③ 치즈(39%) ④ 달걀(26%) ⑤ 감자(20%) ⑥ 쇠고기(16%) ⑦ 돈육(14%) ⑧ 닭고기(13%) ⑨ 생선(10%) ⑩ 커피(33%) ⑪ 홍차(25%) ⑫ 사과(12%) ⑬ 야채 썬, 꽃양배추, 오렌지(24%) ⑭ 양파, 밤, 초콜릿 (22%) ⑮ 기타: 해물, 딸기, 포도, 건포도, 찬 음식, 술, 적포도주	
IBS와 음식	☞ IBS 환자에게 권장되는 Low FODMAP에 대해 쓰시오 12 13 14 15 IBS 환자: low FODMAP 식단 권장 - 호주에서 개발 - 이 물질이 다수 함유된 음식은 소장과 대장에서 흡수되지 않고 미생물에 의해 발효되어 가스와 액체를 만들어 뱃속을 불편하게 함	
IBS와 비타민	by. 영국 셰필드대학연구진 ☞ IBS 증상 완화에 도움되는 비타민은? 12 13 14 15 : IBS환자 51명 중 82% 비타민 D 부족 → 비타민 D 섭취: 증상 완화에 도움	

☞ IBS 환자 51명 중 82%는 다음이 부족하며 보충하면 증상이 개선된다. 18 답) Vit D

☞ 과민성 대장 증후군과 일반 소화기 질환의 차이점 7가지를 쓰시오 08 12 14 15

☞ 과민성 장증후군의 진단법으로 옳지 않은 것은? 17

- ① 밤에 무증세 ② 체중감소 ③ 경증변비
④ 야간 설사 없음
⑤ 초도 발생은 40대 이전

☞ IBS에 의한 복통의 특징으로 옳은 것은? 11

- 가. 식사 중이나 후 좌하복통
나. 장내가스 이동 시 통증 위치 이동
다. 배변 후 복통이 사라짐.
라. 좌하복통이 가장 많고 좌상복통이 가장 적음
① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

☞ IBS 복통 증상으로 옳지 않은 것은? 17

- ① 식사 중, 후에 우하복통을 느낀다.
② 좌하복통이 가장 많고 좌상복통이 가장 적다.
③ 음식이 맹장에 도달 시 우하복통을 느낀다.
④ 장내 가스 이동 시 통증 위치가 이동함
⑤ 배변 시 통증이 사라진다.

☞ IBS의 복통에 대한 설명이다. 옳은 것은? 18 19

- ① 복부를 만지면 살살 아프다.
② 식중, 식후에는 우하복통이 발생한다.
③ 장내 가스가 이동해도 통증은 그대로임
④ 좌상복통이 가장 많고 좌하복통이 가장 적음
⑤ 배변 후에도 통증 사라지지 않음

☞ IBS 설사의 특징으로 옳은 것은? 11

- ① 기상 시 묽은 배변
② 혈변
③ 점액질이 섞인 변
④ 설사와 복통은 거의 같이 나타난다.

☞ IBS가 아닐 가능성이 높은 것은? 18

- ㄱ. 노년에 발병 ㄴ. 심각한 체중감소
ㄷ. 발열 ㄹ. 지방변
① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

☞ IBS를 유발하는 음식 중에서 가장 많은 것을 하나만 기하시오 05 07 08 09 12 14

☞ IBS 유발 최빈도 음식은? 17

- ① 옥수수 ② 치즈 ③ 밀가루 ④ 돼지고기
⑤ 커피

☞ 다음 중 IBS 환자에게 권장하는 low FODMAP이 아닌 것은? 17

- ① 발효당 ② 당알코올 ③ 이당류
④ 단당류 ⑤ 다당류

☞ 소장 내(작은창자)에서 흡수가 잘 되지 않는 짧은 사슬의 탄수화물인 FODMAP에 속하지 않는 것은? 18 19

IBS의 변증시치

IBS 변증시치 5가지를 한자로 쓰시오 02 09 11
IBS 변증시치 5가지와 각각의 처방을 기하시오 06 07

1) 간기승비(肝氣乘脾) = 간울비허 肝鬱脾虛

증상	- 억울 분노 시 복통 설사, 설사 후 복통 감소. 혹은 설사와 변비 교대 - 胸脇痞悶, 肋痛, 腸鳴, 噯氣, 矢氣頻, 善嘆息, 易怒, 苔薄, 脈弦
치법	抑肝扶脾
처방	통사요방 가미

2) 기체습조(氣滯濕阻)

IBS의 변증시치 중 기체습조의 증상, 치법, 처방에 대해 기하시오. 12 13 14 15

증상	- 大便稀爛(대변 무름), 便後後重 혹은 軟便과 粒狀便 혼재(무른 변과 동글한 변 혼재) - 심하면 복창통, 홍협비만, 트림이 잦음, 惡心不食(메스꺼움) / 苔白膩, 脈弦
치법	順氣行滯, 健脾除濕
처방	五磨飲子 + 胃苓湯 (오마음자 : 사마탕 + 지실)

3) 장위열결(腸胃熱結)

증상	- 복부 滿痛(배가 창만하면서 아픔), 甚則絞痛, 변비 혹은 便結如羊屎^{염소똥처럼 변이 뭉침} - 排便不爽, 面赤潮熱, 汗多心煩, 口乾欲飲 - 舌紅, 苔黃或黃燥(황태 또는 황태 끼면서 건조), 脈滑數
치법	泄熱清腸, 行氣通便
처방	마자인환

4) 비위허약(脾胃虛弱)

증상	음식불능, 則排便增加, 粘液便, 或不消化便, 腹滿氣少 혹은 腹部隱痛, 面色萎黃, 倦怠疲乏, 舌淡苔白, 脈細弱
치법	건비익위
처방	삼령백출산

5) 신양허쇠(腎陽虛衰)

증상	- 粘液樣泄瀉(점액과 같은 설사), 黎明에 小腹痛, 腸鳴而泄, 瀉後便安 - 或腹滿, 手足身冷, 面晄白, 腰膝酸痛, 舌淡白, 苔薄白, 脈沈細
치법	溫腎健脾, 固澀止瀉
처방	사신환 + 부자이중환

6) 한열협잡(寒熱挾雜)

증상	- 복통 혹은 장명, 설사. 粘膩(끈적끈적)한 변 또는 거품변 또는 설사와 변비 교대 - 답답하여 먹으려 하지 않음, 배를 따뜻하게 하면 좋아함 / 口舌紅, 苔膩, 脈弦滑
병리	腸胃不調, 寒熱挾雜
치법	調和腸胃, 寒熱并用
처방	烏梅丸 가감 (- 계지 + 백출·황련·복령·목향·백작약·감초)

7) 장도진후 腸道津虧

증상	- 완고한 변비, 3~4일에 1번 배변, 단단히 뭉쳐서 보기 힘들 - 자갈이나 염소똥 같음 - 어떤 환자는 좌하복에서 새끼줄 같은 덩어리 만져짐 - 少腹疼痛, 불면, 두통, 빈민, 手足汗
병리	肝鬱化熱灼津, 大腸失于濡潤.
치법	滋水清肝, 潤腸通便
처방	一貫煎(음액을 보함) - 구기자 + 백작약·玫瑰花

- ① Fermentable
- ② Polysaccharide
- ③ Monosaccharides
- ④ Disaccharides
- ⑤ Oligosaccharides

IBS 변증시치 중 간기승비의 증상, 치법, 처방에 대해 기하시오 05

大便稀爛, 便後後重, 혹은 軟便과 粒狀便 혼재, 심하면 腹脹痛, 胸脇痞滿, 噯氣頻繁, 惡心不食, 苔白膩, 脈弦일 때 변증명은? 17

- ① 간기승비
- ② 기체습조
- ③ 장위열결
- ④ 비위허약
- ⑤ 신양허쇠

대변희란, 변후후중, 연변과 미립변 혼재, 심하면 홍협비만, 오심불식 환자 처방은? 18

① 오마음자 가 위령탕

- ① 마자인환
- ① 통사요방
- ① 삼령백출산
- ① 사신환 가 부자이중환

IBS 환자이다. 복부가 팽진하며 아프고, 심하면 쥐어짜듯 하다. 변비가 있거나 혹은 변이 염소똥처럼 뭉쳐져 나온다. 얼굴이 붉고 조열하다. 설홍 태황초 맥활삭일 때, 처방은? 19탈기

- ① 통사요방 + 복령, 지각, 오약, 백편두, 목과, 의이인, 감초
- ② 오마음자 + 위령탕
- ③ 마자인환
- ④ 사신환 합 부자이중환
- ⑤ 삼령백출산

대변이 묽고 설사하며 가슴이 답답, 더부룩하며 포만감, 힘이 없을 때 처방은? 19 탈기

- ① 역간부비
- ② 활혈화어
- ③ 청열해독
- ④ 건비익위
- ⑤ 온신건비, 고삼지사

IBS로 배변 후 완화됨. 수족신냉 면백광 요슬산연 등의 증상이 있음. 알맞은 처방은? 18

- ① 통사요방 + 복령 지각 오약 백편두 목과 의이인
- ② 오마음자 + 위령탕
- ③ 마자인환
- ④ 삼령백출산
- ⑤ 사신환 + 부자이중환

05	흡수장애증후군
정의	음식물을 소화 흡수하는 과정에서 어느 한 부분이라도 문제가 있어 발생하는 증상
분류	① 소화 효소에 의해 분해가 잘 이루어지지 않는 흡수장애 ② 분해된 영양소를 장세포에서 흡수하지 못하는 흡수장애
원인	① 장관 내에 이상이 발생한 경우 ② 담관이 막혀서 담즙이 나오지 못하는 경우 ③ 만성췌장염으로 췌장 소화액 분비가 부족한 경우 ④ 소장 내 세균 증식, 세균이 소화효소를 분해하는 경우 ⑤ 소장 절제 : 소장이 100cm 이내 남은 경우 ⑥ 소장 용모가 파괴된 경우 ⑦ 감염 ⑧ 점막 세포의 이상 ⑨ 림프관 폐쇄 ⑩ 방사선 치료
증상	- 설사, 더부룩함, 복통, 다량의 변, 근육 위축 - 담즙 대사 장애; 지방변 - 철분, 엽산, 비타민 B12 부족; 빈혈 - 비타민 A, B1 결핍; 내분비 질환, 말초신경증 - 비타민 K 부족; 출혈 - 단백질 흡수 장애; 부종 - 피부염, 각질층이 많이 생김 - 골다공증 / 강직성 경련
진단	① 혈액 검사: 전해질 수치, 콜레스테롤 수치, 알부민 수치, 프로트롬빈 시간 측정 ② 대변 검사: 지방변 ③ 소화관 X-ray 검사 ④ 소장의 점막 검사 ⑤ Xylose 흡수 검사 ⑥ secretin-test 검사
경과	① 각종 비타민 부족으로 야맹증, 피하출혈 ② 피부가 닭살처럼 변함 ③ 빈혈이 심하여 창백해짐 ④ 골연화증; 뼈가 휘고 잘 부러짐

☎ 흡수장애증후군의 변증시치

- ① 비허습성 ② 식체위장 ③ 비위허약 ④ 비신양허
- 기본 병리: 運化失常 / 한의학의 설사, 허로의 범주에 속함
- .

1) 비허습성 脾虛濕盛

증상	肢倦乏力, 脘腹脹悶, 納差少食, 大便時稀時滯(대변이 묽음), 腹痛隱隱, 舌淡, 苔白膩, 脈沈
병리	脾胃虛弱, 濕濁困中
치법	健脾和中, 化濕理氣
처방	향사육군자탕 + 창출, 맥아

2) 식체위장 食滯胃腸

증상	복통, 설사, 大便臭穢, 복창, 矢氣, 噯氣酸腐, 不欲飲食, 泛泛欲嘔, 舌淡紅, 苔垢濁, 脈滑數
병리	食滯不化, 脾運失調
치법	消食導滯
처방	보화환

3) 비위허약 脾胃虛弱

증상	- 泄瀉日久(설사 오래함), 反復發作, 大便如油, 神疲乏力, 消瘦(몸이 마르고 수척함) - 面色萎黃, 心悸頭暈, 胸悶納呆 / 舌淡, 苔薄白, 脈沈弱
병리	脾胃虛弱, 運化無權
치법	益氣健脾, 升清止瀉
처방	삼령백출산

4) 비신양허 脾腎陽虛

증상	- 泄瀉日久, 怠惰乏力, 精神不振, 頭暈耳鳴, 腰脊泛痛, 消瘦 - 舌胖淡, 苔白 或 白滑. 脈沈細無力 或 沈遲
병리	腎陽虛衰, 火不煥土
치법	溫腎運脾, 澀腸止瀉
처방	위관전 + 구기자

06	단장증후군 Short Bowel Syndrome	
정의	외과적 수술로 소장을 본래 길이의 절반 이상 제거했을 때 발생하는 소화흡수불량증	
원인	염증성 장질환이나 소장의 종양, 장폐쇄, 누공, 게실염 등으로 인한 장 절제 수술 +) 선천적으로 장이 짧게 태어나 발생하기도 함	
주요 증상	심한 복통, 설사, 지방변, 유당불내증, 탈수, 체중감소, 무기력, 피로, 영양결핍	
	십이지장 절제	증상 덜함
	공장 절제	흡수불량 두드러짐
	회장 절제	담즙산염, 지방산 흡수 불량 → 대장의 수분과 전해질 흡수작용이 방해받음 → 설사

☞ 흡수장애단장증후군의 변증시치

- 급성기: ① 寒濕暴瀉 ② 陰虛動風 ③ 亡陰亡陽 / 만성기: ① 脾腎陽虛 ② 脾虛瘀阻 ③ 氣虛血滯

1) 한습독사

증상	- 暴注下瀉, 혹은 完穀不化, 복통, 강명, 面色無華(얼굴에 화색이 없음), 형체소수 - 形體消瘦, 脘悶食少. 舌淡苔白膩, 脈濡.
병리	中陽虛損, 脾虛失運, 寒濕困脾
치법	溫運中陽, 健脾散寒, 分利水濕
처방	理中湯 合 胃苓湯 - 택사·육계 + 백편두·의이인

2) 음허동풍

증상	- 泄瀉不止, 急激消瘦, 皮膚乾枯, 兩眼凹陷, 短氣乏力, 身熱綿綿, 口燥咽乾, 筋脈拘攣 - 혹은 四肢抽搐 / 舌紅絳, 少苔欠津, 脈細數
병리	氣陰虧耗, 虛風內動
치법	益氣滋陰, 柔肝熄風
처방	獨蔘湯 合 大定風珠

3) 망음망양

증상	- 泄瀉量少, 혹은 소량의 점액 유출. 얼굴창백, 肢冷汗出, 정신혼미 - 氣少息微, 脈微欲絕 혹은 不應指, 無尿, 혈압하강
병리	陰損及陽, 液竭氣脫
치법	益氣補陰, 回陽固脫
처방	參附湯 合 生脈散 + 앵속각

4) 비신양허

증상	大便時澇時泄, 납매, 면색위황, 형한지냉, 신피핍력, 사지불온, 복창, 복통, 설담태백, 맥세약
병리	脾腎陽虛, 火不暖土, 運化無權
치법	壯火燠土, 運脾滲濕
처방	參苓白朮散 合 實脾飲

5) 비허어조

증상	- 泄瀉日久, 瀉便不爽, 복창, 복통, 痛處不移. 腹有結塊, 按之痛甚 / 수술 부위 통증 심함 - 신피권태, 납매, 面色晦滯 / 舌暗紅 혹은 瘀斑, 脈弦澁
병리	脾虛失運, 瘀阻腸絡
치법	益氣運脾, 化瘀理滯
처방	五味異功散 合 少腹逐瘀湯

6) 기허혈일

증상	- 설사 혹은 便澇, 혹은 변혈 혹은 요혈, 皮膚紫斑(피부의 자반증), 혹은 齒衄, 鼻衄 - 얼굴창백, 神疲乏力, 少氣懶言, 納呆形瘦 / 舌淡, 苔白, 脈濡細
병리	脾虛氣弱, 血失統攝
치법	益氣攝血, 健脾養血
처방	歸脾湯 비불통혈에 쓰는 대표적인 처방

07

장관의 과다가스

- Too much gas에서 연유한다고 생각하는 증상
: ① 가스가 찬다 ② 배에서 소리가 난다. (장명음) ③ 배가 아프다. ④ 트림을 자주 한다. ⑤ 방귀가 잦다
- 기질적 질환은 드물
- 가스가 찬다고 호소하는 환자들의 장관 내 가스량은 정상인과 큰 차이가 없음
- 치료: 증상 개선에 주안점을 둠

1. 장관 내 가스의 출처

- ① 공기의 연하: 한번씩嚥下할 때마 다 2~5mL의 공기를 삼킴
- 삼킨 공기는
 - └ 대부분: 트림으로 배출
 - └ 일부분: 위 점막을 통해 혈액으로 흡수
- ② 장관 내에서의 가스 생성: 이산화탄소, 질소, 메탄, 수소 등이 생성됨
- ③ 혈액으로부터의 확산: 장관 내와 점막 혈액 사이의 가스 이동은 분압의 차이에 의해 결정됨

2. 임상적 가스 증후군

- ① 잦은 트림 ② 복부팽만감 ③ 간, 비 굴곡 부위 증후군 ④ 잦은 방귀 ⑤ 가스-블로우트 증후군
- ⑥ 대장 내 가스 폭발 ⑦ 탄수화물 흡수 장애군

1) 잦은 트림

개요	① 트림은 정상적인 반사작용이며 위장관의 기능이상인 아님 ② 모든 위내 공기는 연하된 공기임
수반 증상	복부 팽만, 헛배부름, 복통
원인	① 빨리 먹는 습관: 공기 삼키는 양이 많아짐 ② 껌, 담배, 탄산음료 ③ 정신적 긴장: 공기 연하증 (만성트림의 원인) ④ 흥부질환, 담낭염, 소화성 궤양, 역류성 식도염

2) 복부 팽만감

- 원인: ① 장관 벽의 확장에 대한 감수성 증가 ② 장관 운동의 이상
- Too much gas는 IBS의 변형
- 가스의 양과 성분: 정상인과 차이가 없음 (가스량과 복부팽만감은 관련X)
- 가스의 양과 증상과는 무관

3) 간, 비 굴곡 부위 증후군 Hepatic and splenic flexure syndrome - 기능적 질환

- 우상복부: 간 굴곡 부위 / 좌상복부: 비 굴곡 부위
- 대장의 굴곡 부위에 가스가 고여 대장이 확장되어 상복부 통증이 일어나리라 생각되는 증후군
- IBS의 일종임
- 증상: ① 상복부 통증, 간혹 가슴 / 어깨 / 목으로 방산 ② 변비, 정서불안 ③ 배변/관장 후 통증 소실
- 치료: 변비 치료가 치료의 관건

4) 잦은 방귀

- ① 정상적인 빈도와 양: 하루 6~20회, 하루 500~1500mL / 정상인과 큰 차이는 없음
- ② 방귀의 근원: 삼켜진 공기와 소화되지 않은 탄수화물의 세균성 발효 (기질적 질환이 있는 경우 드물)
- ③ 방귀의 구성성분: 식이 내 탄수화물의 양과 대장 세균총에 의해 결정됨
 - 면역력을 높이기 위해서는 음양의 균형이 잘 맞아야 함
 - 수소, 이산화탄소, 메탄이 주요 성분임
 - 유당, 과당, 콩, 복합전분과 섬유소, 밀, 귀리, 옥수수, 감자 등 복합 탄수화물 → 가스 증가시킴

5) 가스-블로우트 증후군

정의	역류성 식도염으로 위저부 추벽 성형술을 시행 받은 후 음식이나 공기가 위로 들어가는 것만 가능하고 역으로 트림이나 구토가 불가능한 경우
증상	① 위의 신전으로 복부팽만, 복통, 과도한 방귀 (수술 후 수개월간 25~50%) ② 시간이 지나면서 서서히 호전됨

☞ 만성 트림을 유발하는 원인을 고르시오 17

- ① 정신적 긴장: 공기연하증
- ② 빨리 먹는 습관
- ③ 껌 담배 탄산음료
- ④ 역류성 식도염
- ⑤ 소화성 궤양

☞ 만성트림의 원인은? 18

- ① 정신적 긴장
- ② 빨리 먹는 습관
- ③ 껌, 담배, 탄산음료
- ④ 담낭염
- ⑤ 역류성 식도염

☞ 복부팽만감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 19 탈기

- ① 장관벽의 확장에 따른 감수성 증가 때문
- ② 장관운동이상으로 인한다.
- ③ IBS의 변형이다.
- ④ 가스의 양과 성분은 정상인과 차이가 없다.
- ⑤ 가스의 양은 증상과 밀접한 관계가 있다.

☞ 역류성 식도염 수술을 받고, 섭취 등 위로 들어가는 것만 가능하고, 역으로 트림구토는 불가능하다. 해당하는 것? 18

- ① 축소위
- ② 조기담핑증후군
- ③ 가스-블로우트 증후군
- ④ 비굴곡부위 증후군
- ⑤ 맹관증후군

6) 대장 내 가스 폭발

- ① 대장 내 수소와 메탄의 성분이 각각 44%, 30%까지 되면 폭발 위험성 있음
- ② 특히 mannitol로 장을 세정하면 수소 농도가 높아져 직장 S상 내시경으로 용종 절제술을 할 때 장내 가스 폭발함
- ③ 장내 가스 폭발하면 대장이 심하게 손상되고 천공되기도 함

7) 탄수화물 흡수장애군

- 소장에서 탄수화물의 흡수에 장애가 발생하면 대장에서 세균의 발효에 의해 가스가 발생
- 증상: 복통, 방귀, 고창(배가 뽕뽕하게 가스가 참) 주된 증상
- 탄수화물
 - ① 유당, sorbitol, 과당, 전분
 - ② 과당: 과일, 양파, 아스파라거스, 밀에도 존재
 - ③ 콩에 많은 탄수화물: stachyose, raffinose, verbascose

☞ 복부 가스 증후군의 진단

병력	① 식이습관: 콩, 사과, 자두, 건포도, 전분, sorbitol, 과당 등의 과다 섭취 ② 약물: 마약, 항콜린제, 칼슘차단제 ③ 수술 기왕력: 맹관(blind loop)의 형성 여부 복부수술 여부 ④ 정서 장애: 불안, 우울 ⑤ 전신 질환: 당뇨병, 갑상선기능저하증, 공피증, 근육이영양증(muscular dystrophy) • 갑상선기능저하증: 소화장애를 일으키는 경우 다, 음허증에 해당, 보하면서 온한 약들을 이용하여 치료해야 함
진찰소견	복부팽만 시 복수, 종괴, 복막염 등과 감별

☞ 가스 증후군의 치료

① 껌, 캔디 씹는 것 금함 ② 금연 ③ 구강 청결 ④ 불안증 치료	⑤ 탄수화물 흡수 장애: 콩, 과일, 전분 섭취 줄임 ⑥ 유당 흡수 장애: 우유 섭취 금함 ⑦ 맹관증후군에 의한 장내 세균증식: 항생제 투여 ⑧ 장운동 장애: 섬유소나 삼투성 완하제 투여
--	---

☞ 가스 증후군의 한약처방

: ① 배기음 ② 배기탕 ③ 장울오약탕 ④ 반충산 ⑤ 하사심탕

🔑 배기음(排氣飲) • 구성: 향부자, 오약, 택사 8g, 곽향, 진피, 지각 6g, 후박 4g, 목향 3g • 설명: 性溫, 舒氣和中 • 적용: 治氣逆食滯脹痛 / 위장의 gas를 배출하는 힘이 강함	☞ 排氣飲의 구성 약물에 대해 기하시오. 05
🔑 배기탕(排氣湯) • 구성: 백작약 12g, 지실, 목향 6g, 후박, 계내금 5g, 감초 4g, 침향(後下) 1.2g • 적용: 비(간)굴곡증후군 치료	
🔑 장울오약탕(腸鬱烏藥湯) - 오약탕 가감 • 구성: 목향 6g, 오약, 향부자, 현호색, 진피, 후박 4g, 사인 2.4g, 울금, 감초 2g • 설명: 理氣解鬱止痛 / 오약탕: 오약, 향부자, 당귀, 목향, 자감초 • 적용: 治婦女小腹疼痛, 비(간)굴곡증후군 치료	

☞ 다음에서 설명하는 가스 증후군은 무엇인가? 07 09

mannitol로 장을 세정하면 수소 농도가 높아져 직장 S상 내시경으로 용종 절제술을 할 때 발생한다.

- ① 가스 블로트 증후군
- ② 대장 내 가스폭발
- ③ 간, 비굴곡 부위 증후군
- ④ 탄수화물 흡수 장애군
- ⑤ 복부 팽만감

Ⅶ. 피로

01

피로

- 1) physiologic fatigue: 육체적 과로 후 일시적으로 나타났다가 휴식하면 회복되는 정상적인 생리 반응
- 2) acute fatigue: 발병 후 6개월 이내의 피로
- 3) chronic fatigue: 발병 후 6개월 이후까지 지속하는 피로
- 4) 피로는 비특이적 증상이며 환자의 주관적 호소임
- 5) 전문의 찾는 환자의 1-3%

02

피로가 인체에 미치는 영향

생화학적, 생리학적 변화	• 근수축력 저하와 회복 지연, 근섬유 괴사, 호흡수 증가, 맥박 빨라짐 • 혈압 오름, 맥압 커짐
작업 또는 생산능력 저하	정신적 피로 축적: 頭重 ^{머리가 멍해짐} , 上氣, 심란, 집중력 저하, 불안초조
사고, 판단능력 저하	피로 축적 → 뇌 기능 저하, 진술 판단 능력 장애, 감정조절 장애(善怒, 불안초조, 욕구불만/화를 잘 냄)

☞ 피로가 인체에 미치는 영향을 3가지 측면에서 기술하시오 07

03

피로의 원인

기질적 원인

- | | |
|--|---|
| ① 내분비질환: 甲亢, 甲低, DM
② 심장질환: 울혈성 심부전, 신경성 저혈압증
③ 감염: 심내막증, 간염
- 급성 간염 시 간수치가 급증하여 극심한 피로를 느끼게 됨
④ 호흡기계질환: COPD, Sleep apnea
- 호흡이 제대로 이루어지지 않으면 장부 모든 기능에 영향 | ⑤ 빈혈
⑥ 관절염 관련 질환
⑦ 알코올중독
⑧ 약물: 진정제, 항히스타민제, 항고혈압제, 항우울제, 수면제 |
|--|---|

정신 사회적 원인

- ① 우울증: 가장 흔함 ② 불안증 ③ 스트레스 ④ 적응 장애 ⑤ 알코올 중독

☞ 다음 중 피로를 유발하는 약물은? 18
가. 진정제 나. 항우울제
다. 수면제 라. 항고혈압제

- ① 가나다
② 가다
③ 나라
④ 라
⑤ 가나다라

☞ 피로의 정신사회적 원인으로 가장 흔한 것은? 17 18 19

- ① 불안증
② 스트레스
③ 적응장애
④ 우울증
⑤ 알코올 중독

☞ 다음 중 신체적 피로는? 18 19

- ① 골치가 멍하고 얼굴이 화끈하다.
② 가슴이 답답하다.
③ 신경질이 난다.
④ 졸리다.
⑤ 일이 집중이 되지 않는다.

☞ 신경감각성 피로에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? 17

- ① 눈이 피로하여 보이지 않는다.
② 입맛이 변해 냄새가 싫어진다.
③ 귀가 잘 안들리며 귀에서 왕왕거린다.
④ 눈꺼풀이나 손에 경련이 온다
⑤ 골치가 멍하며 얼굴이 화끈거린다.

☞ 다음 중 신경감각적 피로는? 18

- ① 얼굴이 화끈하고 머리가 멍하다.
② 졸리다.
③ 정신이 오락가락한다.
④ 입맛이 변하며 냄새가 싫어진다.
⑤ 머리가 무겁다.

04

피로의 임상양상

신체적 피로	① 머리가 무겁다 ② 전신이 노곤하다 ③ 어깨가 아프다 ④ 다리가 노곤하다 ⑤ 하품이 난다	⑥ 머리가 아프다 ⑦ 몸이 어딘가 아프며 노곤하다 ⑧ 가슴이 답답하다 ⑨ 침이 마른다 ⑩ 식은 땀이 난다
정신적 피로	① 골치가 멍하며 얼굴이 화끈거린다 ② 남하고 말하는 것이 귀찮다 ③ 졸리다 ④ 일에 집중이 되지 않는다 ⑤ 간단한 것이 생각나지 않는다	⑥ 생각하는 것이 귀찮다 ⑦ 신경질이 난다 ⑧ 정신이 오락가락한다 ⑨ 일하는 것이 걱정이 된다 ⑩ 하는 일에 자신이 없다
신경감각적 피로	① 눈이 피로하여 잘 보이지 않는다 ② 동작이 어색하며 잘 틀린다 ③ 입맛이 변하여 냄새가 싫어진다 ④ 눈꺼풀이나 손에 경련이 온다 ⑤ 귀가 잘 안들리며 귀에서 왕왕거린다	⑥ 눈이 뻑뻑하다 ⑦ 다리가 흔들린다 ⑧ 어지럽다 ⑨ 손발이 떨린다 ⑩ 가만히 있기가 힘들다

05

피로의 진단

Duration	① 단기간: 급성의 기질적 질환(출혈, 심폐질환) ② 중등 기간: 만성질환(암, 결핵), 당뇨병, 내분비학적 변화 ③ 장기간: 정서이상, 적응장애
Onset	갑자기 또는 천천히 생겼는가?
Periodicity	① 지속적 피로: 기질적 질환 ② 환경이 기본에 좌우되면: 정신적 원인
하루 중 피로가 가장 심한 시간	기상한 다음 시간이 지나면서 오히려 피로가 증가하면 기질적 질환

06 만성피로를 호소하는 환자의 유형

- ① 피로의 원인이 어떤 신체적 질환에 의한 것이 아닌가 걱정하는 환자
- ② 우울증으로 대표되는 증상으로 만성피로를 호소하는 환자
- ③ 불안이나 스트레스의 신체화 증상으로서 만성피로를 호소하는 환자

07 만성피로증후군(CFS)과 원발성 만성피로의 구별

- 피로가 6개월 이상 지속되거나 재발한 경우, CFS와 원발성 만성피로로 구분함
- 피로의 정도나 증상이 CFS의 진단 기준에 일치하지 않으면 원발성 만성피로로 진단
- CFS란?: 임상적으로 생활 활동에 따라서 심해지는 피로감, 신경계의 증상 및 인플루엔자 감염과 같은 증상들을 특징으로 하는 증후군

08 만성피로증후군(CFS)의 진단기준

- 1) 6개월 이상 지속되는 피로로 인하여 활동력이 적어도 50%의 감소를 가져온 경우
- 2) 다른 진단의 가능성이 배제된 경우: 검사실 소견 이상 없음 혈액검사, x-ray 등
- 3) 아래의 증상 중 6가지 이상을 갖고 있는 경우

① 미열	⑥ 활동 후 지속되는 피로(운동 후 불쾌감)
② 인후통	⑦ 두통
③ 림프절 종창 또는 압통(경부, 액와부)	⑧ 유주성 관절통
④ 근무력	⑨ 신경정신계 증상(건망, 우울, 감정예민, 변덕, 집중력 저하)
⑤ 근육통	⑩ 수면 장애

09 만성피로증후군

원인	① 불명 ② 면역기능 이상 ③ 뇌하수체, 시상하부의 이상 ④ 신경전달물질의 이상 ⑤ 뇌의 관류 이상
합병증	① 우울증 ② 사회 적응 곤란
예후	수개월 수년 지나면서 개선되나 그동안 지치고 허탈에 빠짐
일반요법	① 적당한 운동 ② 스트레스 회피 ③ 균형식이

10 피로의 한의학적 치료

범주	虛勞, 勞倦傷
사상체질	① 소음인 - 보중익기탕, 십전대보탕 ② 소양인 - 형방지황탕, 육미지황탕, 십이미지황탕 ③ 태음인 - 조위승청탕, 태음조위탕
경험방	귀비익기탕, 하수오탕, 쌍화탕, 생간건비탕 + 황기, 반하백출천마탕

1. 소음인 처방

🔑 소음인 보중익기탕(少陰人 補中益氣湯) • 구성: 인삼, 황기 12g, 백출, 당귀, 진피, 감초 4g, 곽향, 소엽 2g, 생강 6g, 대추 4g • 설명: 보중익기탕에 준함 • 적용: 위장 기능이 약하고 위 부위의 압통이 심하지 않으며 무력 유연한 경우
🔑 소음인 십전대보탕 • 구성: 인삼·황기·백출·당귀·백작약·천궁·진피·자감초·백하수오·관계 각 1돈, 생강 3쪽, 대추 2개 • 설명: 氣血俱虛, 自汗盜汗, 全身倦怠, 久病後虛損 • 적용: 治虛勞

2. 소양인 처방

🔑 형방지황탕(荊防地黃湯) • 구성: 숙지황, 산수유, 복령, 택사 8g, 차전자, 강활, 독활, 형개, 방풍 4g • 설명: 소양인의 肝腎虛證으로 肩臂痛, 腰膝冷痛, 근육통과 피로가 심한 경우 + 위장이 튼튼한 청장년에 효과 빠름

☺ 만성 피로증후군의 진단 기준을 쓰시오 08

☺ 만성피로증후군의 10개 증상을 서술하시오. 12 13 14 15 17

☺ 소음인, 소양인, 태음인의 피로에 쓸 수 있는 처방을 한가지씩 쓰시오 09

☺ 소음인 보중익기탕 처방을 쓰시오 08

🔑 육미지황탕

- 구성: 숙지황 4돈, 구기자·산수유 각 2돈, 택사·목단피·백복령 각 1.5돈
- 설명: 補腎補陰, 填精定志

🔑 십이미지황탕 - 육미지황탕 + 소양인 보음약

- 구성: 숙지황 4돈, 산수유 2돈, 복령·택사 각 1.5돈, 목단피·지골피·현삼·구기자·복분자·차전자·형개·방풍 각 1돈
- 설명: 補腎升清

3. 태음인 처방

🔑 조위승청탕(調胃升清湯)

- 구성: 의이인, 건울 12g, 나복자 6g, 마황, 길경, 오미자, 석창포, 원지, 맥문동, 천문동, 산조인(炒), 용안육 4g
- 설명: 수험생(+ 천마, 고본)
- 적용: 태음인이 식욕이 좋고 피로와 嗜眠을 호소하는 경우

🔑 태음조위탕

- 구성: 건울·의이인 각 3돈, 나복자 2돈, 오미자·맥문동·석창포·길경·마황 각 1돈
- 설명: 태음인 虛證의 대표 처방

☺ 태음인으로 식욕이 좋고 피로와 嗜眠을 호소하는 경우에 사용할 수 있는 사상 처방에 대해 기하시오 05

4. 경험방

🔑 귀비익기탕(歸脾益氣湯)

- 구성: 백출, 진피, 당귀 6g, 인삼, 황기(蜜炙), 백복령, 용안육, 산조인(炒), 향부자, 죽여, 자감초 4g, 맥문동, 방풍, 원지, 백두구, 목향, 신곡(炒) 3g, 승마(酒洗), 시호(酒洗) 2g, 황련 1g, 생강 6g, 대추 4g
- 적용: 治低血壓, 식욕부진, 心悸, 소화불량, 便軟或秘, 淺眠

🔑 하수오탕(何首烏湯)

- 구성: 하수오 20, 황기, 당귀, 백작약 8g, 구기자 6g, 천궁 4g, 소엽, 감초 3g, 생강 6g, 대추 4g
- 설명: 治疲勞

🔑 쌍화탕(雙和湯)

- 구성: 백작약 10g, 숙지황, 황기, 당귀, 천궁 4g, 계피, 감초 4g, 생강 6g, 대추 4g = 소건중탕 + 사물탕
- 설명: 補血調表
- 적용: 治心力俱勞, 氣血皆傷, 或房勞後勞役, 或勞役後犯房, 及大病後虛勞, 氣乏自汗

🔑 생간건비탕(生肝健脾湯)

- 구성: 인진 16g, 택사 10g, 산사육, 맥아 8g, 창출, 백출, 저령, 적복령, 후박, 진피, 나복자 4g, 사인, 신곡, 청피, 초롱담 3g, 목향, 반하, 대복피, 삼릉, 봉출, 감초 2g, 생강 6g
- 적용: 治急慢性肝炎 / 위장병에 肝氣鬱結이 있는 경우

🔑 반하백출천마탕(半夏白朮天麻湯)

- 구성: 반하(製), 진피, 맥아(炒) 6g, 백출, 신곡(炒) 4g, 창출, 인삼, 황기, 천마, 백복령, 택사 2g, 건강 1.2g, 황백 0.8g, 생강 10g
- 설명: 기허, 노인(人蔘爲君)
- 적용: 治脾胃虛弱, 痰厥頭痛 / 허약성 빈혈성 痰多, 頭目眩暈 / 천기가 나쁘면 두통이 나는 경우 - 금기) 血壓過高者, 忌: 고혈압자 금기 / 陰血虛眩暈者, 忌: 음허한 사람 금기

11

用藥三法

- 목적: ① 처방 선택의 용이성 ② 치료 효과 제고 ③ 부작용 최소화

定病用藥	① 定病名: 병명을 정해서 약을 쓰는 것 (= 양진항치 / 양방으로 진단하여 한방으로 치료) ② 定病證: 병증을 정해서 약을 쓰는 것 - 풍한, 음허증/ 반하사심탕증, 소시호탕증, 계지호탕증 등의 이름으로
體質用藥	① 四象體質 ② 기타 체질
辨證用藥	① 臟腑辨證 ② 六經辨證 ③ 衛氣營血辨證